

Bunga Rampai

KEAMANAN PASIEN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Perspektif Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi



Badriah • Sarwoko • Nima Eka Nur Rahmania
Patria Asda • Asih Minarningtyas • Yahmin Setiawan

Editor : Dr. Irma Seriana, SST., M.Keb.

BUNGA RAMPAI
KEAMANAN PASIEN DAN KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN: PERSPEKTIF KEBIDANAN,
KEPERAWATAN, FARMASI, DAN GIZI

Penulis:

Badriah, SST., MPH.

Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

Nima Eka Nur Rahmania, S.KM., M.KKK.

Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H.

Ns. Asih Minarningtyas, M.Kep.

Dr. Yahmin Setiawan, MARS.

Editor:

Dr. Irma Seriana, SST., M.Keb.

Bunga Rampai Keamanan Pasien dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Perspektif Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi

Penulis:

Badriah, SST., MPH.

Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

Nima Eka Nur Rahmania, S.KM., M.KKK.

Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H.

Ns. Asih Minarningtyas, M.Kep.

Dr. Yahmin Setiawan, MARS.

Editor:

Dr. Irma Seriana, SST., M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-41-7

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Bunga rampai berjudul *Keamanan Pasien dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Perspektif Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi* ini disusun sebagai upaya memperkaya khazanah pengetahuan dan praktik keselamatan pasien (patient safety) serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas layanan. Keselamatan pasien bukan sekadar pemenuhan regulasi atau standar akreditasi, melainkan fondasi etis-profesional yang harus hadir dalam setiap keputusan klinis, proses asuhan, dan tata kelola layanan. Karena itu, buku ini menghadirkan sudut pandang lintas profesi—bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi—agar pembaca memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana mutu dan keselamatan dibangun melalui kolaborasi, sistem yang kuat, serta budaya kerja yang saling mendukung.

Secara sistematis, buku ini diawali dengan pembahasan **standar keselamatan pasien di fasilitas kesehatan**, termasuk sasaran keselamatan pasien dan implementasi enam sasaran keselamatan pasien sebagai rujukan operasional di lapangan (Chapter 1). Selanjutnya, kontribusi **keperawatan** ditonjolkan melalui penguatan **quality improvement** serta mekanisme **patient safety incident reporting**—mulai dari konsep dasar, peran perawat, faktor yang memengaruhi pelaporan, strategi peningkatan kepatuhan, hingga praktik baik dan studi kasus (Chapter 2). Pembaca kemudian diajak memahami pilar penting lain dalam keselamatan pasien, yakni **pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial** serta sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan, termasuk rantai penularan, faktor risiko, audit PPI, dan tantangan implementasi di Indonesia (Chapter 3). Rangkaian ini menegaskan bahwa keselamatan pasien lahir dari sinergi standar, perbaikan berkelanjutan, dan pengendalian risiko klinis-lingkungan.

Pada bagian berikutnya, buku ini menekankan aspek yang kerap menentukan keberhasilan implementasi keselamatan pasien: **komunikasi efektif interprofesi** melalui teknik **SBAR** dan pendekatan **TeamSTEPPS** untuk memperkuat kolaborasi tim (Chapter 4). Dimensi etik dan hukum diperjelas lewat kajian **etika, legalitas, dan informed consent** dalam pelayanan kesehatan modern, sehingga praktik keselamatan pasien tetap berpijak pada penghormatan terhadap hak pasien dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (Chapter 5). Sebagai penguat, pembahasan ditutup dengan strategi **penguatan budaya keselamatan pasien** pada perawat, bidan, apoteker, dan ahli gizi—karena budaya yang baik adalah “mesin” yang menjaga standar, komunikasi, kepatuhan, serta pembelajaran dari insiden berjalan konsisten (Chapter 6). Akhirnya, kami berharap buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, klinisi, manajer layanan, serta pemangku kepentingan untuk memperkuat praktik berbasis mutu dan keselamatan—bukan hanya untuk mencegah kejadian tidak diharapkan, tetapi juga untuk membangun layanan kesehatan yang lebih aman, bermartabat, dan berpusat pada pasien.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

CHAPTER 1 STANDAR KESELAMATAN PASIEN DIFASILITAS KESEHATAN 1

Badriah, SST., MPH.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit.....	2
C. Sasaran Keselamatan Pasien	6
D. Enam sasaran keselamatan pasien	7
E. Simpulan.....	9
Referensi.....	9

CHAPTER 2 PERAN PERAWAT DALAM *QUALITY IMPROVEMENT* DAN *PATIENT SAFETY INCIDENT REPORTING*..... 11

Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Konsep Dasar Quality Improvement (QI)	15
C. Konsep Dasar Patient Safety Incident Reporting (PSIR).....	21
D. Hubungan antara Quality Improvement dan Patient Safety	27
E. Peran Perawat dalam Quality Improvement (QI).....	31
F. Peran Perawat dalam Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	38
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Insiden oleh Perawat	44
H. Strategi Peningkatan Kepatuhan Pelaporan dan Quality Improvement.....	47
I. Peran Manajemen Keperawatan dalam Mendukung QI dan PSIR.....	51
J. Praktik Baik (Best Practices) dan Studi Kasus.....	54
K. Tantangan dan Peluang Pengembangan di Masa Depan.....	58
L. Simpulan.....	63
Referensi.....	64
Glosarium.....	71

CHAPTER 3 PENGENDALIAN INFEKSI NOSOKOMIAL DAN SANITASI LINGKUNGAN FASILITAS KESEHATAN..... 75

Nima Eka Nur Rahmania, S.KM., M.KKK.	75
A. Pendahuluan.....	75

B. Konsep, Karakteristik dan Jenis Infeksi Nosokomial.....	76
C. Epidemiologi Infeksi Nosokomial di Fasilitas Kesehatan.....	79
D. Rantai Penularan Infeksi	80
E. Faktor Risiko Infeksi Nosokomial	83
F. Sanitasi Lingkungan Fasilitas Kesehatan.....	84
G. Peran Sumber Daya Manusia, Monitoring, dan Audit PPI	85
H. Tantangan dan Best Practice Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia.....	87
I. Simpulan.....	90
Referensi.....	91
Glosarium.....	92

CHAPTER 4 KOMUNIKASI EFEKTIF INTERPROFESI DALAM UPAYA KESELAMATAN PASIEN..... 93

Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H.	93
A. Pendahuluan/Prolog	93
B. Teknik SBAR dalam komunikasi interprofesi.....	93
C. TeamSTEPPS untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antar profesi kesehatan.....	96
D. Simpulan.....	100
Referensi.....	101
Glosarium.....	102

CHAPTER 5 ETIKA, LEGALITAS, DAN INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN MODERN..... 103

Ns. Asih Minarningtyas, M.Kep.....	103
A. Pendahuluan.....	103
B. Tren dan Isu Kontemporer.....	104
C. Etika dalam Pelayanan Kesehatan Modern.....	105
D. Aspek Legalitas dalam Pelayanan Kesehatan Modern.....	108
E. Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan Modern.....	111
F. Kesimpulan	114
Referensi.....	115

CHAPTER 6 PENGUATAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN PADA PERAWAT, BIDAN, APOTEKER DAN AHLI GIZI..... 117

Dr. Yahmin Setiawan, MARS.	117
A. Pendahuluan.....	117

B. Budaya Keselamatan Pasien Terhadap Keselamatan Pasien	118
C. Peran Perawat Dalam Budaya Keselamatan Pasien	119
D. Peran Bidan dalam Budaya Keselamatan Pasien	121
E. Peran Apoteker dalam Budaya Keselamatan Pasien	123
F. Peran Ahli Gizi dalam Budaya Keselamatan Pasien	124
G. Faktor-Faktor yang Mendukung Budaya Keselamatan Pasien	125
H. Simpulan.....	125
Referensi.....	126
PROFIL PENULIS	131

CHAPTER 1

STANDAR KESELAMATAN PASIEN DIFASILITAS KESEHATAN

Badriah, SST., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Rumah Sakit merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mengelola Pelayanan yang ditujukan kepada individu secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan baik preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif atau perawatan paliatif dengan menyediakan pelayanan berupa rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Dalam memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi dan pasien merasa lebih nyaman, maka Rumah Sakit harus memiliki tata kelola dengan pelayanan klinis yang baik. (UU Nomor 17 Tahun 2023).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsif terhadap kejadian tidak diinginkan di fasilitas pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga perlu dioptimalkan. Permenkes no.11 tahun 2017, mengatakan bahwa keselamatan Pasien merupakan suatu sistem yang membuat pelayanan kesehatan lebih aman, nyaman dan meliputi, penilaian risiko, identifikasi dan pengelolaan data yang akurat, dimana apabila ada suatu kejadian yang tidak diinginkan, dilakukan manajemen risiko pasien, pelaporan dan lakukan analisis insiden, kapasitas untuk belajar dari insiden dan tindak lanjutnya. Serta solusi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bahaya yang diakibatkan oleh kesalahan tindakan atau terlambat untuk melakukan pertolongan.

Kemampuan untuk bertindak sesuai standar yang relevan sangat penting untuk layanan kesehatan. Ada beberapa komponen program manajemen risiko yang efektif diantaranya :1). Adanya pengawasan dan dukungan dari pihak pimpinan, 2). Metodologi untuk mengidentifikasi dan tata kelola,3). menilai dan memantau risiko 4). Strategi untuk mengkomunikasikan dan cara mengelola risiko 5). Evaluasi dan pelaporan tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara berkala. (Aini et al., 2025)

Program untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, maka Rumah sakit harus dapat meningkatkan mutu pelayanannya, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, hal-hal yang dapat meningkatkan mutu pelayanan di Rumah sakit dapat dipengaruhi adanya penerapan Standar akreditasi, penilaian dimensi budaya keselamatan pasien, peran dan gaya pemimpin dalam meningkatkan mutu keselamatan dan pelayanan pasien serta komunikasi tenaga kesehatan terhadap pasien maupun keluarganya, dan persepsi perawat dalam meningkatkan budaya keselamatan pasien. (Hidayah & Arfah, 2022). Keselamatan pasien merupakan isu global, termasuk rumah sakit dituntut untuk mengupayakan sasaran keselamatan pasien, meningkatkan mutu pelayanan, mengurangi risiko pasien jatuh, mengurangi risiko yang berhubungan dengan infeksi, meningkatkan komunikasi yang efektif, jurnal lain mengatakan bahwa manfaat dari penilaian untuk mengetahui target keselamatan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. (Penelitian et al., 2026).

B. Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Permenkes Nomor 5 Tahun 2022. Mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan), dalam hal ini merupakan ketentuan tentang jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan pada dasarnya merupakan urusan pemerintahan yang wajib dan berhak diperoleh pada setiap warga negara, minimal wajib diterapkan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 6, BN 2024 (204); 130 HLM.

Keselamatan pasien berhubungan dengan suatu masalah sedini mungkin harus ditangani oleh pihak rumah sakit di Indonesia, maka dari itu penting sekali untuk diterapkannya standar keselamatan pasien rumah sakit sebagai pedoman rumah sakit yang ada di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Standar Keselamatan Pasien wajib diterapkan dirumah sakit dan melaksanakan evaluasi dengan menggunakan Instrumen Akreditasi Rumah Sakit. hak Pasien mendapatkan pelayanan yang baik, sehingga disusun Standar keselamatan pasien yang terdiri dari tujuh standar antara lain:

1. Hak pasien
2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
4. Penggunaan metoda-metoda dalam peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien

7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Dari tujuh standar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Standar I. Hak pasien

Standar: Pasien maupun keluarga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden.

Kriteria:

1. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan.
2. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan.
3. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan dengan benar kepada pasien dan keluarganya, tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien, termasuk kemungkinan terjadinya insiden.

Standar II. Mendidik pasien dan keluarga

Standar: Rumah sakit harus mendidik pasien beserta keluarga tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien.

Kriteria:

1. Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di rumah sakit harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat :
 - a. Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur.
 - b. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga.
 - c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti.
 - d. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.
 - e. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit.
 - f. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa.
 - g. Memenuhi kewajiban finansial yang perlu disepakati.

Standar III. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan

Standar: Rumah Sakit dapat menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga kesehatan dan unit pelayanan.

Kriteria:

1. Terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar dari rumah sakit.
2. Terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan dapat berjalan baik dan lancar.

3. Terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjut lainnya.
4. Terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman dan efektif.

Standar IV. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien

Standar: Rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien.

Kriteria:

1. Setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan (desain) yang baik, mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan "Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit".
2. Setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara lain terkait dengan : pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan.
3. Setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi secara intensif terkait dengan semua insiden, dan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus risiko tinggi.
4. Setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan, agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin.

Standar V. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien Standar:

1. Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan "Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit".
2. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi insiden..
3. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien.
4. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien.
5. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien.

Kriteria:

1. Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien.
2. Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden.
3. Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari rumah sakit terintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan pasien.
4. Tersedia prosedur "cepat-tanggap" terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis.
5. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas tentang Analisis Akar Masalah "Kejadian Nyaris Cedera" (Near miss) dan "Kejadian Sentinel" pada saat program keselamatan pasien mulai dilaksanakan.
6. Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden, misalnya menangani "Kejadian Sentinel" (Sentinel Event) atau kegiatan proaktif untuk memperkecil risiko, termasuk mekanisme untuk mendukung staf dalam kaitan dengan "Kejadian Sentinel".
7. Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar unit dan antar pengelola pelayanan di dalam rumah sakit dengan pendekatan antar disiplin.
8. Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan perbaikan kinerja rumah sakit dan perbaikan keselamatan pasien, termasuk evaluasi berkala terhadap kecukupan sumber daya tersebut.
9. Tersedia sasaran terukur, dan pengumpulan informasi menggunakan kriteria objektif untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien, termasuk rencana tindak lanjut dan implementasinya.

Standar VI. Mendidik staf tentang keselamatan pasien Standar:

1. Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas
2. Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisipliner dalam pelayanan pasien.

Kriteria:

1. Setiap rumah sakit harus memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya masing-masing.
2. Setiap rumah sakit harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan in-service training dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden.

3. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok (teamwork) guna mendukung pendekatan interdisipliner dan kolaboratif dalam rangka melayani pasien.

Standar VII. Komunikasi merupakan kunci bagi staff untuk mencapai keselamatan pasien

Standar:

1. Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal.
2. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat.

Kriteria:

1. Perlu disediakan anggaran dalam merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal hal terkait dengan keselamatan pasien.
2. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada.

C. Sasaran Keselamatan Pasien

Sasaran Keselamatan Pasien merupakan syarat utama yang harus diterapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Penyusunan sasaran ini mengacu kepada Nine Life-Saving Patient Safety Solutions dari WHO Patient Safety (2007) yang digunakan oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit PERSI (KKPRS PERSI), dari Joint Commission International (JCI). Maksud dan tujuan diterapkannya Sasaran Keselamatan Pasien, merupakan alat untuk mendorong perbaikan secara Khusus pada keselamatan pasien. Sasaran tersebut merupakan bagian dari langkah yang mempunyai masalah dalam pelayanan kesehatan dan merupakan konsensus berbasis bukti dari keahlian dalam permasalahan ini.

Identifikasi faktor yang mempunyai pengaruh terhadap keselamatan pasien yaitu langkah kritis yang diambil dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien merupakan aspek esensial yang harus diperhatikan dimana tempat pelayanan kesehatan atau Rumah sakit dalam mengurangi risiko cedera atau komplikasi yang tidak diinginkan selama dilakukannya perawatan. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: 1). Faktor internal, 2) faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari aspek-aspek dalam institusi kesehatan. Diantaranya adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh institusi. Kebijakan dan prosedur yang terstandarisasi mengenai keselamatan pasien, penting sekali untuk memastikan bahwa staf kesehatan yang terlibat didalamnya dapat memahami dan melakukan tahapan yang tepat demi

melindungi pasien. Prosedur ini mencakup SOP atau panduan tentang penggunaan alat-alat kesehatan, pemberian obat, dan tindakan darurat yang harus dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Kebijakan yang posistif harus didukung oleh pelatihan berkelanjutan bagi petugas kesehatan secara berkala agar staf selalu siap untuk menghadapi berbagai kejadian yang mungkin terjadi. (Mikraj et al., 2024).

“Upaya rumah sakit untuk menciptakan keselamatan pasien antara lain dengan adanya kebijakan yang berhubungan dengan keselamatan pasien, standar dan keselamatan pasien terdiri dari 6 SKPN, dan SKP ini di ukur dengan indikator-indikator mutu sehingga dapat menilai proses RS untuk mengukur keselamatan pasien”. “rumah sakit selalu menekankan kepada semua stafnya untuk melakukan setiap tindakan berdasarkan pedoman ataupun standar prosedur operasional dan regulasi yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Untuk memperkuat budaya keselamatan pasien, diperlukan program pendidikan berkelanjutan bagi staf, kampanye keselamatan yang konsisten, serta pemberian penghargaan bagi staf yang menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Langkah ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih proaktif terhadap keselamatan pasien. (Hasanah, 2024). Untuk memenuhi ketentuan normatif pada Permenkes No. 11 Tahun 2017. dalam pelaksanaannya masih terdapat ketimpangan antara standar normatif dan praktik yang sebenarnya, yang memungkinkan dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap pasien apabila tidak segera diatasi.

D. Enam sasaran keselamatan pasien

1. Ketepatan Identifikasi Pasien

Pada saat melakukan identifikasi pada pasien apabila ada kesalahan akan mengakibatkan fatal, terlebih dalam intervensi pemberian obat, transfusi darah, atau tindakan medis yang lain.

Maka dari itu Penting sekali buat tenaga kesehatan memastikan bahwa wajib melakukan setiap diidentifikasi pasien harus tepat untuk menghindari kesalahan pada saat melakukan tindakan pemberian perawatan. Pasien dapat diidentifikasi dengan cara melakukan anamnese dari mulai: nama lengkap dan tanggal lahir pasien dengan menggunakan pertanyaan terbuka, kemudian dicocokkan dengan label identitas pasien sebelum memberikan perawatan atau tindakan medis.

2. Peningkatan Komunikasi Efektif

Komunikasi secara efektif dan jelas antara anggota tim kesehatan yang merupakan kunci untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melaksanakan

pelayanan kesehatan. Informasi kurang lengkap atau melakukan kesalahan dalam interpretasi data dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam menentukan diagnosa, pengobatan, atau perawatan lanjutan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan komunikasi melalui pencatatan yang jelas, komunikasi verbal yang efektif, dan serah terima yang baik antara shift kerja atau antar unit layanan medis.

Lakukan teknik komunikasi **SBAR**:

Situation (Situasi): Jelaskan situasi saat ini secara singkat. Apa masalahnya? Mengapa laporan ini diperlukan?

Background (Latar Belakang): Berikan informasi latar belakang yang relevan. Apa yang terjadi sebelumnya?

Assessment (Penilaian): Berikan penilaian atau diagnosis sementara. Berdasarkan informasi yang ada, apa masalahnya?

Recommendation (Rekomendasi): Berikan saran atau rekomendasi. Apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Apa yang Anda rekomendasikan sebagai tindakan atau intervensi?

3. Meningkatkan Keamanan penggunaan Obat

Pemberian obat merupakan salah satu area yang rentan terhadap kesalahan. Dengan demikian untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kebijakan yang jelas mengenai pengobatan serta pengawasan yang ketat dalam memberi dan memantau penggunaan obat. Perhatian khusus terhadap obat berisiko tinggi (*high alert*), obat-obat LASA (*Look Alike Sound Alike*) dan sebagainya, mulai dari pelabelan yang benar, pengawasan dosis, serta edukasi pasien tentang obat yang di konsumsi.

4. Memastikan Tindakan yang Tepat di Lokasi yang Benar pada Pasien yang Benar

Pengecekan ulang oleh Petugas medis perlu dilakukan sebelum tindakan dilakukan, seperti tanda tangan pasien, *mark side* atau penandaan pada area/lokasi yang akan di operasi. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa tindakan medis dilakukan dengan benar.

5. Mengurangi Risiko Infeksi terkait Layanan Kesehatan

Healthcare-associated infections/HAIs atau Infeksi terkait layanan kesehatan merupakan infeksi yang didapat oleh pasien selama mereka menerima perawatan medis di fasilitas kesehatan. Untuk mencegah terjadi hal tersebut maka fasilitas kesehatan/rumah sakit wajib menerapkan praktik kebersihan dan sterilisasi yang baik untuk mencegah penyebaran infeksi, seperti patuh melakukan langkah-

langkah kebersihan tangan sesuai dengan 5 monent cuci tangan dan penggunaan alat medis steril untuk mencegah kontaminasi.

6. Mengurangi Risiko Jatuh Pada Pasien

penyebab umum cedera yang terjadi di rumah sakit adalah Jatuh , terutama pada ana-anak, pasien lanjut usia, dan pasien yang baru menjalani operasi. Risiko cedera akibat jatuh dapat dikurangi dengan penilaian risiko pada setiap pasien, edukasi dapat dilakukan kepada pasien dan keluarga tentang langkah-langkah pencegahan jatuh misalnya : memasang pagar pengaman tempat tidur,

bel ditekan apabila membutuhkan bantuan/pertolongan, roda tempat tidur pastikan selalu terkunci, (<https://rskm.ihc.id/artikel-detail-787-6-Sasaran-Keselamatan-Pasien.html>).

E. Simpulan

Standar keselamatan pasien merupakan standar acuan bagi rumah sakit dan wajib dilaksanakan penilaiannya yang dilakukan dengan menggunakan instrumen Rumah Sakit, dan terdiri dari 7 standar dengan kriterianya dan 6 sasaran Keselamatan pasien. Keselamatan pasien berhubungan dengan suatu masalah sedini mungkin yang harus ditangani oleh pihak rumah sakit di Indonesia, maka dari itu penting sekali untuk diterapkannya standar keselamatan pasien rumah sakit sebagai pedoman rumah sakit yang ada di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Referensi

- Aini, W. N., Lailiyah, S., & Kurniawati, N. A. (2025). *Upaya Penerapan Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan di Rumah Sakit: Systematic Literature Review 2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline*. 3(2), 485–496.
- Assessment, R., Risk, P., Irsyad, M., Aji, K., Simandjuntak, M. E., & Wibowo, D. B. (2017). *Pelaksanaan Asesmen Risiko , Identifikasi dan Pengelolaan Risiko Pasien Guna Menjamin Keselamatan Pasien dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No 11 Tahun 2017 (Studi di Rumah Sakit Islam Pati)*. 2017(11), 71–78.
- Hasanah, S. W. (2024). *Strategi implementasi keselamatan pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rsud abdoel wahab sjahrane*. 3(1), 12–43.
- Hidayah, N., & Arfah, A. (2022). *Quality of service for patient safety in hospitals*. 24(1), 186–194.
- Mikraj, A. L., Budiman, A., & Yudiansyah, R. (2024). *Manajemen Pasien Safety dalam*

- Meningkatkan Mutu Pelayanan Pasien. 5(1), 239–248.*
- Mulyadi. Manajemen Risiko di Rumah Sakit. Jakarta: EGC, 2020.
- Murray, E. (2017). Nursing leadership and management for patient safety and quality care. Philadelphia: F.A. Davis Company
- Penellitian, L., Jodjana, K., Niha, S. S., & Manafe, H. A. (2026). *Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit: Literatur Review. 23(2), 2026–2031.*
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3194>
- (2017). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2023;(187315):1–300.
- Tutiany, Lindawati, Krisanti, P. (2017). Manajemen keselamatan pasien. Jakarta: Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
- <https://galihendradita.wordpress.com/2024/09/23/standar-keselamatan-pasien-di-indonesia/>
- (<https://rskm.ihc.id/artikel-detail-787-6-Sasaran-Keselamatan-Pasien.html>).

CHAPTER 2

PERAN PERAWAT DALAM *QUALITY IMPROVEMENT* DAN *PATIENT SAFETY INCIDENT REPORTING*

Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

A. Pendahuluan

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam sistem pelayanan kesehatan modern yang menjadi indikator fundamental kualitas pelayanan di seluruh dunia. Insiden keselamatan pasien yang tidak dilaporkan dan dikelola dengan baik dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik dari aspek kesehatan pasien maupun beban finansial sistem kesehatan. *Medical error* dan insiden keselamatan pasien telah menjadi permasalahan global yang memerlukan perhatian serius dari seluruh *stakeholder* kesehatan, mengingat dampaknya yang luas terhadap kualitas hidup pasien, reputasi institusi kesehatan, dan keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Berbagai intervensi telah dikembangkan untuk mengurangi insiden *medical error* dan beban finansialnya dalam sistem pelayanan kesehatan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan sistematis yang melibatkan seluruh elemen organisasi kesehatan (Ahsani-Estahbanati et al., 2022).

Pelaporan insiden keselamatan pasien merupakan langkah krusial dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pencegahan terjadinya kejadian yang sama di masa mendatang. Sistem pelaporan yang efektif memungkinkan organisasi kesehatan untuk mengidentifikasi pola kesalahan, menganalisis akar masalah, dan mengimplementasikan strategi perbaikan yang komprehensif. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kontak paling lama dan intensif dengan pasien memiliki peran strategis dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien, karena posisi mereka yang berada di garda terdepan pelayanan kesehatan menempatkan mereka sebagai pihak yang paling sering mengidentifikasi dan mengalami insiden keselamatan pasien secara langsung. Namun demikian, praktik pelaporan insiden keselamatan pasien masih menghadapi berbagai hambatan signifikan yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai *barriers* dalam pelaporan insiden oleh tenaga medis, termasuk ketakutan akan konsekuensi negatif, persepsi bahwa pelaporan dapat berdampak negatif terhadap reputasi

profesional, beban kerja yang tinggi, dan kekhawatiran akan tindakan disipliner yang dapat mempengaruhi karir profesional mereka (Anderson et al., 2024).

Konteks pelayanan kesehatan di berbagai negara, khususnya di negara berkembang, menunjukkan kompleksitas permasalahan pelaporan insiden yang lebih mendalam dan memerlukan perhatian khusus. Sistem pelaporan insiden keselamatan pasien dan praktik pelaporan di organisasi kesehatan Afrika masih belum optimal, dengan tingkat pelaporan yang rendah dan sistem yang belum terstandarisasi dengan baik. Analisis sistematis dan *meta-analysis* menunjukkan bahwa organisasi kesehatan di Afrika menghadapi tantangan struktural, kultural, dan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas sistem pelaporan dan pembelajaran dari insiden, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan yang memadai, dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung *transparency* dalam pelaporan kesalahan. Situasi serupa juga ditemukan di berbagai negara berkembang lainnya, menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap konteks lokal dalam pengembangan sistem pelaporan yang *culturally appropriate* dan berkelanjutan (Fekadu et al., 2025).

Hambatan dalam implementasi pedoman pelaporan dan pembelajaran dari insiden keselamatan pasien di unit perawatan khusus mencakup berbagai aspek yang saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan. Studi kualitatif di unit perawatan khusus di KwaZulu-Natal mengidentifikasi berbagai *barriers* yang meliputi aspek organisasional seperti kurangnya dukungan manajemen dan keterbatasan sumber daya, aspek individual seperti kurangnya pengetahuan dan motivasi perawat, serta aspek sistemik seperti kompleksitas proses pelaporan dan ketiadaan *feedback* yang konstruktif terhadap laporan yang telah disubmit. Hambatan-hambatan tersebut menciptakan siklus negatif di mana rendahnya tingkat pelaporan mengakibatkan minimnya pembelajaran organisasi, yang pada gilirannya semakin menurunkan motivasi untuk melaporkan insiden di masa mendatang. Temuan ini menekankan perlunya pendekatan holistik dan *multifaceted* yang mempertimbangkan *multiple factors* dalam merancang strategi peningkatan pelaporan insiden yang efektif dan sustainable (Gqaleni & Mkhize, 2024).

Hubungan antara disposisi berpikir kritis perawat dan pelaporan insiden keselamatan pasien menunjukkan kompleksitas faktor yang mempengaruhi praktik pelaporan di lingkungan klinis. Perawat dengan kemampuan berpikir kritis yang baik cenderung lebih mampu mengidentifikasi potensi risiko, menganalisis situasi dengan komprehensif, dan membuat keputusan yang tepat terkait perlunya pelaporan insiden. Namun, kemampuan ini perlu didukung oleh budaya keselamatan pasien yang kuat dalam organisasi untuk dapat termanifestasi dalam

praktik pelaporan yang konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien berperan sebagai mediator dalam hubungan antara disposisi berpikir kritis perawat dan pelaporan insiden, di mana lingkungan kerja yang kondusif, *supportive leadership*, dan sistem yang *blame-free* memungkinkan perawat untuk melaporkan insiden tanpa rasa takut dan mendorong transparansi serta pembelajaran organisasi yang berkelanjutan (Kim & Kwak, 2024).

Sistem perangkat lunak pelaporan insiden keselamatan pasien yang ada saat ini masih memiliki berbagai kekurangan signifikan yang mempengaruhi motivasi dan kemudahan profesional kesehatan dalam melaporkan insiden. Dari perspektif profesional kesehatan, *handling features* dari *software* pelaporan sering kali tidak *user-friendly*, memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu laporan, dan memiliki antarmuka yang kompleks serta membingungkan. Studi *cross-sectional* dengan desain kualitatif juga mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam proses pemrosesan laporan, termasuk kurangnya *feedback* yang tepat waktu, ketidakjelasan tentang tindak lanjut yang dilakukan terhadap laporan, dan minimnya komunikasi tentang pembelajaran yang diperoleh dari insiden yang dilaporkan. Keterbatasan teknologi dan sistem ini berkontribusi signifikan terhadap rendahnya motivasi tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden, karena proses yang rumit dan memakan waktu menambah beban kerja yang sudah tinggi tanpa memberikan nilai tambah yang jelas bagi pelapor (Koskiniemi et al., 2025).

Intervensi edukasi keselamatan pasien bagi perawat merupakan strategi fundamental yang perlu dirancang secara sistematis dan berbasis bukti untuk meningkatkan kompetensi dan praktik keselamatan pasien. *Systematic review* tentang intervensi edukasi keselamatan pasien menunjukkan bahwa program pendidikan yang terstruktur, menggunakan metode pembelajaran aktif, dan mengintegrasikan simulasi serta studi kasus dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik perawat terkait keselamatan pasien secara signifikan. Rekomendasi untuk *educator* keperawatan menekankan pentingnya integrasi konten keselamatan pasien dalam kurikulum pendidikan keperawatan sejak dini, penggunaan pendekatan *interprofessional education*, dan pengembangan kompetensi melalui *experiential learning* yang memungkinkan mahasiswa keperawatan untuk belajar dari situasi nyata dalam lingkungan yang aman. Pendidikan yang komprehensif ini tidak hanya fokus pada aspek teknis keselamatan pasien, tetapi juga mengembangkan *critical thinking*, komunikasi efektif, dan *teamwork* yang merupakan kompetensi esensial dalam praktik keselamatan pasien (S. E. Lee et al., 2021).

Upaya peningkatan pelaporan insiden melalui pendekatan *quality improvement* telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam berbagai konteks

pelayanan kesehatan. Implementasi metodologi *quality improvement* untuk meningkatkan pelaporan insiden serius dalam sistem kesehatan nasional, seperti yang dilakukan di NHS Inggris, mendemonstrasikan bahwa pendekatan sistematis dengan fokus pada *continuous learning* dan *iterative improvement* dapat menghasilkan peningkatan substansial dalam kualitas dan kuantitas pelaporan insiden. Strategi *quality improvement* yang efektif meliputi simplifikasi proses pelaporan, pemberian *feedback* regular kepada pelapor, edukasi berkelanjutan tentang pentingnya pelaporan, keterlibatan *leadership* dalam mempromosikan budaya keselamatan, dan penggunaan data pelaporan untuk *actionable improvements*. Adopsi pendekatan ini memerlukan komitmen organisasional jangka panjang, alokasi sumber daya yang memadai, dan dukungan sistem yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan program (Dos Santos et al., 2025).

Pembelajaran dari organisasi dengan reliabilitas tinggi (*high-reliability organizations*) dan analisis insiden di berbagai *settings* pelayanan kesehatan memberikan *insights* berharga untuk pengembangan sistem pelaporan dan pembelajaran yang efektif. *Systematic review* mengidentifikasi berbagai *learning tools* yang telah terbukti efektif di industri dengan risiko tinggi seperti penerbangan dan nuklir, yang memiliki potensi untuk diadaptasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk teknik analisis akar masalah (*root cause analysis*), *failure mode and effects analysis*, dan sistem *debriefing* terstruktur. Analisis *mixed methods* terhadap insiden keselamatan pasien yang melibatkan pasien sakit akut di unit *assessment* rumah sakit juga menunjukkan pentingnya identifikasi pola insiden, *contributing factors*, dan *opportunities for improvement* melalui analisis komprehensif untuk mengembangkan intervensi yang *targeted* dan efektif. Transfer pengetahuan lintas sektor dan pembelajaran berbasis bukti ini memperkaya pendekatan *healthcare* dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan pembelajaran organisasi dari setiap insiden yang terjadi (Serou et al., 2021).

Konteks Indonesia menunjukkan permasalahan spesifik terkait rendahnya pelaporan insiden keselamatan pasien di kalangan perawat yang memerlukan pemahaman mendalam dan intervensi yang sesuai dengan karakteristik lokal. Studi kualitatif tentang alasan rendahnya pelaporan insiden keselamatan pasien di kalangan perawat Indonesia mengidentifikasi berbagai faktor yang melatarbelakangi, termasuk faktor budaya seperti kecenderungan untuk menghindari konflik dan menjaga harmoni kelompok, faktor organisasional seperti hierarki yang kuat dan kurangnya dukungan manajemen, serta faktor individual seperti ketakutan akan *blame* dan kurangnya pemahaman tentang manfaat pelaporan. Gaya kepemimpinan perawat juga memiliki pengaruh signifikan terhadap budaya pelaporan insiden keselamatan pasien, di mana *leadership style*

yang transformasional dan *supportive* dapat menciptakan lingkungan yang mendorong transparansi dan *openness* dalam pelaporan insiden (Yusuf & Irwan, 2021). Pemahaman konteks lokal yang mendalam ini sangat penting dalam merancang intervensi yang *culturally appropriate*, efektif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan praktik pelaporan di Indonesia, serta pengembangan kapasitas kepemimpinan perawat sebagai investasi strategis dalam membangun budaya keselamatan pasien yang kuat (Pramesona et al., 2023).

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang peran krusial perawat dalam *quality improvement* dan *patient safety incident reporting* dalam konteks pelayanan kesehatan modern. Melalui kajian literatur yang mendalam dan berbasis bukti, buku ini menyajikan analisis tentang berbagai aspek yang mempengaruhi praktik pelaporan insiden, mulai dari faktor individual perawat, budaya organisasi, sistem pelaporan, hingga strategi peningkatan yang dapat diimplementasikan. Manfaat yang diharapkan dari pembahasan ini adalah meningkatnya *awareness* perawat tentang pentingnya peran mereka dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien dan *quality improvement*. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi *educator* keperawatan dalam mengembangkan kurikulum dan program pelatihan yang fokus pada *patient safety*, serta memberikan panduan praktis bagi manajer keperawatan dan administrator rumah sakit dalam merancang sistem dan kebijakan yang mendukung praktik pelaporan insiden yang efektif dan berkelanjutan.

B. Konsep Dasar Quality Improvement (QI)

1. Pengertian dan Prinsip Dasar QI di Rumah Sakit

Quality Improvement (QI) atau peningkatan mutu merupakan pendekatan sistematis dan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui identifikasi masalah, analisis proses, implementasi perubahan, dan evaluasi hasil secara berkesinambungan. Dalam konteks rumah sakit, QI berfokus pada optimalisasi berbagai aspek pelayanan untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pasien, efisiensi operasional, dan keselamatan dalam pemberian layanan kesehatan. Konsep ini tidak hanya melibatkan perbaikan pada satu area spesifik, tetapi mencakup transformasi menyeluruh dalam budaya organisasi yang mengutamakan pembelajaran berkelanjutan, inovasi, dan komitmen terhadap *excellence*. Prinsip dasar QI di rumah sakit mencakup pendekatan yang berpusat pada pasien (*patient-centered*), penggunaan data untuk pengambilan keputusan, keterlibatan seluruh tim multidisiplin, fokus pada proses daripada menyalahkan individu, serta

komitmen terhadap perubahan yang berkelanjutan dan terukur. Berbagai indikator kunci yang mempengaruhi efisiensi rumah sakit perlu diidentifikasi dan dimonitor secara sistematis untuk memastikan bahwa upaya peningkatan mutu dapat dilakukan secara *evidence-based* dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan (Imani et al., 2022).

Implementasi praktik *Total Quality Management* (TQM) di rumah sakit telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja finansial dan operasional organisasi kesehatan. Praktik TQM yang komprehensif mencakup berbagai elemen seperti kepemimpinan yang kuat dalam mendorong budaya mutu, fokus pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam proses peningkatan mutu, manajemen proses yang efektif, penggunaan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan, serta komitmen terhadap pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit yang mengadopsi praktik TQM secara konsisten dan menyeluruh mengalami peningkatan dalam berbagai aspek kinerja, termasuk efisiensi operasional yang tercermin dari pengurangan *waste* dan optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan kualitas layanan yang diukur melalui berbagai indikator klinis dan non-klinis, serta peningkatan kinerja finansial yang sustainable. Dampak positif ini menunjukkan bahwa investasi dalam program QI bukan hanya memberikan manfaat dari perspektif kualitas pelayanan dan keselamatan pasien, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan finansial dan daya saing organisasi kesehatan dalam jangka panjang (Zehir & Zehir, 2023).

2. Model Peningkatan Mutu (PDSA, Lean, Six Sigma)

Berbagai model peningkatan mutu telah dikembangkan dan diadopsi dalam sistem pelayanan kesehatan untuk memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam melaksanakan inisiatif perbaikan. Model-model ini menyediakan metodologi yang sistematis, *tools* yang praktis, dan pendekatan yang terbukti efektif untuk mengidentifikasi *gaps* dalam kualitas layanan, merancang intervensi yang tepat, dan mengukur dampak perubahan yang diimplementasikan. Setiap model memiliki karakteristik, kekuatan, dan area aplikasi yang spesifik, namun semuanya berbagi tujuan fundamental yang sama yaitu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan. Pemahaman yang komprehensif tentang berbagai model ini memungkinkan organisasi kesehatan untuk memilih atau mengombinasikan pendekatan yang paling sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan kapabilitas mereka (Mehta et al., 2022). Tiga model yang paling banyak digunakan dalam konteks rumah sakit adalah *Plan-Do-Study-Act*

(PDSA), *Lean*, dan *Six Sigma*, masing-masing menawarkan perspektif dan metodologi yang unik dalam mendorong peningkatan mutu yang berkelanjutan.

a. Plan-Do-Study-Act (PDSA)

Model PDSA merupakan siklus perbaikan iteratif yang terdiri dari empat tahap berurutan: merencanakan perubahan (*Plan*), melaksanakan perubahan dalam skala kecil (*Do*), mempelajari hasil dan dampak perubahan (*Study*), dan mengambil tindakan berdasarkan pembelajaran yang diperoleh (*Act*). Pendekatan ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui eksperimen skala kecil yang memungkinkan organisasi untuk menguji ide perbaikan dengan risiko minimal sebelum implementasi penuh. Dalam fase *Plan*, tim mengidentifikasi masalah atau peluang perbaikan, menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, menganalisis proses yang ada, dan merancang perubahan yang akan diuji. Fase *Do* melibatkan implementasi perubahan dalam skala kecil atau *pilot*, sambil mengumpulkan data untuk evaluasi. Fase *Study* fokus pada analisis data yang dikumpulkan, membandingkan hasil aktual dengan prediksi atau target yang ditetapkan, dan mengidentifikasi pembelajaran kunci dari eksperimen. Fase *Act* melibatkan keputusan tentang langkah selanjutnya: apakah perubahan akan diadopsi secara luas, dimodifikasi untuk siklus PDSA berikutnya, atau ditinggalkan jika tidak efektif. Siklus ini dapat diulang berkali-kali dengan modifikasi dan perbaikan progresif hingga mencapai hasil yang diinginkan, menjadikannya pendekatan yang fleksibel dan adaptif untuk berbagai konteks peningkatan mutu.

b. Lean

Lean adalah filosofi dan metodologi manajemen yang berfokus pada maksimalisasi nilai bagi pasien sambil meminimalkan *waste* atau pemborosan dalam sistem pelayanan kesehatan. Konsep *Lean* mengidentifikasi tujuh jenis *waste* utama: transportasi yang tidak perlu, *inventory* yang berlebihan, gerakan yang tidak efisien, waktu menunggu, *over-processing*, *overproduction*, dan *defects* atau kesalahan. Pendekatan *Lean* yang dikombinasikan dengan prinsip *person-centered care* telah terbukti efektif dalam mendukung berbagai inisiatif perbaikan di rumah sakit, termasuk dalam konteks pemulihan aktivitas rutin pasca periode krisis seperti pandemi COVID-19. Implementasi *Lean* melibatkan berbagai *tools* dan teknik seperti *value stream mapping* untuk memvisualisasikan alur proses dan mengidentifikasi *waste*, konsep 5S (Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain) untuk menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir dan efisien, *Kaizen* atau perbaikan berkelanjutan yang melibatkan semua level karyawan, dan sistem *pull* yang mengatur aliran kerja berdasarkan permintaan aktual. Pendekatan *Lean* yang berorientasi pada manusia tidak

hanya fokus pada efisiensi proses, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan pasien serta kesejahteraan staf, menciptakan sistem yang lebih *sustainable* dan *human-centered* (Daly et al., 2022).

c. Six Sigma

Six Sigma adalah metodologi peningkatan mutu yang sangat terstruktur dan berbasis data statistik yang bertujuan untuk mengurangi variasi dalam proses dan mencapai tingkat kesalahan yang minimal (3,4 *defects* per juta kesempatan). Pendekatan ini menggunakan kerangka kerja DMAIC (*Define-Measure-Analyze-Improve-Control*) untuk proyek perbaikan: fase *Define* mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pelanggan, fase *Measure* mengumpulkan data *baseline* tentang kinerja proses saat ini, fase *Analyze* menggunakan alat statistik untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, fase *Improve* mengembangkan dan mengimplementasikan solusi, dan fase *Control* memastikan perbaikan dipertahankan melalui sistem monitoring dan standarisasi. *Lean Six Sigma*, yang mengintegrasikan kecepatan dan fokus eliminasi *waste* dari *Lean* dengan ketepatan dan rigor statistik dari *Six Sigma*, telah menjadi pendekatan yang semakin populer dalam organisasi kesehatan. Pengembangan model maturitas peningkatan mutu yang sistemik melalui sintesis *systematic review* dan opini ahli menunjukkan bahwa organisasi kesehatan perlu mengembangkan kapabilitas mereka secara bertahap dalam implementasi metodologi seperti *Lean Six Sigma*, mulai dari tingkat kesadaran dan inisiasi hingga mencapai tingkat optimisasi dan inovasi berkelanjutan. Model maturitas ini membantu organisasi untuk menilai posisi mereka saat ini, mengidentifikasi *gap* dalam kapabilitas, dan merencanakan jalur pengembangan yang sistematis menuju *excellence* dalam peningkatan mutu (Akmal et al., 2021).

3. Indikator Mutu Pelayanan Keperawatan

Indikator mutu pelayanan keperawatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien serta efektivitas sistem dan proses keperawatan dalam organisasi kesehatan. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi yang memungkinkan manajer keperawatan dan tim klinis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, melacak kemajuan inisiatif peningkatan mutu, dan memastikan bahwa standar pelayanan keperawatan terpenuhi secara konsisten (R. Layli, 2022). Pengukuran indikator mutu yang sistematis dan berkelanjutan memberikan data objektif yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, alokasi sumber daya yang efektif, dan

peningkatan akuntabilitas profesional. Indikator mutu pelayanan keperawatan dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi utama yang saling terkait dan secara kolektif mencerminkan kualitas komprehensif dari pelayanan keperawatan dalam suatu organisasi kesehatan.

a. Indikator Struktur

Indikator struktur mengukur sumber daya dan sistem yang tersedia untuk mendukung pemberian pelayanan keperawatan, termasuk karakteristik organisasi, fasilitas fisik, peralatan medis, dan yang paling krusial adalah sumber daya manusia keperawatan. Manajemen sumber daya manusia dalam fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran vital dalam memastikan tersedianya tenaga keperawatan yang kompeten, termotivasi, dan dalam jumlah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien. Aspek-aspek penting dalam indikator struktur meliputi rasio perawat terhadap pasien (*nurse-to-patient ratio*) yang mempengaruhi beban kerja dan kualitas asuhan yang dapat diberikan, kualifikasi dan kompetensi perawat termasuk tingkat pendidikan dan sertifikasi spesialisasi, program orientasi dan pelatihan berkelanjutan yang memastikan perawat memiliki pengetahuan dan keterampilan terkini, sistem penjadwalan dan manajemen *shift* yang mempengaruhi kelelahan dan kepuasan kerja perawat, serta ketersediaan *support systems* seperti teknologi informasi kesehatan dan protokol klinis yang memfasilitasi praktik berbasis bukti. Investasi yang memadai dalam struktur ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pemberian asuhan keperawatan berkualitas tinggi (Sarila, 2025).

b. Indikator Proses

Indikator proses mengukur aktivitas dan tindakan keperawatan yang dilakukan dalam memberikan asuhan kepada pasien, termasuk kepatuhan terhadap standar praktik, protokol klinis, dan *best practices* yang telah ditetapkan. Indikator proses mencakup berbagai aspek seperti kelengkapan dan ketepatan waktu dokumentasi keperawatan, pelaksanaan pengkajian pasien yang komprehensif dan berkala, implementasi rencana asuhan keperawatan yang individualized, kepatuhan terhadap prosedur pencegahan infeksi dan praktik keselamatan pasien, pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga, serta koordinasi dan komunikasi yang efektif antar tim kesehatan. Pengukuran indikator proses memungkinkan identifikasi *gaps* antara praktik aktual dan standar yang diharapkan, memberikan *insight* tentang area yang memerlukan pelatihan atau perbaikan sistem, dan memfasilitasi pembelajaran serta peningkatan berkelanjutan dalam praktik keperawatan. Proses yang

terstandarisasi dan berbasis bukti meningkatkan konsistensi kualitas pelayanan dan mengurangi variabilitas yang tidak diinginkan dalam asuhan keperawatan.

c. Indikator Outcome

Indikator *outcome* atau hasil mengukur dampak pelayanan keperawatan terhadap status kesehatan dan kesejahteraan pasien, serta kepuasan mereka terhadap asuhan yang diterima. Indikator *outcome* yang umum digunakan dalam pelayanan keperawatan meliputi tingkat kejadian *adverse events* seperti *pressure ulcers*, jatuh pasien, infeksi terkait perawatan, kesalahan medikasi, tingkat kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan, *length of stay* (lama rawat inap), tingkat *readmission*, dan status fungsional pasien saat pulang. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang efektivitas pelayanan keperawatan dalam mencapai tujuan klinis dan memenuhi kebutuhan pasien. Pengukuran *outcome* yang sistematis memungkinkan organisasi kesehatan untuk mengevaluasi dampak dari inisiatif peningkatan mutu, membandingkan kinerja antar unit atau dengan *benchmark* eksternal, dan mengidentifikasi *best practices* yang dapat direplikasi untuk meningkatkan hasil di seluruh organisasi.

d. Indikator Kinerja Perawat

Indikator kinerja perawat mengukur produktivitas, efektivitas, dan kualitas kerja perawat secara individual maupun kolektif dalam memberikan asuhan keperawatan. Motivasi merupakan faktor krusial yang mempengaruhi kinerja perawat di rumah sakit, di mana perawat yang termotivasi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam berbagai aspek pekerjaan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat meliputi motivasi intrinsik dan ekstrinsik, kepuasan kerja, dukungan supervisi dan *leadership*, beban kerja dan kondisi lingkungan kerja, peluang pengembangan profesional, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi mereka. Indikator kinerja dapat mencakup tingkat kehadiran dan *turnover*, partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan, kontribusi dalam inisiatif peningkatan mutu, penilaian kompetensi klinis, dan *feedback* dari pasien serta rekan kerja. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kinerja perawat sangat penting bagi manajer keperawatan dalam merancang strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang *supportive*, dan mengoptimalkan kontribusi perawat terhadap kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (A. N. Layli et al., 2023).

C. Konsep Dasar Patient Safety Incident Reporting (PSIR)

1. Definisi dan Tujuan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Pelaporan insiden keselamatan pasien merupakan suatu proses sistematis dalam mendokumentasikan, melaporkan, dan menganalisis kejadian atau situasi yang berpotensi atau telah menyebabkan cedera pada pasien selama proses pelayanan kesehatan. Sistem pelaporan ini menjadi komponen fundamental dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit, karena menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi *gaps* dalam sistem pelayanan, memahami akar penyebab masalah, dan mengimplementasikan tindakan perbaikan yang *evidence-based*. Definisi pelaporan insiden mencakup tidak hanya kejadian yang mengakibatkan kerugian aktual pada pasien (*adverse events*), tetapi juga kejadian yang hampir terjadi (*near miss*) dan situasi yang berpotensi menimbulkan risiko. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan organisasi kesehatan untuk belajar dari berbagai tingkat insiden dan mengembangkan strategi preventif sebelum kerugian serius terjadi. Sistem pelaporan yang efektif harus bersifat *non-punitive*, mudah diakses, *user-friendly*, dan memberikan *feedback* yang konstruktif kepada pelapor untuk mendorong partisipasi aktif dari seluruh profesional kesehatan. Evaluasi sistem pelaporan insiden keselamatan pasien menggunakan berbagai metode menunjukkan bahwa efektivitas sistem sangat bergantung pada desain yang *user-centered*, proses yang tersederhanakan, dan dukungan organisasional yang kuat dalam menciptakan budaya pembelajaran dari kesalahan (Toyo et al., 2022).

Tujuan utama dari pelaporan insiden keselamatan pasien bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan individu, melainkan untuk menciptakan sistem pembelajaran organisasional yang memungkinkan identifikasi faktor-faktor sistemik yang berkontribusi terhadap terjadinya insiden. Tujuan primer meliputi deteksi dini terhadap potensi bahaya dalam sistem pelayanan kesehatan, analisis *root cause* untuk memahami mengapa insiden terjadi dengan mempertimbangkan faktor manusia, proses, peralatan, dan lingkungan, pengembangan dan implementasi strategi pencegahan yang *targeted* dan berbasis bukti, monitoring efektivitas intervensi keselamatan yang telah dilaksanakan, serta diseminasi pembelajaran dari insiden ke seluruh organisasi dan bahkan lintas institusi. Selain itu, sistem pelaporan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan profesional kesehatan terhadap isu keselamatan pasien, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi, memfasilitasi *benchmarking* kinerja keselamatan dengan standar nasional maupun internasional, dan pada akhirnya mengurangi *morbidity*, *mortality*, dan biaya yang terkait dengan insiden keselamatan pasien. Berbagai

aspek dimensi budaya keselamatan pasien menunjukkan hubungan yang signifikan dengan budaya pelaporan di rumah sakit, di mana lingkungan yang mendukung *psychological safety* dan *just culture* menjadi prasyarat penting untuk mendorong pelaporan yang jujur dan komprehensif (Wulandari et al., 2023).

Namun demikian, realisasi tujuan-tujuan tersebut sering kali terhambat oleh berbagai faktor yang menghambat praktik pelaporan insiden di rumah sakit. Hambatan-hambatan ini bersifat multifaktorial dan kompleks, mencakup faktor individual seperti ketakutan akan *blame* dan konsekuensi negatif terhadap karir, persepsi bahwa insiden minor tidak perlu dilaporkan, kurangnya pengetahuan tentang apa yang harus dilaporkan dan bagaimana cara melaporkan, serta *time constraint* akibat beban kerja yang tinggi. Faktor organisasional meliputi budaya yang *punitive* terhadap kesalahan, kurangnya dukungan dan komitmen manajemen terhadap program keselamatan pasien, sistem pelaporan yang kompleks dan *time-consuming*, tidak adanya *feedback* yang bermakna kepada pelapor tentang tindak lanjut yang dilakukan, serta ketiadaan insentif atau pengakuan bagi mereka yang aktif melaporkan (Valentin, 2025). Faktor sistem mencakup infrastruktur teknologi pelaporan yang tidak memadai, kurangnya standarisasi dalam klasifikasi dan analisis insiden, keterbatasan sumber daya untuk investigasi dan tindak lanjut insiden, serta koordinasi yang lemah antar unit dalam manajemen keselamatan pasien. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penghambat ini melalui *literature review* yang komprehensif sangat penting untuk merancang intervensi yang *targeted* dan efektif dalam meningkatkan *rate* pelaporan dan mengoptimalkan pembelajaran organisasional dari insiden keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien yang positif terbukti memiliki korelasi kuat dengan peningkatan pelaporan insiden, menunjukkan bahwa intervensi yang fokus pada transformasi budaya organisasi merupakan strategi fundamental dalam mengatasi hambatan pelaporan (Habibah & Dhamanti, 2025).

2. Jenis-Jenis Insiden (KTD, KNC, KTC, KPC)

Klasifikasi insiden keselamatan pasien merupakan elemen penting dalam sistem pelaporan dan manajemen keselamatan pasien di rumah sakit, karena memungkinkan identifikasi, kategorisasi, dan analisis yang sistematis terhadap berbagai jenis kejadian yang dapat membahayakan pasien. Sistem klasifikasi yang terstandarisasi memfasilitasi komunikasi yang jelas antar profesional kesehatan, memungkinkan agregasi dan analisis data secara konsisten, serta mendukung *benchmarking* kinerja keselamatan antar institusi. Di Indonesia, klasifikasi insiden

keselamatan pasien mengacu pada pedoman nasional yang mengategorikan insiden ke dalam empat jenis utama berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap pasien: Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Cedera (KTC), dan Kondisi Potensial Cedera (KPC). Pemahaman yang komprehensif tentang masing-masing kategori ini sangat penting bagi profesional kesehatan dalam mengidentifikasi dan melaporkan insiden dengan akurat, serta bagi organisasi dalam mengembangkan strategi pencegahan yang sesuai dengan tingkat risiko dan prioritas. Hubungan antara budaya keselamatan pasien dengan tingkat dan jenis insiden yang terjadi di pelayanan rawat inap menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat mengurangi frekuensi insiden serius dan meningkatkan deteksi serta pelaporan insiden dengan tingkat keparahan lebih rendah yang sering kali menjadi *early warning signs* untuk masalah sistemik yang lebih besar (Kasanah et al., 2025).

a. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

Kejadian Tidak Diharapkan atau *adverse event* merupakan insiden yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada pasien akibat tindakan medis atau kondisi yang terkait dengan proses pelayanan kesehatan, bukan karena penyakit yang mendasari atau kondisi pasien itu sendiri. KTD mencakup berbagai kejadian seperti kesalahan pemberian obat (*medication error*) yang menyebabkan reaksi merugikan pada pasien, infeksi terkait pelayanan kesehatan (*healthcare-associated infections*) seperti infeksi luka operasi atau infeksi aliran darah, komplikasi prosedur medis atau pembedahan yang dapat dicegah, jatuh pasien yang mengakibatkan cedera, *pressure ulcers* atau luka dekubitus yang berkembang selama perawatan, serta kesalahan identifikasi pasien yang berakibat pada prosedur yang salah. KTD merupakan kategori insiden yang paling serius karena telah menyebabkan kerugian aktual pada pasien, dan oleh karena itu memerlukan investigasi mendalam menggunakan metode *root cause analysis* (RCA) atau metode analisis lainnya untuk mengidentifikasi *contributing factors* dan mengembangkan rencana tindakan perbaikan yang komprehensif. Analisis KTD tidak hanya fokus pada *immediate causes* atau kesalahan aktif (*active errors*), tetapi juga mengeksplorasi *latent conditions* atau faktor-faktor tersembunyi dalam sistem yang menciptakan kondisi untuk terjadinya kesalahan, seperti desain proses yang buruk, komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya, atau budaya organisasi yang tidak mendukung praktik aman.

b. Kejadian Nyaris Cedera (KNC)

Kejadian Nyaris Cedera atau *near miss* adalah situasi atau kejadian yang berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien, namun tidak sampai terjadi

karena terdeteksi dan dicegah tepat waktu atau karena faktor keberuntungan. KNC sering kali disebut juga sebagai *close call*, di mana cedera hampir terjadi namun berhasil dihindari di detik-detik terakhir. Contoh KNC meliputi kesalahan dalam persiapan dosis obat yang terdeteksi sebelum diberikan kepada pasien, hampir tertukarnya identitas pasien namun tertangkap sebelum prosedur dilakukan, peralatan medis yang tidak berfungsi dengan baik namun teridentifikasi sebelum digunakan pada pasien, atau situasi di mana pasien hampir jatuh namun dapat ditangkap atau dicegah oleh perawat atau pengunjung. Meskipun KNC tidak mengakibatkan kerugian aktual pada pasien, kejadian ini memiliki nilai yang sangat tinggi dalam program keselamatan pasien karena memberikan *early warning* tentang kelemahan dalam sistem tanpa adanya konsekuensi merugikan. Analisis KNC memungkinkan organisasi untuk belajar dari "*free lessons*" dan mengimplementasikan perbaikan proaktif sebelum kejadian serupa berkembang menjadi KTD. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaporan insiden menunjukkan bahwa KNC sering kali kurang dilaporkan dibandingkan KTD, meskipun nilai pembelajaran dari KNC dapat sama atau bahkan lebih besar, karena frekuensinya yang lebih tinggi dan potensinya dalam mengungkap *systemic weaknesses* (Muda, 2025).

c. Kejadian Tidak Cedera (KTC)

Kejadian Tidak Cedera merupakan insiden yang sudah terjadi dan mencapai pasien, namun tidak mengakibatkan cedera atau kerugian, baik karena keberuntungan atau karena cedera yang mungkin timbul sangat minimal dan tidak signifikan secara klinis. KTC menempati posisi antara KNC dan KTD dalam spektrum insiden keselamatan pasien. Contoh KTC termasuk pemberian obat yang salah namun tidak menimbulkan efek merugikan pada pasien karena karakteristik farmakologis obat yang relatif aman atau kondisi spesifik pasien, terlambatnya pemberian intervensi yang tidak berdampak pada *outcome* klinis pasien, atau kesalahan prosedural minor yang tidak berdampak pada kesehatan pasien. Pelaporan dan analisis KTC penting untuk memahami kelemahan dalam sistem dan proses yang, dalam kondisi berbeda atau pada pasien dengan karakteristik berbeda, dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. KTC memberikan *insight* tentang variabilitas dalam sistem pelayanan dan membantu organisasi mengidentifikasi area yang memerlukan standarisasi atau perbaikan. Evaluasi pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit menunjukkan bahwa KTC sering kali tidak terdokumentasi dengan baik karena dipersepsikan sebagai tidak penting atau

tidak mendesak, padahal analisis agregat dari KTC dapat mengungkap pola masalah sistemik yang memerlukan perhatian (Adnyani et al., 2022).

d. Kondisi Potensial Cedera (KPC)

Kondisi Potensial Cedera atau *hazard* adalah situasi, kondisi, atau keadaan yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera pada pasien di masa mendatang jika tidak segera diidentifikasi dan dikoreksi. KPC berbeda dari ketiga kategori sebelumnya karena belum terjadi sebagai insiden aktual, namun merupakan kondisi yang menciptakan risiko atau meningkatkan probabilitas terjadinya insiden. Contoh KPC mencakup peralatan medis yang rusak atau tidak dikalibrasi dengan benar, kebijakan atau prosedur yang ambigu atau tidak jelas yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda, lingkungan fisik yang tidak aman seperti lantai yang licin atau pencahayaan yang buruk, *staffing* yang tidak memadai yang meningkatkan risiko kelelahan dan kesalahan, sistem penyimpanan obat yang dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahan pemilihan (*look-alike, sound-alike medications*), atau kurangnya pelatihan staf tentang peralatan atau prosedur baru. Identifikasi dan pelaporan KPC merupakan bentuk paling proaktif dari manajemen keselamatan pasien, karena memungkinkan organisasi untuk melakukan intervensi preventif sebelum insiden apapun terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *prospective risk assessment* dan *proactive risk management* yang menjadi ciri organisasi dengan budaya keselamatan yang matang. Mendorong pelaporan KPC memerlukan perubahan paradigma dari *reactive* menjadi *proactive safety culture*, di mana seluruh staf merasa bertanggung jawab dan diberdayakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan kondisi yang berisiko tanpa menunggu terjadinya insiden aktual (Nthumba et al., 2024).

e. Regulasi Nasional dan Internasional tentang Pelaporan Insiden

Regulasi tentang pelaporan insiden keselamatan pasien di tingkat nasional dan internasional memberikan kerangka *legal*, standar, dan panduan bagi organisasi kesehatan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelaporan yang efektif dan akuntabel. Di Indonesia, regulasi nasional tentang keselamatan pasien dan pelaporan insiden telah berkembang secara progresif sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengamanatkan setiap rumah sakit untuk menerapkan standar keselamatan pasien. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien yang menetapkan standar keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kewajiban untuk melakukan pelaporan

dan analisis insiden keselamatan pasien. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) sebagai organisasi profesi juga telah mengembangkan pedoman dan *tools* untuk mendukung implementasi program keselamatan pasien, termasuk sistem pelaporan insiden yang terstandarisasi. Regulasi nasional menekankan pentingnya budaya *just* dan *non-punitive* dalam pelaporan insiden, perlindungan terhadap pelapor dari tindakan disipliner yang tidak adil, serta kewajiban organisasi kesehatan untuk melakukan analisis dan tindak lanjut dari insiden yang dilaporkan. Pengaruh *mentoring* terhadap pelaporan insiden keselamatan pasien menunjukkan bahwa dukungan sistemik, termasuk melalui program *mentoring* yang terstruktur, dapat meningkatkan pemahaman perawat tentang regulasi dan pentingnya *compliance* terhadap standar pelaporan (Silvania & Lisum, 2024).

Di tingkat internasional, berbagai organisasi dan badan regulasi telah mengembangkan *framework* dan standar untuk pelaporan insiden yang menjadi referensi global dalam praktik keselamatan pasien. *World Health Organization* (WHO) melalui program *Patient Safety* telah menerbitkan *International Classification for Patient Safety* (ICPS) yang menyediakan taksonomi terstandarisasi untuk mengklasifikasikan dan melaporkan insiden keselamatan pasien, memfasilitasi perbandingan dan pembelajaran lintas negara. *Joint Commission International* (JCI) dalam standar akreditasinya menetapkan persyaratan komprehensif untuk sistem pelaporan insiden, termasuk *sentinel event policy* yang mengharuskan pelaporan dan investigasi mendalam terhadap kejadian serius. Di Amerika Serikat, berbagai regulasi seperti *Patient Safety and Quality Improvement Act* tahun 2005 memberikan perlindungan *legal* terhadap informasi yang dilaporkan ke *Patient Safety Organizations* (PSOs) untuk mendorong pelaporan yang lebih terbuka. Di Eropa, regulasi seperti EU Patient Safety Directive menekankan pembelajaran lintas negara dari insiden keselamatan pasien. Meskipun berasal dari industri penerbangan, implementasi regulasi seperti CASR Part 830 dalam investigasi kecelakaan di Indonesia menunjukkan bagaimana *framework* investigasi insiden yang sistematis dan berbasis bukti dari sektor dengan *high-reliability* dapat diadaptasi untuk berbagai konteks, termasuk potensial aplikasinya dalam investigasi insiden keselamatan pasien di *healthcare*. Prinsip-prinsip seperti investigasi yang independen, fokus pada faktor sistemik daripada *blame* individual, dan diseminasi pembelajaran untuk pencegahan di masa depan merupakan elemen universal yang relevan lintas sektor (Prabowo et al., 2025).

D. Hubungan antara Quality Improvement dan Patient Safety

1. Integrasi Program Mutu dan Keamanan Pasien

Integrasi antara program *quality improvement* dan keselamatan pasien merupakan pendekatan holistik yang mengakui bahwa kedua aspek ini saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara komprehensif. Keselamatan pasien merupakan fondasi dari kualitas pelayanan kesehatan, dan tidak mungkin mencapai standar mutu yang tinggi jika aspek keselamatan diabaikan atau diperlakukan sebagai program terpisah. Pendekatan terintegrasi ini mengakui bahwa banyak prinsip, metodologi, dan *tools* yang digunakan dalam *quality improvement* dapat dan harus diaplikasikan untuk meningkatkan keselamatan pasien, dan sebaliknya, fokus pada keselamatan pasien berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, integrasi ini dapat diwujudkan melalui penyelarasan struktur organisasi di mana komite atau departemen yang menangani mutu dan keselamatan pasien bekerja secara koordinatif atau bahkan digabungkan, pengembangan indikator kinerja yang mencakup baik dimensi mutu maupun keselamatan, implementasi inisiatif perbaikan yang secara simultan menargetkan peningkatan mutu dan pengurangan risiko keselamatan, serta alokasi sumber daya yang mengoptimalkan dampak terhadap kedua area tersebut. Praktik *Total Quality Management* yang efektif di rumah sakit secara inheren mencakup fokus yang kuat pada keselamatan pasien sebagai komponen integral dari sistem mutu, di mana prinsip-prinsip seperti *patient-centeredness*, *continuous improvement*, dan penggunaan data untuk *decision-making* berlaku sama kuatnya untuk inisiatif keselamatan pasien (Zehir & Zehir, 2023).

Pendekatan *Lean* yang dikombinasikan dengan prinsip *person-centered care* mendemonstrasikan bagaimana metodologi peningkatan mutu dapat secara efektif mengintegrasikan tujuan efisiensi operasional dengan tujuan keselamatan dan kepuasan pasien. Eliminasi *waste* dalam proses pelayanan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi kompleksitas dan peluang untuk terjadinya kesalahan, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap keselamatan pasien. Misalnya, mengurangi waktu tunggu pasien, menyederhanakan proses *handover*, atau mengoptimalkan alur komunikasi antar tim dapat secara simultan meningkatkan kepuasan pasien, efisiensi operasional, dan mengurangi risiko insiden keselamatan. Pengembangan model maturitas peningkatan mutu yang sistemik juga menekankan bahwa organisasi kesehatan yang matang dalam praktik *quality improvement* secara natural mengintegrasikan keselamatan pasien sebagai dimensi fundamental dalam

semua inisiatif perbaikan mereka. Model maturitas ini menunjukkan bahwa evolusi dari pendekatan reaktif terhadap masalah mutu dan keselamatan menuju pendekatan proaktif dan prediktif memerlukan integrasi yang kuat antara sistem, proses, dan budaya yang mendukung baik *quality improvement* maupun keselamatan pasien (Daly et al., 2022; Triana et al., 2023).

Integrasi program mutu dan keselamatan pasien juga tercermin dalam pendekatan komprehensif terhadap manajemen sumber daya manusia keperawatan, di mana kompetensi, motivasi, dan *well-being* perawat dipandang sebagai faktor krusial yang mempengaruhi baik kualitas asuhan maupun keselamatan pasien. Manajemen sumber daya manusia yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan memastikan bahwa perawat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kondisi kerja yang mendukung pemberian asuhan berkualitas tinggi dan praktik aman. Program pelatihan dan pengembangan profesional yang mengintegrasikan konten *quality improvement* dan keselamatan pasien membantu perawat memahami bagaimana upaya perbaikan mutu berkontribusi terhadap keselamatan, dan bagaimana praktik keselamatan yang baik merupakan manifestasi dari asuhan keperawatan berkualitas. Hubungan antara motivasi dan kinerja perawat menunjukkan bahwa perawat yang termotivasi dan bekerja dalam lingkungan yang *supportive* cenderung lebih engaged dalam inisiatif *quality improvement*, lebih waspada terhadap potensi risiko keselamatan, dan lebih proaktif dalam melaporkan dan mengatasi masalah yang dapat mempengaruhi kualitas dan keselamatan pelayanan (Sarila, 2025 ; R. Layli, 2022).

2. Dampak Insiden Keselamatan terhadap Mutu Pelayanan

Insiden keselamatan pasien memiliki dampak yang luas dan multidimensional terhadap mutu pelayanan kesehatan, mempengaruhi tidak hanya *outcome* klinis pasien tetapi juga berbagai aspek operasional, finansial, reputasional, dan budaya organisasi kesehatan. Dampak paling langsung dan serius adalah terhadap kesehatan dan kesejahteraan pasien yang mengalami insiden, di mana *adverse events* dapat mengakibatkan perpanjangan masa rawat inap, komplikasi tambahan yang memerlukan intervensi lebih lanjut, *disability* jangka panjang, atau bahkan kematian yang dapat dicegah. Dari perspektif mutu pelayanan, setiap insiden keselamatan merepresentasikan kegagalan dalam sistem pelayanan untuk memenuhi standar yang diharapkan, mencerminkan *gap* antara praktik aktual dan *best practice*, serta mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses, komunikasi, *teamwork*, atau faktor sistemik lainnya yang memerlukan perhatian dan perbaikan. *Medical errors* dan beban finansial yang ditimbulkannya dalam sistem pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa dampak

insiden tidak terbatas pada domain klinis, tetapi juga menciptakan konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi pasien, institusi kesehatan, dan sistem kesehatan secara keseluruhan (Ahsani-Estahbanati et al., 2022).

Dampak insiden keselamatan terhadap indikator mutu pelayanan keperawatan dapat dilihat pada berbagai level pengukuran. Pada level indikator *outcome*, insiden seperti infeksi terkait pelayanan kesehatan, *pressure ulcers*, atau jatuh pasien secara langsung menurunkan skor kualitas yang dicapai oleh unit atau organisasi, mempengaruhi *benchmarking* dengan institusi lain, dan dapat berdampak pada akreditasi serta reputasi rumah sakit. Pada level indikator proses, insiden sering kali mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap protokol klinis, *guidelines*, atau standar praktik yang telah ditetapkan, menunjukkan perlunya penguatan dalam pelatihan, supervisi, atau sistem *reminder* dan *forcing functions*. Pada level indikator struktur, analisis insiden dapat mengungkap ketidakcukupan dalam sumber daya manusia, peralatan, atau sistem pendukung yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Evaluasi sistem pelaporan insiden keselamatan pasien menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang baik dapat mengidentifikasi pola insiden dan mengintervensi faktor-faktor yang berkontribusi sebelum berdampak lebih luas terhadap mutu pelayanan secara keseluruhan (Toyo et al., 2022).

Hubungan antara budaya keselamatan pasien dan insiden yang terjadi di pelayanan rawat inap mendemonstrasikan bagaimana insiden keselamatan tidak hanya merupakan hasil dari budaya organisasi yang lemah, tetapi juga dapat mempengaruhi dan membentuk budaya tersebut dalam siklus yang berkelanjutan. Insiden yang tidak ditangani dengan baik, tidak dianalisis secara mendalam, atau direspons dengan pendekatan *punitive* dapat merusak kepercayaan staf, menciptakan budaya *blame* dan ketakutan, serta menurunkan transparansi dan pembelajaran organisasi yang pada gilirannya meningkatkan risiko insiden di masa depan dan menurunkan mutu pelayanan secara sistemik. Sebaliknya, organisasi yang merespons insiden dengan pendekatan *just culture*, melakukan investigasi yang menyeluruh, mengimplementasikan perbaikan berbasis bukti, dan mengkomunikasikan pembelajaran dengan efektif dapat mengubah insiden menjadi peluang untuk penguatan budaya keselamatan dan peningkatan mutu. Beberapa aspek dimensi budaya keselamatan pasien, seperti *teamwork*, komunikasi, *leadership support*, dan *non-punitive response to error*, menunjukkan hubungan yang kuat dengan budaya pelaporan dan pada akhirnya dengan kemampuan organisasi untuk belajar dari insiden dan meningkatkan

mutu pelayanan secara berkelanjutan (Kasanah et al., 2025; Wulandari et al., 2023).

3. Peran Data Insiden sebagai Dasar Perbaikan Sistem

Data yang diperoleh dari sistem pelaporan insiden keselamatan pasien merupakan sumber informasi yang sangat berharga untuk mengidentifikasi peluang perbaikan sistem dan mengarahkan inisiatif *quality improvement* yang *evidence-based* dan *targeted*. Data insiden menyediakan *insight* empiris tentang di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa masalah terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan, memungkinkan organisasi untuk bergerak dari asumsi dan persepsi menuju pemahaman yang berbasis data tentang permasalahan aktual yang memerlukan perhatian. Peran data insiden dalam perbaikan sistem mencakup beberapa fungsi kritis: pertama, sebagai sistem *early warning* yang mengidentifikasi area berisiko tinggi atau proses yang rentan terhadap kesalahan sebelum insiden serius terjadi; kedua, sebagai dasar untuk *root cause analysis* dan investigasi mendalam yang mengungkap faktor-faktor *contributing* baik *proximal* maupun *distal*; ketiga, sebagai input untuk *risk assessment* dan prioritas inisiatif perbaikan berdasarkan frekuensi dan severitas insiden; keempat, sebagai mekanisme monitoring efektivitas intervensi yang telah diimplementasikan melalui pengukuran tren insiden sebelum dan sesudah intervensi; dan kelima, sebagai sumber pembelajaran organisasional yang dapat didiseminasikan untuk mencegah kejadian serupa di unit atau departemen lain. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaporan insiden keselamatan pasien menunjukkan bahwa kualitas dan kelengkapan data yang tersedia untuk analisis sangat bergantung pada budaya pelaporan yang kuat, sistem yang *user-friendly*, dan komitmen organisasi terhadap *follow-up* dan *feedback* (Muda, 2025).

Pembelajaran dari organisasi dengan reliabilitas tinggi (*high-reliability organizations*) menunjukkan bahwa *learning tools* yang efektif bergantung pada ketersediaan data insiden yang komprehensif, akurat, dan tepat waktu. Berbagai *tools* seperti *root cause analysis*, *failure mode and effects analysis* (FMEA), *trending* dan analisis pola, serta *comparative analysis* semuanya memerlukan data insiden sebagai input fundamental. Analisis agregat dari data insiden dapat mengungkap pola dan tren yang tidak terlihat dari kasus individual, seperti variasi dalam tingkat insiden antar *shift*, *seasonal patterns*, atau korelasi antara tingkat *staffing* dan frekuensi insiden tertentu. *Systematic review* tentang pembelajaran dari insiden keselamatan di organisasi dengan reliabilitas tinggi menekankan pentingnya tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan mentransformasi data tersebut menjadi *actionable intelligence* yang dapat

menginformasikan keputusan dan perubahan konkret dalam sistem. Organisasi yang efektif dalam pemanfaatan data insiden memiliki kapabilitas analitik yang kuat, tim multidisiplin yang terlatih dalam investigasi insiden, dan proses yang terstruktur untuk menerjemahkan temuan analisis menjadi rekomendasi perbaikan yang spesifik dan terukur (Serou et al., 2021).

Penggunaan metodologi *quality improvement* seperti PDSA, *Lean*, dan *Six Sigma* dalam konteks perbaikan keselamatan pasien sangat bergantung pada data insiden sebagai dasar untuk tahap *Plan* (mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan), tahap *Measure* (mengukur kinerja *baseline*), dan tahap *Study/Analyze* (memahami akar penyebab masalah). Pendekatan *quality improvement* untuk meningkatkan pelaporan insiden serius dalam sistem kesehatan nasional mendemonstrasikan bagaimana data dari sistem pelaporan dapat digunakan tidak hanya untuk perbaikan klinis, tetapi juga untuk meningkatkan sistem pelaporan itu sendiri, menciptakan *feedback loop* positif di mana pelaporan yang lebih baik menghasilkan data yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya memfasilitasi analisis dan perbaikan yang lebih efektif. Evaluasi pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit menunjukkan bahwa utilisasi data yang optimal memerlukan tidak hanya sistem pelaporan yang efektif, tetapi juga kapasitas organisasi dalam *data management*, analisis, dan translasi temuan menjadi tindakan perbaikan konkret. Organisasi yang berhasil dalam memanfaatkan data insiden untuk perbaikan sistem biasanya memiliki infrastruktur teknologi informasi yang mendukung agregasi dan analisis data, *dashboard* yang memvisualisasikan tren dan pola dengan jelas, forum reguler untuk membahas temuan dan mengembangkan rencana aksi, serta mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan diimplementasikan dan dampaknya dievaluasi (Adnyani et al., 2022).

E. Peran Perawat dalam Quality Improvement (QI)

1. Perawat sebagai Frontliner dalam Peningkatan Mutu

Perawat menempati posisi unik dan strategis sebagai *frontliner* dalam sistem pelayanan kesehatan yang menempatkan mereka pada garis terdepan dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sebagai profesional kesehatan yang memiliki kontak paling intensif dan berkelanjutan dengan pasien selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, perawat memiliki kesempatan terbesar untuk mengobservasi kondisi pasien, mengidentifikasi perubahan status kesehatan, mendeteksi potensi masalah atau risiko keselamatan, dan merespons kebutuhan pasien secara *real-time*. Posisi *frontliner* ini memberikan perawat perspektif yang tidak dimiliki oleh profesional kesehatan lain tentang bagaimana

sistem pelayanan berfungsi dalam praktik sehari-hari, di mana terjadi *bottlenecks* atau inefisiensi, bagaimana proses benar-benar dilaksanakan versus bagaimana seharusnya dilaksanakan menurut protokol, dan apa dampak dari berbagai kebijakan atau perubahan sistem terhadap pasien dan alur kerja klinis. Pengetahuan *frontline* yang mendalam ini menjadikan perawat sebagai sumber *intelligence* yang sangat berharga untuk inisiatif *quality improvement*, karena mereka dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen atau administrator, memahami konteks dan nuansa situasi klinis yang mempengaruhi implementasi perubahan, dan memberikan *insights* praktis tentang solusi yang *feasible* dan *sustainable* dalam konteks operasional yang nyata. Pencapaian dan pemeliharaan keselamatan dalam pelayanan kesehatan memerlukan komitmen institusional dan individual yang tidak tergoyahkan, di mana perawat sebagai komponen terbesar dari *workforce* kesehatan memainkan peran krusial dalam mewujudkan komitmen tersebut melalui praktik klinis sehari-hari mereka (Rigamonti & Rigamonti, 2021).

Kontribusi perawat terhadap peningkatan mutu tidak hanya melalui pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam mengidentifikasi peluang perbaikan, mengusulkan solusi inovatif, dan mengimplementasikan perubahan dalam praktik. Perawat yang bekerja di *frontline* memiliki kemampuan unik untuk menghubungkan perspektif pasien dengan perspektif sistem, memahami bagaimana keputusan organisasional berdampak pada pengalaman pasien dan *outcomes* klinis, serta mengadvokasi perubahan yang benar-benar *patient-centered* dan berbasis pada kebutuhan aktual di lapangan. Dalam konteks *quality improvement*, perawat *frontliner* dapat berkontribusi melalui berbagai cara: mengidentifikasi masalah atau *gaps* dalam kualitas pelayanan berdasarkan observasi langsung dan pengalaman klinis, berpartisipasi dalam tim *quality improvement* dengan membawa perspektif praktis dari *frontline*, mengumpulkan data untuk inisiatif perbaikan, menguji dan memberikan *feedback* tentang intervensi atau perubahan proses yang diusulkan, memfasilitasi adopsi *best practices* oleh rekan sejawat, dan memonitor serta melaporkan efektivitas perubahan yang diimplementasikan. Peran *frontliner* ini menjadikan keterlibatan perawat bukan hanya *desirable* tetapi esensial untuk keberhasilan inisiatif *quality improvement*, karena tanpa *buy-in* dan partisipasi aktif dari perawat, perubahan yang dirancang bahkan dengan niat terbaik mungkin tidak efektif atau *sustainable* dalam praktik.

Pengaruh waktu keperawatan dan tingkat *staffing* terhadap kesalahan medikasi mendemonstrasikan bagaimana faktor struktural dan organisasional yang mempengaruhi praktik perawat di *frontline* memiliki dampak langsung

terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Analisis *cross-sectional* terhadap data administratif menunjukkan bahwa ketika perawat memiliki waktu yang adekuat dan tingkat *staffing* yang memadai, mereka lebih mampu untuk melaksanakan praktik aman, melakukan *double-checking* yang diperlukan, berkomunikasi secara efektif dengan tim, dan memberikan perhatian penuh terhadap detail-detail kritis yang mencegah kesalahan. Sebaliknya, kondisi *understaffing* dan beban kerja yang berlebihan meningkatkan risiko kesalahan, kelelahan perawat, dan *burnout* yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap mutu dan keselamatan. Temuan ini menekankan bahwa peran perawat sebagai *frontliner* dalam peningkatan mutu harus didukung oleh kondisi struktural yang memadai, termasuk rasio perawat-pasien yang optimal, alokasi waktu yang cukup untuk tugas-tugas keperawatan esensial, dan sistem pendukung yang memfasilitasi praktik berbasis bukti. Investasi dalam sumber daya keperawatan di *frontline* bukan hanya isu kesejahteraan staf, tetapi merupakan strategi fundamental untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan secara sistemik (Moriwaki et al., 2025).

2. Kontribusi Perawat dalam Audit Klinis dan Continuous Improvement

Audit klinis merupakan komponen penting dalam *continuous improvement* yang memungkinkan evaluasi sistematis terhadap praktik klinis dibandingkan dengan standar atau *best practices* yang telah ditetapkan, identifikasi *gaps* dalam kualitas pelayanan, dan implementasi perubahan untuk meningkatkan *outcomes*. Perawat memiliki peran sentral dalam seluruh siklus audit klinis, mulai dari identifikasi area yang memerlukan audit, pengumpulan dan analisis data, interpretasi temuan, pengembangan rekomendasi perbaikan, implementasi perubahan, hingga re-audit untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan. Kontribusi perawat dalam audit klinis sangat berharga karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang proses klinis yang diaudit, akses langsung ke data yang diperlukan, dan kredibilitas serta *rapport* dengan rekan-rekan *frontline* yang esensial untuk mendorong perubahan praktik. Audit klinis yang dipimpin atau melibatkan perawat secara aktif cenderung lebih relevan dengan isu praktis yang dihadapi di *frontline*, lebih *feasible* dalam implementasinya, dan lebih diterima oleh komunitas perawat yang akan mengadopsi perubahan yang direkomendasikan. Dalam konteks *continuous improvement*, audit klinis bukan merupakan kegiatan *one-time* tetapi bagian dari siklus berkelanjutan di mana standar ditegakkan, praktik dievaluasi secara regular, dan perbaikan diimplementasikan secara iteratif untuk mencapai *excellence* yang berkelanjutan.

a. Audit Dokumentasi Keperawatan untuk Identifikasi Risiko Pasien

Dokumentasi keperawatan merupakan elemen fundamental dari praktik profesional yang tidak hanya memfasilitasi komunikasi dan kontinuitas asuhan, tetapi juga berfungsi sebagai indikator kualitas pelayanan dan mekanisme identifikasi risiko pasien. Audit terhadap kelengkapan dokumentasi keperawatan dapat berfungsi sebagai indikator *outcome* untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami *pressure ulcers*, jatuh, dan kerentanan sosial, memberikan *early warning* yang memungkinkan intervensi preventif dilakukan tepat waktu. Studi observasional menunjukkan bahwa dokumentasi yang lengkap dan akurat tentang pengkajian risiko, rencana asuhan, dan intervensi yang dilakukan berkorelasi dengan *outcomes* pasien yang lebih baik dan insiden yang lebih rendah. Audit dokumentasi dapat mengidentifikasi pola seperti area pengkajian yang sering terlewatkan, inkonsistensi dalam dokumentasi intervensi pencegahan, atau kurangnya dokumentasi tentang edukasi pasien dan keluarga. Temuan dari audit ini kemudian dapat menginformasikan intervensi *targeted* seperti pelatihan tentang pentingnya dokumentasi komprehensif, simplifikasi formulir dokumentasi untuk meningkatkan *compliance*, implementasi *reminders* atau *alerts* dalam sistem elektronik, atau restrukturisasi alur kerja untuk mengalokasikan waktu yang adekuat untuk dokumentasi. Perawat yang terlibat dalam audit dokumentasi tidak hanya mengidentifikasi *gaps*, tetapi juga dapat mengadvokasi perubahan sistem yang memfasilitasi dokumentasi berkualitas, seperti pengurangan dokumentasi yang redundan atau tidak memberikan nilai klinis, integrasi yang lebih baik antar sistem dokumentasi, atau pengembangan *template* yang memandu dokumentasi komprehensif sambil tetap efisien (López et al., 2022).

b. Audit Klinis untuk Peningkatan Kualitas Dokumentasi di Fasilitas Perawatan

Audit klinis yang berfokus pada peningkatan kualitas dokumentasi di fasilitas perawatan jangka panjang atau *residential care homes* mendemonstrasikan bagaimana metodologi audit dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi masalah spesifik dan mendorong perbaikan yang terukur dan berkelanjutan. Proses audit melibatkan penetapan kriteria kualitas dokumentasi yang jelas dan terukur, pengumpulan data tentang praktik dokumentasi saat ini melalui *chart review* atau metode lain, analisis *gap* antara praktik aktual dan standar yang diharapkan, pengembangan dan implementasi intervensi untuk meningkatkan praktik, dan re-audit untuk mengevaluasi dampak intervensi. Perawat yang memimpin atau berpartisipasi dalam audit klinis semacam ini mengembangkan kompetensi penting dalam metodologi

quality improvement, penggunaan data untuk *decision-making*, dan *change management*. Mereka belajar bagaimana mengidentifikasi masalah secara objektif menggunakan data, menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah, merancang intervensi yang *evidence-based*, dan mengevaluasi efektivitas perubahan menggunakan metrik yang terukur. Pengalaman dalam audit klinis juga membangun *ownership* perawat terhadap kualitas praktik mereka, meningkatkan kesadaran tentang standar profesional, dan memfasilitasi budaya *continuous improvement* di mana evaluasi dan perbaikan praktik menjadi bagian integral dari rutinitas kerja. Hasil audit yang menunjukkan peningkatan dalam kualitas dokumentasi tidak hanya meningkatkan *compliance* terhadap standar, tetapi juga berkontribusi terhadap komunikasi yang lebih baik antar tim, kontinuitas asuhan yang lebih efektif, dan kemampuan yang lebih baik untuk mendeteksi dan merespons perubahan kondisi pasien (Moldskred et al., 2021).

c. Audit Intersektoral dan Kolaborasi Multidisiplin dalam Quality Improvement

Ward rounds atau ronde intersektoral yang melibatkan kolaborasi multidisiplin merepresentasikan pendekatan audit dan *quality improvement* yang holistik, di mana berbagai profesional kesehatan dan sosial bekerja bersama untuk mengevaluasi dan meningkatkan asuhan pasien secara komprehensif. Dalam konteks pasien yang dirawat di akomodasi sementara 24 jam atau *setting* kompleks lainnya, ronde intersektoral memungkinkan integrasi perspektif medis, keperawatan, sosial, rehabilitasi, dan lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien secara holistik dan mengembangkan rencana asuhan yang koordinatif. Perawat memainkan peran kunci dalam ronde intersektoral dengan membawa pemahaman mendalam tentang kondisi pasien sehari-hari, respons terhadap intervensi, dinamika keluarga, dan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi asuhan. Partisipasi perawat dalam forum multidisiplin ini juga memfasilitasi pembelajaran *interprofessional*, di mana perawat dan profesional lain saling berbagi pengetahuan dan perspektif, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kontribusi masing-masing, dan membangun *teamwork* yang lebih efektif. Studi kasus tentang implementasi ronde intersektoral menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif ini dapat meningkatkan koordinasi asuhan, mengurangi fragmentasi dalam pelayanan, mengidentifikasi masalah yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan *single-discipline*, dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan *patient-centered*. Kontribusi perawat dalam inisiatif semacam ini mendemonstrasikan bahwa peran mereka dalam *quality improvement* tidak terbatas pada domain keperawatan, tetapi meluas ke

kolaborasi sistem yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Grew et al., 2022).

3. Keterlibatan Perawat dalam Tim Peningkatan Mutu Rumah Sakit

Keterlibatan perawat dalam tim peningkatan mutu rumah sakit merupakan faktor krusial dalam keberhasilan inisiatif *quality improvement*, mengingat perawat tidak hanya merupakan kelompok terbesar dari *workforce* kesehatan tetapi juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang unik tentang operasional klinis, kebutuhan pasien, dan tantangan implementasi di *frontline*. Tim peningkatan mutu yang efektif mengintegrasikan perawat dari berbagai level dan area praktik, memastikan bahwa perspektif *frontline* terwakili dalam *decision-making*, dan memberdayakan perawat untuk berkontribusi secara aktif dalam identifikasi masalah, desain solusi, dan implementasi perubahan. Keterlibatan perawat dalam tim semacam ini memberikan manfaat ganda: bagi organisasi, hal ini meningkatkan relevansi, *feasibility*, dan efektivitas inisiatif perbaikan; bagi perawat, hal ini memberikan kesempatan untuk pengembangan profesional, meningkatkan *engagement* dan kepuasan kerja, serta memperkuat *sense of ownership* terhadap kualitas pelayanan. Tim peningkatan mutu yang inklusif dan memberdayakan perawat juga berkontribusi terhadap transformasi budaya organisasi menuju *culture of excellence*, di mana setiap anggota tim merasa bertanggung jawab dan mampu untuk berkontribusi terhadap peningkatan mutu dan keselamatan.

a. Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik untuk Root Cause Analysis

Implementasi sistem pelaporan elektronik *root cause analysis* (RCA) untuk mengurangi *hospital-acquired pressure injuries* mendemonstrasikan bagaimana perawat dapat memimpin inisiatif teknologi untuk mendukung *quality improvement* dan keselamatan pasien. Sistem elektronik yang dirancang dengan baik dapat menyederhanakan proses pelaporan insiden, memfasilitasi analisis yang lebih sistematis dan mendalam, meningkatkan akuntabilitas dalam tindak lanjut rekomendasi, dan memungkinkan *tracking* tren serta pola insiden dengan lebih efektif. Perawat yang terlibat dalam implementasi sistem semacam ini berkontribusi dalam berbagai cara: memberikan *input* tentang *workflow* pelaporan yang *user-friendly* dan terintegrasi dengan praktik klinis, menguji sistem dalam *pilot* dan memberikan *feedback* untuk perbaikan, melatih rekan-rekan dalam penggunaan sistem, dan mengadvokasi adopsi sistem di unit mereka. Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari adopsi teknologi itu sendiri, tetapi dari dampaknya terhadap *outcome* yang ditargetkan, dalam hal ini penurunan *hospital-*

acquired pressure injuries. Keterlibatan perawat dalam seluruh siklus implementasi, dari perencanaan hingga evaluasi, memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna *frontline* dan berkontribusi terhadap tujuan *quality improvement* yang substantif. Pendekatan ini juga mengilustrasikan pentingnya *change management* yang efektif, di mana perawat tidak hanya sebagai penerima pasif dari perubahan teknologi, tetapi sebagai *champions* yang aktif mendukung dan memfasilitasi transformasi (Armstrong, 2023).

b. Pendidikan Root Cause Analysis untuk Perawat dan Mahasiswa Keperawatan

Perbandingan efek antara pendidikan tradisional dan pendidikan *root cause analysis* terhadap sikap mahasiswa keperawatan tentang budaya keselamatan dan pengetahuan tentang praktik administrasi obat yang aman menunjukkan pentingnya mengintegrasikan metodologi *quality improvement* dalam pendidikan keperawatan. Pendidikan RCA yang mengajarkan mahasiswa keperawatan untuk menganalisis insiden secara sistematis, mengidentifikasi *contributing factors* baik *proximal* maupun *distal*, dan mengembangkan rekomendasi perbaikan berbasis bukti tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk *mindset* dan sikap yang mendukung budaya keselamatan. Mahasiswa yang terpapar pada pendidikan RCA mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas sistem kesehatan, peran faktor sistemik dalam insiden keselamatan, dan pentingnya pendekatan *non-punitive* dalam pembelajaran dari kesalahan. Mereka juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang esensial untuk praktik profesional yang aman dan berkualitas. Investasi dalam pendidikan RCA untuk mahasiswa keperawatan mempersiapkan *next generation* perawat yang tidak hanya kompeten dalam praktik klinis, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam *quality improvement* dan keselamatan pasien sejak awal karir mereka. Bagi perawat yang sudah berpraktik, pendidikan RCA merupakan komponen penting dari pengembangan profesional berkelanjutan yang meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi efektif dalam tim peningkatan mutu, memimpin investigasi insiden, dan mengimplementasikan perubahan berbasis bukti (Miller, 2021).

c. Program Zero Harm untuk Pencegahan Jatuh Pasien

Desain dan implementasi program *Zero Harm* untuk pencegahan jatuh merepresentasikan pendekatan komprehensif terhadap *quality improvement* yang menargetkan eliminasi *harm* yang dapat dicegah melalui strategi multifaset yang melibatkan perawat di semua level. Program *Zero Harm*

menetapkan *aspirational goal* yang ambisius namun memberikan arah yang jelas dan memotivasi untuk upaya perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks pencegahan jatuh, program ini biasanya mencakup komponen-komponen seperti pengkajian risiko jatuh yang komprehensif dan terstandarisasi, stratifikasi pasien berdasarkan tingkat risiko, implementasi intervensi pencegahan yang *evidence-based* dan disesuaikan dengan tingkat risiko individual pasien, modifikasi lingkungan untuk mengurangi hazards, edukasi pasien dan keluarga tentang risiko jatuh dan strategi pencegahan, penggunaan teknologi seperti *bed alarms* atau sistem monitoring, *rounding* yang terstruktur dan regular, serta budaya di mana semua anggota tim merasa bertanggung jawab untuk keselamatan pasien. Perawat memainkan peran sentral dalam setiap komponen program ini, dari melakukan pengkajian risiko hingga mengimplementasikan intervensi pencegahan dalam praktik sehari-hari. Keterlibatan perawat dalam desain program memastikan bahwa strategi yang dikembangkan *feasible* dan *sustainable* dalam konteks operasional *frontline*, sementara keterlibatan mereka dalam implementasi dan monitoring memastikan *fidelity* dan kontinuitas program. Evaluasi program *Zero Harm* biasanya melibatkan *tracking* metrik seperti *rate* jatuh, jatuh dengan cedera, *compliance* terhadap protokol pencegahan, dan kepuasan pasien dengan strategi keselamatan, memberikan data objektif tentang efektivitas program dan area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut (Wilson et al., 2022).

F. Peran Perawat dalam Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

1. Pentingnya Pelaporan Insiden bagi Praktik Keperawatan Aman

Pelaporan insiden keselamatan pasien merupakan elemen fundamental dari praktik keperawatan yang aman dan profesional, berfungsi sebagai mekanisme kritis untuk identifikasi, pembelajaran, dan pencegahan *harm* yang dapat dihindari dalam sistem pelayanan kesehatan. Pentingnya pelaporan insiden bagi praktik keperawatan tidak dapat dilebih-lebihkan, karena perawat sebagai *frontlineryang* memiliki kontak paling intensif dengan pasien berada dalam posisi unik untuk mendeteksi insiden pada tahap paling awal, memahami konteks di mana insiden terjadi, dan memberikan informasi *first-hand* yang kaya detail untuk analisis dan pembelajaran. Pelaporan yang komprehensif dan jujur memungkinkan organisasi kesehatan untuk mengidentifikasi pola dan tren insiden, memahami *root causes* dan *contributing factors*, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pencegahan yang *evidence-based*, dan memonitor efektivitas intervensi yang dilakukan. Tanpa pelaporan yang robust dari perawat, organisasi kehilangan visibilitas terhadap masalah keselamatan

yang sesungguhnya terjadi di *frontline*, mengakibatkan *missed opportunities* untuk pembelajaran dan perbaikan yang dapat mencegah *harm* di masa depan. Pelaporan insiden juga merupakan tanggung jawab etis dan profesional perawat yang tidak hanya melindungi pasien saat ini, tetapi juga pasien-pasien di masa mendatang yang dapat terhindar dari insiden serupa jika pembelajaran dari laporan ditindaklanjuti dengan efektif.

a. Komitmen Institusional dan Individual terhadap Keselamatan

Pencapaian dan pemeliharaan keselamatan dalam pelayanan kesehatan memerlukan komitmen yang tidak tergoyahkan baik di level institusional maupun individual, di mana komitmen kedua level ini saling memperkuat dan esensial untuk menciptakan budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan. Pada level institusional, komitmen terhadap keselamatan harus tercermin dalam alokasi sumber daya yang memadai untuk program keselamatan pasien, pengembangan kebijakan dan sistem yang mendukung praktik aman, investasi dalam pelatihan dan pendidikan staf, penciptaan infrastruktur untuk pelaporan dan analisis insiden, serta *leadership* yang konsisten memprioritaskan keselamatan dalam semua keputusan organisasional. Institusi yang berkomitmen terhadap keselamatan menciptakan lingkungan di mana pelaporan insiden didorong dan dihargai, di mana kesalahan dipandang sebagai peluang pembelajaran sistemik daripada alasan untuk menyalahkan individu, dan di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi norma budaya. Pada level individual, komitmen perawat terhadap keselamatan tercermin dalam vigilance terhadap potensi risiko, kepatuhan terhadap protokol dan *best practices*, kemauan untuk berbicara (*speak up*) ketika melihat praktik yang tidak aman, partisipasi aktif dalam inisiatif keselamatan, dan yang paling penting, konsistensi dalam melaporkan insiden termasuk *near misses* dan *unsafe conditions*. Komitmen individual ini harus didukung dan difasilitasi oleh komitmen institusional, menciptakan sinergi di mana perawat merasa diberdayakan dan didukung untuk memprioritaskan keselamatan dalam praktik mereka, dan institusi menyediakan sistem serta budaya yang memungkinkan komitmen tersebut terwujud dalam tindakan konkret (Rigamonti & Rigamonti, 2021).

b. Pengaruh Waktu dan Staffing terhadap Keselamatan Praktik Keperawatan

Pengaruh waktu keperawatan dan tingkat *staffing* terhadap kesalahan medikasi mengilustrasikan bagaimana faktor struktural dan organisasional memiliki dampak langsung terhadap kemampuan perawat untuk melaksanakan praktik aman dan melaporkan insiden dengan efektif. Analisis *cross-sectional* terhadap data administratif menunjukkan korelasi yang

signifikan antara adekuasi waktu dan *staffing* dengan *rate* kesalahan medikasi, di mana kondisi *understaffing* dan waktu yang terbatas meningkatkan tekanan waktu, mengurangi kesempatan untuk *double-checking* dan verifikasi, membatasi komunikasi yang efektif antar tim, dan meningkatkan kelelahan yang pada gilirannya meningkatkan risiko kesalahan. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk pelaporan insiden, karena perawat yang bekerja dalam kondisi *staffing* yang tidak memadai tidak hanya menghadapi risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam insiden, tetapi juga mungkin tidak memiliki waktu untuk melaporkan insiden yang terjadi karena harus memprioritaskan tugas-tugas klinis yang mendesak. Hal ini menciptakan *vicious cycle* di mana kondisi kerja yang buruk meningkatkan insiden namun menurunkan pelaporan, mengakibatkan *underestimation* masalah dan respon organisasional yang tidak memadai. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pelaporan insiden harus disertai dengan perhatian terhadap kondisi kerja perawat, termasuk memastikan *staffing* yang adekuat, alokasi waktu yang cukup untuk tugas-tugas keselamatan termasuk pelaporan, dan sistem pendukung yang meminimalkan beban administratif yang tidak perlu. Investasi dalam kondisi kerja yang mendukung tidak hanya merupakan isu kesejahteraan staf, tetapi merupakan strategi fundamental untuk meningkatkan keselamatan pasien dan efektivitas sistem pelaporan insiden (Moriwaki et al., 2025).

2. Mekanisme dan Alur Pelaporan Insiden di Unit Keperawatan

Mekanisme dan alur pelaporan insiden di unit keperawatan harus dirancang untuk memfasilitasi pelaporan yang mudah, cepat, dan komprehensif, sambil memastikan bahwa informasi yang dilaporkan ditindaklanjuti dengan efektif untuk pembelajaran dan perbaikan sistem. Alur pelaporan yang efektif biasanya dimulai dengan identifikasi insiden oleh perawat atau anggota tim lain, diikuti dengan stabilisasi pasien dan mitigasi *harm* jika diperlukan, kemudian dokumentasi insiden melalui sistem pelaporan yang tersedia (baik elektronik maupun *paper-based*), notifikasi kepada supervisor atau manajer unit, dan eskalasi ke tim keselamatan pasien atau komite terkait untuk analisis dan tindak lanjut. Sistem pelaporan yang baik memiliki karakteristik seperti aksesibilitas (tersedia dengan mudah bagi semua staf), kesederhanaan (formulir atau antarmuka yang tidak terlalu kompleks), fleksibilitas (memungkinkan pelaporan berbagai jenis insiden), *confidentiality* (melindungi identitas pelapor jika diinginkan), *timeliness* (memungkinkan pelaporan segera setelah insiden terjadi), dan *responsiveness* (memberikan *feedback* kepada pelapor tentang tindak lanjut yang dilakukan). Alur pelaporan juga harus jelas mendefinisikan tanggung jawab

di setiap tahap, *timeline* untuk tindak lanjut, dan kriteria untuk eskalasi berdasarkan severitas insiden. Transparansi tentang apa yang terjadi setelah insiden dilaporkan sangat penting untuk membangun kepercayaan staf terhadap sistem pelaporan dan memotivasi pelaporan berkelanjutan.

Root cause analysis untuk memahami insiden keselamatan pasien dalam *placement* mahasiswa keperawatan melalui analisis konten kualitatif mendemonstrasikan pentingnya memahami mekanisme insiden tidak hanya untuk perawat praktisi tetapi juga untuk mahasiswa yang sedang belajar. Studi ini mengidentifikasi bahwa insiden yang melibatkan mahasiswa keperawatan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya supervisi yang memadai, *knowledge* atau *skill deficit*, komunikasi yang tidak efektif dengan preceptor atau tim, atau sistem yang tidak mengakomodasi status mahasiswa dalam desain *safety checks*. Pemahaman tentang mekanisme insiden yang spesifik untuk mahasiswa ini penting untuk merancang alur pelaporan dan *follow-up* yang sesuai, yang tidak hanya fokus pada pembelajaran untuk mahasiswa yang terlibat tetapi juga pada perbaikan sistem supervisi dan pendidikan klinis. Mekanisme pelaporan untuk insiden yang melibatkan mahasiswa harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran tidak terkompromikan oleh ketakutan akan konsekuensi negatif, sambil tetap mempertahankan akuntabilitas dan standar keselamatan yang tinggi. Hal ini memerlukan *balance* antara menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman untuk membuat kesalahan (*psychologically safe learning environment*) dengan menjaga keselamatan pasien sebagai prioritas utama (Ropero-Padilla et al., 2022).

Pendekatan berbasis bukti untuk mengurangi *near miss medication events* mengilustrasikan bagaimana data dari sistem pelaporan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola masalah dan mengembangkan intervensi yang *targeted* dan efektif. *Near miss* dalam konteks medikasi adalah situasi di mana kesalahan hampir terjadi atau terjadi namun tertangkap sebelum obat diberikan kepada pasien, memberikan kesempatan untuk pembelajaran tanpa *harm* aktual pada pasien. Mekanisme pelaporan yang mendorong pelaporan *near miss* sangat berharga karena frekuensi *near miss* biasanya jauh lebih tinggi daripada *adverse events*, memberikan lebih banyak data untuk analisis pola dan tren. Alur pelaporan *near miss* harus menekankan bahwa pelaporan tersebut adalah hal positif yang menunjukkan *vigilance* dan berfungsinya *safety checks* dalam sistem, bukan indikasi dari kegagalan atau kesalahan yang perlu dihukum (Smith-Love, 2022).

3. Keterlibatan Perawat dalam Analisis RCA (Root Cause Analysis)

Keterlibatan perawat dalam *Root Cause Analysis* (RCA) merupakan komponen krusial dari sistem pembelajaran organisasional yang efektif, di mana perawat tidak hanya sebagai sumber informasi tentang insiden tetapi sebagai partisipan aktif dalam proses analisis dan pengembangan solusi. RCA adalah metodologi sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari terjadinya insiden, mengeksplorasi tidak hanya *immediate causes* atau kesalahan aktif yang jelas terlihat, tetapi juga *latent conditions* atau faktor sistemik yang menciptakan kondisi untuk terjadinya kesalahan. Partisipasi perawat dalam RCA memberikan nilai tambah yang signifikan karena mereka dapat memberikan konteks *frontline* yang kaya tentang bagaimana pekerjaan sesungguhnya dilakukan (*work-as-done*) versus bagaimana seharusnya dilakukan menurut prosedur (*work-as-imagined*), mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual atau *workarounds* yang mungkin tidak terlihat oleh investigator eksternal, dan memberikan *insights* tentang *feasibility* dan *acceptability* dari solusi yang diusulkan. Keterlibatan perawat dalam RCA juga memiliki manfaat edukasional, mengembangkan pemahaman mereka tentang *systems thinking*, kompleksitas insiden keselamatan, dan pentingnya pendekatan *non-punitive* dalam pembelajaran dari kesalahan.

a. Root Cause Analysis dalam Konteks Pendidikan Keperawatan

Aplikasi *root cause analysis* untuk memahami insiden keselamatan pasien dalam *placements* mahasiswa keperawatan melalui analisis konten kualitatif mendemonstrasikan bagaimana metodologi RCA dapat diadaptasi untuk konteks pendidikan klinis dengan tujuan pembelajaran dan perbaikan sistemik. RCA dalam konteks mahasiswa keperawatan perlu mempertimbangkan faktor-faktor unik seperti tingkat kompetensi dan pengalaman mahasiswa, kualitas dan konsistensi supervisi klinis, kejelasan ekspektasi dan batasan praktik mahasiswa, efektivitas orientasi mahasiswa terhadap unit dan sistem, serta integrasi mahasiswa dalam tim dan *workflow* unit. Analisis kualitatif mengungkapkan bahwa insiden yang melibatkan mahasiswa sering kali memiliki *contributing factors* yang kompleks di mana interaksi antara karakteristik mahasiswa, kualitas supervisi, dan faktor sistemik berperan. Misalnya, mahasiswa mungkin tidak merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan atau mengakui ketidakpastian karena budaya unit atau *preceptor*, sistem mungkin tidak memiliki *checks* yang mempertimbangkan keterlibatan mahasiswa, atau komunikasi antara institusi pendidikan dan klinik mungkin tidak optimal. Temuan RCA ini kemudian menginformasikan perbaikan yang *multifaceted*, termasuk peningkatan kualitas program *preceptorship*, pengembangan sistem

yang lebih eksplisit mengakomodasi mahasiswa, peningkatan komunikasi antara akademik dan klinik, dan pengembangan budaya yang mendukung mahasiswa untuk *speak up* tentang keterbatasan atau ketidakpastian mereka (Ropero-Padilla et al., 2022).

b. Strategi Root Cause Analysis untuk Pencegahan Jatuh Pasien

Root cause analysis dan strategi untuk mengurangi jatuh di antara pasien rawat inap di fasilitas kesehatan melalui *narrative review* menyediakan *overview* komprehensif tentang bagaimana RCA dapat diaplikasikan untuk salah satu insiden keselamatan pasien yang paling umum dan *costly*. Jatuh pasien merupakan fenomena multifaktorial yang dapat disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor intrinsik pasien (usia, kondisi medis, medikasi, mobilitas, kognitif), faktor ekstrinsik atau lingkungan (desain lantai, pencahayaan, *bed height*, *footwear*), dan faktor sistem atau proses (pengkajian risiko, komunikasi, *staffing*, *rounding*, respons terhadap *call bells*). RCA untuk insiden jatuh mengeksplorasi semua dimensi ini untuk mengidentifikasi *contributing factors* spesifik dalam kasus individual dan pola *contributing factors* dalam kasus agregat. Strategi pencegahan yang dikembangkan dari temuan RCA biasanya bersifat *multifaceted* dan *multilevel*, mencakup intervensi pada level pasien (pengkajian risiko komprehensif, intervensi *tailored* berdasarkan faktor risiko individual, edukasi pasien dan keluarga), level lingkungan (modifikasi *physical environment* untuk mengurangi *hazards*, penggunaan *assistive devices*, optimalisasi pencahayaan), dan level sistem (protokol pengkajian dan intervensi yang terstandarisasi, *hourly rounding*, *handoff* komunikasi yang efektif, *staffing* yang adekuat, budaya keselamatan yang kuat). Keterlibatan perawat dalam RCA jatuh sangat penting karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi risiko jatuh dalam praktik sehari-hari, dapat memberikan *input* tentang *feasibility* intervensi yang diusulkan, dan merupakan *key implementers* dari strategi pencegahan (Lakbala et al., 2024).

c. Model Root Cause Analysis untuk Masalah Spesifik dalam Sistem Kesehatan

Model *5-step root cause analysis* untuk *overutilization* tes laboratorium mendemonstrasikan bagaimana kerangka kerja RCA yang terstruktur dapat diaplikasikan untuk masalah *quality* dan *efficiency* dalam sistem kesehatan, tidak hanya untuk insiden keselamatan pasien yang jelas. *Overutilization* atau penggunaan berlebihan dari tes diagnostik merupakan isu mutu yang penting karena berkontribusi terhadap biaya kesehatan yang tidak perlu, potensi *harm* dari tes yang tidak diperlukan atau *follow-up* dari hasil positif palsu, dan inefisiensi dalam sistem. Model 5-langkah untuk RCA biasanya mencakup:

- 1) identifikasi masalah dan *scope* analisis,
- 2) pengumpulan data dan informasi tentang proses saat ini,
- 3) identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah melalui berbagai metode seperti *fishbone diagram*, *5 whys*, atau analisis *Swiss cheese*,
- 4) pengembangan rekomendasi perbaikan yang mengatasi *root causes* yang diidentifikasi, dan
- 5) implementasi dan monitoring efektivitas intervensi.

Aplikasi model ini untuk *overutilization* tes transferrin plasma mengidentifikasi berbagai *contributing factors* seperti kurangnya *guidelines* yang jelas tentang indikasi tes, *ordering* yang berbasis kebiasaan daripada evidensi klinis, kurangnya *feedback* kepada klinisi tentang pola *ordering* mereka, atau sistem *ordering* yang tidak memfasilitasi *decision support*. Solusi yang dikembangkan kemudian *targeted* untuk mengatasi faktor-faktor spesifik ini, seperti pengembangan dan diseminasi *guidelines*, implementasi *clinical decision support* dalam sistem *ordering* elektronik, *audit and feedback* untuk klinisi, atau edukasi tentang *appropriate use*. Perawat dapat terlibat dalam RCA untuk isu seperti ini baik sebagai anggota tim analisis maupun sebagai *implementers* dari solusi, terutama dalam konteks di mana perawat memiliki peran dalam *ordering* tes atau dalam edukasi klinisi lain (Jittapranerat & Chinswangwatanakul, 2024).

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Insiden oleh Perawat

1. Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi Perawat

Pengetahuan perawat mengenai sistem pelaporan insiden keselamatan pasien merupakan fondasi penting dalam mendorong praktik pelaporan yang efektif di lingkungan pelayanan kesehatan. Pemahaman yang komprehensif tentang definisi insiden, prosedur pelaporan, serta tujuan dari sistem pelaporan akan membentuk landasan kognitif yang memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi kejadian yang perlu dilaporkan dan melaksanakan pelaporan sesuai dengan protokol yang berlaku. Keterbatasan pengetahuan sering kali menjadi hambatan signifikan yang menyebabkan *underreporting*, di mana perawat tidak mengenali situasi tertentu sebagai insiden yang harus dilaporkan atau tidak memahami mekanisme pelaporan yang tersedia di institusi mereka (Beecham et al., 2025).

Sikap perawat terhadap pelaporan insiden mencerminkan kecenderungan evaluatif yang dapat bersifat positif maupun negatif terhadap praktik pelaporan. Sikap positif ditandai dengan keyakinan bahwa pelaporan insiden merupakan

tanggung jawab profesional yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang, sementara sikap negatif dapat muncul dari persepsi bahwa pelaporan akan menghasilkan konsekuensi yang merugikan bagi pelapor. Faktor-faktor yang membentuk sikap ini meliputi pengalaman pribadi dengan sistem pelaporan, pengaruh rekan kerja, serta respons organisasi terhadap laporan yang telah disampaikan sebelumnya, yang secara kumulatif akan menentukan apakah perawat memandang pelaporan sebagai kegiatan yang bermanfaat atau justru berisiko (Al-Roomi et al., 2024).

Persepsi perawat tentang konsekuensi pelaporan insiden memainkan peran krusial dalam keputusan mereka untuk melaporkan atau tidak melaporkan kejadian yang mereka alami atau saksikan. Ketakutan akan hukuman, stigmatisasi, atau dampak negatif terhadap reputasi profesional sering kali menjadi penghalang utama yang menyebabkan perawat memilih untuk tidak melaporkan insiden, meskipun mereka menyadari pentingnya pelaporan tersebut. Persepsi ini dipengaruhi oleh budaya organisasi yang ada, di mana lingkungan yang mendukung dan non-punitif akan membentuk persepsi positif bahwa pelaporan adalah bagian dari pembelajaran organisasi, sedangkan lingkungan yang cenderung menyalahkan individu akan memperkuat persepsi negatif dan menghambat transparansi dalam pelaporan (Desty, 2025).

2. Dukungan Manajemen dan Lingkungan Organisasi

Dukungan manajemen dan lingkungan organisasi yang kondusif merupakan elemen fundamental dalam membangun sistem pelaporan insiden yang efektif di institusi pelayanan kesehatan. Manajemen memiliki peran strategis dalam menciptakan infrastruktur, kebijakan, dan iklim kerja yang mendorong perawat untuk melaporkan insiden tanpa rasa takut atau khawatir akan konsekuensi negatif. Lingkungan organisasi yang suportif tidak hanya menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses, tetapi juga memastikan bahwa setiap laporan ditanggapi dengan serius, dianalisis secara objektif, dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan (Ali Ali et al., 2022).

a. Komitmen Kepemimpinan terhadap Keselamatan Pasien

Komitmen kepemimpinan yang nyata terhadap keselamatan pasien ditunjukkan melalui alokasi sumber daya yang memadai untuk sistem pelaporan insiden, pengembangan kebijakan yang jelas dan komprehensif, serta keterlibatan aktif pimpinan dalam program-program keselamatan pasien. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya memberikan dukungan verbal tetapi juga mengimplementasikan tindakan konkret seperti pelatihan rutin, evaluasi

sistem pelaporan, dan pemberian umpan balik konstruktif kepada staf yang melaporkan insiden, sehingga menciptakan persepsi bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama organisasi.

b. Ketersediaan Sistem Pelaporan yang Mudah Diakses

Sistem pelaporan yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan akses, kesederhanaan prosedur, dan kejelasan mekanisme yang memungkinkan perawat melaporkan insiden dengan cepat dan efisien tanpa mengganggu alur kerja klinis mereka. Sistem pelaporan yang user-friendly, baik dalam format elektronik maupun manual, dengan formulir yang tidak terlalu rumit dan dapat diakses kapan saja, akan meningkatkan tingkat partisipasi perawat dalam melaporkan insiden karena mengurangi hambatan teknis dan administratif yang sering menjadi alasan untuk tidak melaporkan.

c. Umpan Balik dan Tindak Lanjut yang Konstruktif

Pemberian umpan balik yang tepat waktu dan konstruktif terhadap laporan insiden yang disampaikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi motivasi perawat untuk terus melaporkan kejadian di masa mendatang. Organisasi yang secara konsisten memberikan informasi tentang hasil investigasi, tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan, serta pembelajaran yang diperoleh dari insiden yang dilaporkan, akan menciptakan siklus umpan balik positif yang memperkuat perilaku pelaporan dan menunjukkan bahwa setiap laporan memiliki nilai dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan (da Brás et al., 2023).

3. Budaya Non-Blaming dan Komunikasi Terbuka

Budaya non-blaming dan komunikasi terbuka merupakan karakteristik esensial dari budaya keselamatan pasien yang matang, di mana fokus organisasi bergeser dari mencari siapa yang bersalah ketika terjadi insiden menjadi memahami mengapa insiden tersebut dapat terjadi dan bagaimana sistem dapat diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pendekatan ini mengakui bahwa kesalahan dalam pelayanan kesehatan sering kali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor manusia, sistem, dan lingkungan kerja, sehingga respons organisasi yang punitif terhadap pelapor justru akan menghambat transparansi dan pembelajaran organisasi yang sangat diperlukan untuk peningkatan keselamatan pasien berkelanjutan (Canali et al., 2025).

a. Pendekatan Sistem dalam Analisis Insiden

Pendekatan sistem dalam menganalisis insiden keselamatan pasien menekankan pada identifikasi faktor-faktor latent dan kondisi yang

memfasilitasi terjadinya kesalahan, seperti beban kerja yang berlebihan, protokol yang ambigu, komunikasi yang tidak efektif, atau keterbatasan sumber daya, daripada semata-mata menyalahkan individu yang terlibat langsung dalam insiden. Organisasi yang mengadopsi pendekatan sistem akan melakukan root cause analysis yang komprehensif untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses dan struktur organisasi, sehingga solusi yang dihasilkan bersifat sistemik dan preventif, bukan hanya reaktif terhadap individu tertentu.

b. Komunikasi Terbuka Antar Staf dan Manajemen

Komunikasi terbuka yang didukung oleh manajemen menciptakan lingkungan di mana perawat merasa aman untuk mengungkapkan kekhawatiran, melaporkan near miss, dan mendiskusikan kesalahan tanpa takut akan retribusi atau penilaian negatif dari rekan kerja maupun atasan. Komunikasi yang efektif dalam konteks keselamatan pasien tidak hanya bersifat vertikal dari manajemen ke staf, tetapi juga horizontal antar rekan kerja dan multidisipliner antar departemen, sehingga informasi tentang risiko dan insiden dapat mengalir dengan bebas dan digunakan untuk pembelajaran kolektif yang meningkatkan kewaspadaan dan responsivitas seluruh tim terhadap potensi bahaya.

c. Pembelajaran Organisasi dari Insiden yang Dilaporkan

Pembelajaran organisasi yang efektif dari insiden yang dilaporkan melibatkan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mendiseminasikan informasi tentang insiden kepada seluruh staf melalui mekanisme seperti briefing keselamatan, bulletin, pelatihan, atau diskusi kasus, sehingga pengetahuan yang diperoleh dari satu kejadian dapat mencegah terulangnya insiden serupa di unit atau departemen lain. Organisasi yang berhasil mentransformasi data pelaporan insiden menjadi pembelajaran yang bermakna akan menunjukkan penurunan tingkat insiden dari waktu ke waktu, peningkatan awareness staf terhadap risiko, dan pengembangan budaya proaktif yang mengantisipasi masalah sebelum berkembang menjadi kejadian yang merugikan pasien (Ferorelli et al., 2022).

H. Strategi Peningkatan Kepatuhan Pelaporan dan Quality Improvement

1. Penguatan Kompetensi dan Pelatihan Perawat

Penguatan kompetensi perawat melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan merupakan strategi fundamental dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan insiden keselamatan pasien di institusi pelayanan kesehatan. Pelatihan yang komprehensif tidak hanya mencakup aspek teknis

tentang cara mengisi formulir pelaporan atau menggunakan sistem elektronik, tetapi juga harus membangun pemahaman mendalam tentang konsep keselamatan pasien, jenis-jenis insiden yang perlu dilaporkan, pentingnya pelaporan untuk pembelajaran organisasi, serta keterampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko dalam praktik klinis sehari-hari. Program pelatihan yang efektif akan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti workshop interaktif, simulasi kasus, diskusi kelompok, dan studi kasus nyata yang memungkinkan perawat untuk tidak hanya memahami konsep secara teoritis tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi klinis yang kompleks dan dinamis (Kakemam et al., 2021).

Keberlanjutan program pelatihan melalui mekanisme refreshment training, update reguler tentang kebijakan dan prosedur terbaru, serta integrasi materi keselamatan pasien dalam program orientasi staf baru dan pengembangan profesional berkelanjutan akan memastikan bahwa kompetensi perawat dalam pelaporan insiden tetap terjaga dan berkembang seiring dengan evolusi sistem pelayanan kesehatan. Evaluasi efektivitas pelatihan melalui pre-test dan post-test, observasi praktik klinis, serta analisis peningkatan jumlah dan kualitas laporan yang disampaikan akan memberikan data objektif tentang dampak program pelatihan terhadap perilaku pelaporan, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan lebih lanjut sehingga strategi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing unit atau departemen dalam organisasi (Smit & Peddle, 2025).

2. Sistem Umpan Balik dan Evaluasi Pelaporan Insiden

Sistem umpan balik dan evaluasi pelaporan insiden yang terstruktur dan responsif merupakan komponen krusial dalam mempertahankan motivasi perawat untuk terus melaporkan insiden serta meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan. Umpan balik yang efektif tidak hanya memberikan konfirmasi bahwa laporan telah diterima, tetapi juga mengkomunikasikan hasil analisis insiden, tindakan perbaikan yang telah atau akan diimplementasikan, serta pembelajaran yang dapat diambil dari kejadian tersebut, sehingga perawat memahami bahwa kontribusi mereka dalam melaporkan insiden memiliki dampak nyata terhadap peningkatan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Sistem yang komprehensif akan mencakup mekanisme umpan balik dalam berbagai tingkatan, mulai dari umpan balik individual kepada pelapor, disseminasi pembelajaran kepada seluruh staf, hingga pelaporan berkala tentang tren insiden dan perbaikan sistem kepada manajemen dan komite keselamatan pasien (Viana et al., 2021).

a. Mekanisme Umpan Balik Tepat Waktu kepada Pelapor

Pemberian umpan balik yang tepat waktu, idealnya dalam waktu 48-72 jam setelah laporan disampaikan, akan menunjukkan bahwa organisasi menghargai upaya pelapor dan menganggap serius setiap laporan yang masuk, sehingga memperkuat perilaku positif dalam melaporkan insiden. Umpan balik yang cepat dan spesifik tidak hanya meningkatkan kepuasan pelapor tetapi juga membangun kepercayaan terhadap sistem pelaporan, karena perawat melihat bahwa laporan mereka tidak hilang dalam birokrasi administratif tetapi ditindaklanjuti dengan serius dan profesional, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk terus melaporkan kejadian di masa mendatang.

b. Diseminasi Pembelajaran dari Analisis Insiden

Penyebaran hasil pembelajaran dari analisis insiden kepada seluruh staf melalui berbagai saluran komunikasi seperti safety briefing, newsletter keselamatan pasien, bulletin board, atau platform digital internal akan memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari satu kejadian dapat mencegah terulangnya insiden serupa di unit atau shift lain. Diseminasi yang efektif harus menyampaikan informasi dalam format yang mudah dipahami, relevan dengan praktik klinis, dan actionable, sehingga staf dapat langsung mengimplementasikan rekomendasi perbaikan dalam pekerjaan sehari-hari mereka tanpa memerlukan interpretasi atau klarifikasi tambahan yang dapat menghambat aplikasi pembelajaran.

c. Evaluasi Berkala terhadap Sistem Pelaporan

Evaluasi sistematis dan berkala terhadap efektivitas sistem pelaporan insiden, mencakup analisis kuantitatif seperti jumlah laporan yang masuk, jenis insiden yang dilaporkan, waktu respons, serta analisis kualitatif seperti kualitas laporan, hambatan yang dihadapi pelapor, dan kepuasan pengguna sistem, akan memberikan data komprehensif untuk continuous improvement sistem pelaporan. Evaluasi yang melibatkan partisipasi perawat sebagai end-user sistem akan mengidentifikasi gap antara desain sistem dengan kebutuhan praktis di lapangan, sehingga perbaikan yang dilakukan benar-benar responsif terhadap tantangan nyata yang dihadapi perawat dan meningkatkan usability serta efektivitas sistem secara keseluruhan.

3. Peran Supervisi Klinis dan Kepemimpinan Kepala Ruangan

Supervisi klinis yang efektif dan kepemimpinan kepala ruangan yang suportif merupakan faktor determinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaporan insiden keselamatan pasien di tingkat unit pelayanan.

Kepala ruangan memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara manajemen dan staf klinis, yang memungkinkan mereka untuk menerjemahkan kebijakan organisasi tentang keselamatan pasien menjadi praktik nyata di unit kerja, memberikan dukungan langsung kepada perawat dalam melaporkan insiden, serta menciptakan budaya unit yang menekankan pada pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan daripada menyalahkan individu ketika terjadi kesalahan. Kepemimpinan yang transformatif dan caring dari kepala ruangan akan membentuk iklim psikologis yang aman, di mana perawat merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan keselamatan pasien melalui pelaporan insiden yang akurat dan tepat waktu (Abou Hashish et al., 2024).

a. Modeling Perilaku Pelaporan oleh Kepala Ruangan

Kepala ruangan yang secara aktif memodelkan perilaku pelaporan insiden, termasuk melaporkan kejadian yang melibatkan diri mereka sendiri atau sistematis menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari staf, akan menciptakan standar normatif yang kuat di unit kerja bahwa pelaporan adalah bagian integral dari praktik profesional yang harus dilakukan oleh semua anggota tim tanpa terkecuali. Kepemimpinan by example ini sangat powerful dalam membentuk perilaku staf karena menunjukkan konsistensi antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemimpin, sehingga menghilangkan keraguan atau persepsi bahwa pelaporan hanya diharapkan dari staf tingkat bawah sementara manajer atau kepala ruangan mendapat pengecualian.

b. Pemberian Dukungan Emosional dan Profesional

Dukungan emosional yang diberikan kepala ruangan kepada perawat yang mengalami atau terlibat dalam insiden keselamatan pasien, termasuk memberikan kesempatan untuk mendiskusikan perasaan, kekhawatiran, dan pembelajaran dari kejadian tersebut dalam suasana yang tidak menghakimi, akan membantu perawat mengatasi stres psikologis yang sering menyertai kejadian adverse event dan mencegah berkembangnya fenomena second victim syndrome yang dapat menghambat pelaporan di masa mendatang. Kepala ruangan yang menunjukkan empati, pengertian, dan dukungan praktis seperti adjustment beban kerja atau akses ke konseling profesional akan membangun loyalitas dan trust dari staf, yang pada gilirannya menciptakan hubungan kerja yang terbuka dan komunikatif yang esensial untuk sistem pelaporan yang efektif.

c. Supervisi Klinis yang Berfokus pada Pembelajaran

Supervisi klinis yang dilakukan kepala ruangan dengan orientasi pada pembelajaran dan pengembangan kompetensi, bukan pada surveillance dan punishment, akan menciptakan dinamika yang konstruktif di mana diskusi tentang insiden atau near miss menjadi kesempatan untuk refleksi, analisis kritis, dan identifikasi strategi pencegahan, sehingga pengalaman negatif dapat ditransformasi menjadi pembelajaran yang berharga. Menurut Viana et al. (2021), supervisi yang efektif mencakup observasi praktik klinis yang reguler, debriefing setelah situasi kompleks atau insiden, serta pemberian feedback yang spesifik dan konstruktif yang membantu perawat mengidentifikasi area untuk improvement sambil mengakui kekuatan dan kontribusi positif mereka, sehingga proses supervisi dipersepsikan sebagai dukungan profesional yang memfasilitasi pertumbuhan, bukan sebagai mekanisme kontrol yang mengancam.

I. Peran Manajemen Keperawatan dalam Mendukung QI dan PSIR

1. Kebijakan dan Standar Operasional Keperawatan

Kebijakan dan standar operasional keperawatan merupakan fondasi fundamental dalam mengimplementasikan program peningkatan kualitas (*Quality Improvement/QI*) dan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien (*Patient Safety Incident Reporting/PSIR*) di institusi pelayanan kesehatan. Keberadaan kebijakan yang terstruktur dan komprehensif memberikan kerangka kerja yang jelas bagi tenaga keperawatan dalam melaksanakan praktik klinis yang aman dan berkualitas, sekaligus menjadi panduan operasional dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menindaklanjuti insiden keselamatan pasien yang terjadi dalam lingkungan pelayanan. Standar operasional prosedur (*Standard Operating Procedures/SOP*) yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip keselamatan pasien tidak hanya berfungsi sebagai acuan teknis pelaksanaan asuhan keperawatan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol kualitas yang memastikan setiap tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan *evidence-based practice* dan regulasi yang berlaku (Hussein et al., 2021).

Implementasi kebijakan dan standar operasional keperawatan yang efektif memerlukan komitmen kuat dari manajemen keperawatan dalam menyusun, mensosialisasikan, dan melakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan pelaksanaannya di seluruh unit pelayanan. Proses akreditasi rumah sakit telah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui standardisasi kebijakan dan prosedur operasional yang sistematis, termasuk dalam aspek manajemen keperawatan dan

keselamatan pasien. Manajemen keperawatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh staf keperawatan memahami dan mengaplikasikan kebijakan serta SOP dalam praktik sehari-hari, sekaligus menciptakan mekanisme *feedback* yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada berdasarkan temuan dari proses QI dan analisis data PSIR (Camacho Rodríguez et al., 2022).

2. Pemantauan Indikator Mutu Keperawatan

Pemantauan indikator mutu keperawatan merupakan aktivitas esensial dalam manajemen keperawatan yang bertujuan untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan secara objektif dan terukur. Indikator mutu keperawatan berfungsi sebagai parameter penilaian kinerja yang mencerminkan efektivitas pelayanan keperawatan, tingkat keselamatan pasien, serta area-area yang memerlukan perbaikan dalam sistem pelayanan. Melalui pemantauan indikator mutu secara sistematis dan berkelanjutan, manajemen keperawatan dapat mengidentifikasi tren kejadian insiden, pola *adverse events*, serta faktor-faktor kontekstual yang berkontribusi terhadap terjadinya kesalahan dalam pelayanan keperawatan (Hafezi et al., 2022).

Beberapa indikator mutu keperawatan yang perlu dipantau secara rutin meliputi:

- a. Insiden Kesalahan Medikasi (*Medication Errors*): Pemantauan terhadap frekuensi dan jenis kesalahan dalam proses pemberian obat, mulai dari tahap peresepan, persiapan, pendistribusian, hingga administrasi kepada pasien. Kualitas dokumentasi medikasi sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, kepuasan kerja perawat, *burnout* terkait pasien, serta budaya keselamatan pasien yang kuat dalam organisasi (Gambashidze et al., 2025).
- b. Angka Kejadian Infeksi Nosokomial (*Healthcare-Associated Infections/HAIs*): Monitoring terhadap kejadian infeksi yang didapat pasien selama perawatan di rumah sakit, termasuk infeksi luka operasi, infeksi saluran kemih akibat kateter, pneumonia akibat ventilator, dan infeksi aliran darah, yang merupakan indikator penting dari praktik pencegahan dan pengendalian infeksi.
- c. Insiden Jatuh Pasien (*Patient Falls*): Pengukuran frekuensi kejadian jatuh pasien beserta tingkat keparahan cedera yang ditimbulkan, yang mencerminkan efektivitas asesmen risiko jatuh, implementasi intervensi pencegahan, serta kesiapan lingkungan fisik dalam mendukung keselamatan pasien (Gambashidze et al., 2025).
- d. Tingkat Kepuasan Pasien (*Patient Satisfaction*): Evaluasi terhadap persepsi dan pengalaman pasien mengenai kualitas asuhan keperawatan yang diterima,

yang memberikan perspektif penting tentang aspek humanistik pelayanan dan *patient-centered care*.

- e. Indikator Proses Asuhan Keperawatan: Pemantauan terhadap kelengkapan dan ketepatan waktu pengkajian keperawatan, perumusan diagnosis keperawatan, implementasi intervensi berbasis bukti, serta evaluasi hasil asuhan yang terdokumentasi secara akurat dan komprehensif (Yusuf & Irwan, 2021).
- f. Angka Kejadian *Adverse Events*: Monitoring terhadap seluruh kejadian tidak diharapkan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera pada pasien, termasuk kejadian nyaris cedera (*near miss*), yang menjadi sumber pembelajaran penting untuk perbaikan sistem (Hafezi et al., 2022).

3. Pengintegrasian Patient Safety dalam Budaya Organisasi

Pengintegrasian keselamatan pasien (*patient safety*) ke dalam budaya organisasi keperawatan merupakan transformasi fundamental yang memerlukan perubahan paradigma dari *culture of blame* menuju *culture of safety* yang mendorong pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Budaya keselamatan pasien yang kuat ditandai dengan nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku kolektif yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan kesehatan. Manajemen keperawatan memegang peran strategis dalam membentuk, memelihara, dan mengembangkan budaya keselamatan melalui kepemimpinan yang transformatif, penciptaan lingkungan kerja yang suportif, serta pemberdayaan perawat untuk berpartisipasi aktif dalam program keselamatan pasien tanpa rasa takut akan hukuman atau stigmatisasi (W. Lee & Jang, 2023).

Strategi pengintegrasian *patient safety* dalam budaya organisasi keperawatan mencakup beberapa dimensi penting:

- a. Kepemimpinan Transformasional dan Komitmen Manajemen: Peran pemimpin keperawatan dalam mendemonstrasikan komitmen nyata terhadap keselamatan pasien melalui alokasi sumber daya yang memadai, pemberian dukungan terhadap inisiatif keselamatan, dan penciptaan visi bersama tentang pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas. Gaya kepemimpinan perawat berpengaruh signifikan terhadap budaya pelaporan insiden keselamatan pasien dalam organisasi (Ünal et al., 2025).
- b. Sistem Pelaporan Insiden yang Non-Punitif: Pengembangan sistem PSIR yang transparan, mudah diakses, dan tidak menghukum pelapor, yang mendorong perawat untuk melaporkan insiden dan kejadian nyaris cedera sebagai bagian dari pembelajaran organisasi, bukan sebagai mekanisme penyalahan individu.

- c. Komunikasi Terbuka dan Kolaborasi Interprofesional: Fasilitasi komunikasi efektif antar profesional kesehatan melalui mekanisme *handover* yang terstruktur, ronde keperawatan kolaboratif, dan forum diskusi kasus yang melibatkan tim multidisiplin untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko keselamatan pasien secara komprehensif.
- d. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Implementasi program edukasi keselamatan pasien yang sistematis dan berkesinambungan bagi seluruh staf keperawatan, mencakup topik-topik seperti identifikasi risiko, analisis akar masalah (*root cause analysis*), komunikasi efektif, dan praktik keselamatan berbasis bukti.
- e. Pembelajaran dari Kesalahan (*Learning from Errors*): Pengembangan mekanisme analisis insiden yang konstruktif dan fokus pada perbaikan sistem, bukan penyalahan individu, melalui investigasi menyeluruh terhadap faktor-faktor kontributor, identifikasi kelemahan sistem, dan implementasi tindakan perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
- f. Profesionalisme dan Lingkungan Kerja yang Mendukung: Penciptaan iklim kerja yang menghargai profesionalisme keperawatan, memberikan otonomi klinis yang seimbang dengan akuntabilitas, serta menyediakan kondisi kerja yang kondusif untuk praktik keperawatan yang aman. Profesionalisme perawat, lingkungan kerja yang positif, dan komunikasi efektif dengan profesional kesehatan lain terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap budaya keselamatan pasien dalam organisasi (W. Lee & Jang, 2023).

J. Praktik Baik (Best Practices) dan Studi Kasus

1. Contoh Implementasi QI oleh Tim Keperawatan

Implementasi *Quality Improvement* (QI) oleh tim keperawatan merupakan upaya terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendekatan berbasis data, kolaborasi interprofesional, dan pembelajaran berkelanjutan. Program QI yang efektif memerlukan komitmen organisasi yang kuat, partisipasi aktif seluruh anggota tim keperawatan, serta penggunaan metodologi perbaikan yang terstandar untuk mengidentifikasi masalah, merancang intervensi, mengimplementasikan perubahan, dan mengevaluasi hasil secara berkesinambungan. Konsep *learning health system* (LHS) telah menjadi kerangka kerja penting dalam mengintegrasikan praktik klinis dengan penelitian dan peningkatan kualitas, di mana data dari pelayanan rutin digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang kemudian diaplikasikan kembali untuk memperbaiki sistem pelayanan (Nash et al., 2021).

Beberapa contoh implementasi QI oleh tim keperawatan yang telah menunjukkan hasil signifikan meliputi:

- a. Program Pengurangan Infeksi Nosokomial: Implementasi *bundle* pencegahan infeksi aliran darah terkait kateter vena sentral (*Central Line-Associated Bloodstream Infections/CLABSI*) melalui standarisasi prosedur insersi, perawatan harian dengan *checklist*, dan audit kepatuhan yang dilakukan secara berkala. Program ini melibatkan tim keperawatan dalam monitoring ketat terhadap indikasi pemasangan kateter, teknik aseptik yang ketat, serta evaluasi harian terhadap kebutuhan kelanjutan penggunaan kateter untuk meminimalkan risiko infeksi.
- b. Proyek Penurunan Angka Jatuh Pasien: Inisiatif QI yang mengintegrasikan asesmen risiko jatuh komprehensif menggunakan instrumen tervalidasi, implementasi intervensi pencegahan berlapis seperti modifikasi lingkungan, penggunaan alarm tempat tidur, edukasi pasien dan keluarga, serta pemberian identifikasi visual bagi pasien berisiko tinggi. Program ini didukung oleh sistem dokumentasi elektronik yang memfasilitasi komunikasi tim dan pemantauan *real-time* terhadap status risiko pasien.
- c. Peningkatan Kepatuhan *Hand Hygiene*: Kampanye peningkatan kebersihan tangan melalui pendekatan multimodal yang mencakup edukasi staf, penyediaan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses, penggunaan *alcohol-based hand rub* di titik-titik pelayanan, monitoring kepatuhan melalui observasi langsung, dan pemberian *feedback* reguler kepada unit-unit keperawatan mengenai tingkat kepatuhan mereka.
- d. Optimalisasi Manajemen Nyeri Pasien: Implementasi protokol asesmen nyeri yang terstruktur menggunakan skala nyeri yang sesuai dengan kondisi pasien, dokumentasi sistematis terhadap intensitas nyeri, intervensi farmakologis dan non-farmakologis berbasis bukti, serta re-evaluasi efektivitas manajemen nyeri dalam interval waktu yang telah ditentukan untuk memastikan kenyamanan optimal pasien.
- e. Program Pengurangan *Medication Errors*: Inisiatif keselamatan medikasi yang melibatkan implementasi sistem *double-check* untuk obat-obatan berisiko tinggi, penggunaan teknologi *barcode scanning* untuk verifikasi pasien dan obat, standarisasi proses rekonsiliasi medikasi saat transisi pelayanan, serta edukasi berkelanjutan bagi perawat mengenai obat-obatan baru dan praktik pemberian obat yang aman (Mike et al., 2021).

2. Studi Kasus Pelaporan Insiden dan Tindak Lanjut Perbaikan

Pelaporan insiden keselamatan pasien dan tindak lanjut perbaikan yang sistematis merupakan komponen esensial dalam membangun budaya keselamatan dan pembelajaran organisasi di institusi kesehatan. Sistem pelaporan insiden yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi bahaya dalam sistem pelayanan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran berharga untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Kesadaran dan praktik pelaporan insiden di kalangan perawat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman tentang sistem pelaporan, persepsi terhadap konsekuensi pelaporan, beban kerja, serta dukungan manajerial terhadap budaya pelaporan yang non-punitif (Oweidat et al., 2023).

Komponen-komponen kunci dalam sistem pelaporan insiden dan tindak lanjut perbaikan yang efektif mencakup:

- a. Identifikasi dan Klasifikasi Insiden: Proses deteksi insiden melalui berbagai sumber seperti laporan langsung dari staf, keluhan pasien, hasil audit klinis, atau monitoring indikator mutu. Setiap insiden yang teridentifikasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan (*severity*), tipe insiden, dan dampaknya terhadap pasien menggunakan taksonomi yang terstandar untuk memfasilitasi analisis dan pembelajaran sistematis.
- b. Pelaporan yang Mudah dan Tidak Menghukum: Penyediaan mekanisme pelaporan yang sederhana dan dapat diakses melalui berbagai platform seperti formulir elektronik, aplikasi *mobile*, atau sistem berbasis *web*, yang disertai dengan jaminan kerahasiaan pelapor dan pendekatan *just culture* yang membedakan antara kesalahan sistem dengan perilaku *reckless* individu.
- c. Investigasi dan Analisis Akar Masalah: Pelaksanaan investigasi mendalam terhadap insiden signifikan menggunakan metodologi *Root Cause Analysis* (RCA) atau analisis faktor kontributor yang melibatkan tim multidisiplin untuk mengidentifikasi faktor-faktor sistem, proses, dan manusia yang berkontribusi terhadap terjadinya insiden, bukan sekadar mencari individu yang bersalah.
- d. Pengembangan dan Implementasi Rencana Perbaikan: Perumusan rekomendasi perbaikan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki *timeline* yang jelas (*SMART*), yang mencakup perubahan kebijakan, revisi prosedur, peningkatan pelatihan, modifikasi sistem, atau redesain proses kerja untuk mengeliminasi atau meminimalkan risiko terulangnya insiden serupa.
- e. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Perbaikan: Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi tindakan perbaikan melalui indikator

kinerja yang relevan, audit kepatuhan, dan pengukuran dampak terhadap pengurangan insiden, yang memungkinkan organisasi untuk menilai efektivitas intervensi dan melakukan penyesuaian bila diperlukan.

- f. Diseminasi Pembelajaran (*Learning Dissemination*): Komunikasi temuan investigasi dan pembelajaran yang diperoleh kepada seluruh staf melalui berbagai forum seperti *safety briefing*, *morbidity and mortality conference*, buletin keselamatan, atau platform digital, untuk memastikan bahwa pembelajaran dari satu insiden dapat mencegah kejadian serupa di unit atau departemen lain (Mukherjee et al., 2024).

3. Pembelajaran dari Rumah Sakit yang Berhasil

Rumah sakit yang berhasil mengimplementasikan program peningkatan kualitas dan keselamatan pasien secara efektif menunjukkan karakteristik dan strategi tertentu yang dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi institusi kesehatan lainnya. Salah satu keberhasilan signifikan terlihat pada rumah sakit yang mengadopsi prinsip-prinsip *learning health system*, di mana terdapat integrasi yang mulus antara pelayanan klinis, penelitian, dan peningkatan kualitas. Inisiatif *Acute Inpatient Medicine—High Reliability, Learning Environment, and Workforce Development Initiative* (AIM-HI) yang diimplementasikan di rumah sakit rural *Veterans Health Administration* mendemonstrasikan bagaimana pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip *high reliability organization*, penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan pengembangan tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan bahkan di setting dengan sumber daya terbatas (Gilmartin et al., 2024).

Analisis retrospektif terhadap *adverse events* yang dilaporkan oleh profesional unit perawatan intensif di Tunisia memberikan wawasan penting tentang pola dan faktor kontributor insiden keselamatan pasien dalam setting perawatan kritis. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa mayoritas insiden terkait dengan masalah medikasi, kesalahan prosedural, dan kegagalan komunikasi, dengan faktor sistem seperti beban kerja tinggi, kelelahan staf, dan keterbatasan sumber daya menjadi kontributor utama. Rumah sakit yang berhasil mengatasi tantangan ini mengimplementasikan strategi komprehensif yang mencakup optimalisasi rasio perawat-pasien, implementasi protokol komunikasi terstruktur seperti *SBAR* (*Situation-Background-Assessment-Recommendation*), penggunaan teknologi *clinical decision support*, serta program kesejahteraan staf untuk mengurangi *burnout* dan kelelahan (Tlili et al., 2024).

Pembelajaran penting lainnya dari rumah sakit yang berhasil adalah kemampuan mereka untuk "membengkokkan kurva biaya dengan peningkatan

kualitas" (*bending the cost curve with increased quality*), yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan efisiensi biaya bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat dicapai secara simultan melalui strategi terintegrasi. Strategi-strategi ini mencakup optimalisasi *care pathways* untuk mengurangi variasi praktik yang tidak perlu, implementasi program *enhanced recovery after surgery* (ERAS) yang mempercepat pemulihan pasien dan mengurangi lama rawat, pengembangan klinik khusus untuk manajemen penyakit kronik yang mengurangi readmisi, serta investasi dalam teknologi kesehatan digital yang meningkatkan koordinasi pelayanan. Rumah sakit-rumah sakit tersebut juga menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi data, di mana informasi tentang kualitas pelayanan dan *outcome* pasien dibagikan secara terbuka kepada staf, pasien, dan publik, yang menciptakan akuntabilitas dan mendorong perbaikan berkelanjutan (Wackers et al., 2021).

K. Tantangan dan Peluang Pengembangan di Masa Depan

1. Peran Teknologi Digital dalam Quality Improvement dan Reporting

Teknologi digital telah menghadirkan transformasi fundamental dalam praktik *quality improvement* (QI) dan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien (*patient safety incident reporting*/PSIR) di institusi pelayanan kesehatan kontemporer. Integrasi teknologi informasi dalam sistem manajemen kualitas dan keselamatan pasien tidak hanya meningkatkan efisiensi proses dokumentasi dan pelaporan, tetapi juga membuka peluang baru untuk analisis data yang lebih mendalam, deteksi dini terhadap pola insiden, serta pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih akurat dan *real-time*. Pengaruh teknologi informasi terhadap efisiensi kinerja pegawai kesehatan telah terbukti signifikan, di mana implementasi sistem digital yang tepat dapat mengoptimalkan alur kerja, mengurangi beban administratif, dan memfasilitasi komunikasi serta kolaborasi yang lebih efektif antar profesional kesehatan (Al Munawar, 2025).

Berbagai peran strategis teknologi digital dalam mendukung QI dan *reporting* meliputi:

- a. Sistem Pelaporan Insiden Elektronik (*Electronic Incident Reporting System*/EIRS): Platform digital yang memfasilitasi pelaporan insiden secara *real-time* melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau *smartphone*, yang dilengkapi dengan antarmuka yang intuitif, formulir terstruktur dengan *dropdown menu* dan *auto-population*, serta kemampuan untuk melampirkan dokumentasi pendukung seperti foto atau dokumen. Sistem ini memungkinkan pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif dibandingkan sistem manual berbasis kertas, sekaligus

memfasilitasi *tracking* status investigasi dan tindak lanjut perbaikan secara transparan.

- b. *Dashboard* Visualisasi Data dan *Analytics*: Penggunaan teknologi *business intelligence* dan *data analytics* untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber (rekam medis elektronik, sistem pelaporan insiden, indikator mutu, kepuasan pasien) ke dalam *dashboard* visual yang interaktif, yang memungkinkan manajer dan klinisi untuk memantau tren kualitas pelayanan, mengidentifikasi *outlier*, mendeteksi pola insiden yang muncul, serta melakukan analisis komparatif antar unit atau periode waktu secara efisien.
- c. Sistem Peringatan Dini Berbasis Kecerdasan Buatan (*AI-Based Early Warning System*): Implementasi algoritma *machine learning* dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data pasien secara kontinu dan mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi mengalami deteriorasi klinis, komplikasi, atau *adverse events*, yang kemudian memicu notifikasi otomatis kepada tim klinis untuk intervensi preventif sebelum kejadian buruk terjadi.
- d. Rekam Medis Elektronik Terintegrasi (*Integrated Electronic Health Records/EHR*): Sistem dokumentasi digital yang terstandar dan terintegrasi yang memfasilitasi kontinuitas informasi pasien sepanjang episode pelayanan, mengurangi duplikasi dokumentasi, meminimalkan risiko kesalahan transkripsi, serta menyediakan *clinical decision support* berbasis bukti yang membantu klinisi dalam pengambilan keputusan klinis yang aman dan efektif.
- e. Platform Pembelajaran dan Diseminasi Pengetahuan Digital: Pengembangan *Learning Management System* (LMS) dan portal pengetahuan digital yang memfasilitasi akses mudah terhadap kebijakan, prosedur, panduan klinis, *safety alert*, serta pembelajaran dari insiden yang telah terjadi, yang mendukung budaya pembelajaran berkelanjutan dan diseminasi *best practices* secara luas dan efisien.
- f. Teknologi *Barcode* dan *Radio-Frequency Identification* (RFID): Implementasi sistem identifikasi otomatis menggunakan *barcode* atau RFID untuk verifikasi identitas pasien, obat-obatan, dan prosedur, yang merupakan komponen kritis dalam mencegah kesalahan identifikasi pasien dan kesalahan medikasi, serta memfasilitasi *tracking* peralatan medis dan manajemen inventori yang lebih efisien (Al Munawar, 2025).

2. Transformasi Budaya Keselamatan di Era Digitalisasi Kesehatan

Era digitalisasi kesehatan membawa implikasi mendalam terhadap transformasi budaya keselamatan pasien di institusi pelayanan kesehatan, di mana teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis tetapi juga

sebagai katalisator perubahan perilaku, nilai, dan norma organisasi terkait keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien yang kuat dalam konteks pelayanan primer kesehatan, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian pada setting *Brazilian Family Health Strategy*, mengindikasikan pentingnya pendekatan sistemik yang mengintegrasikan kepemimpinan yang suportif, komunikasi terbuka, pembelajaran dari kesalahan, kerja tim yang kolaboratif, dan respons non-punitif terhadap *error* sebagai fondasi budaya keselamatan yang efektif. Digitalisasi kesehatan memberikan peluang untuk memperkuat setiap dimensi budaya keselamatan ini melalui transparansi data yang lebih besar, aksesibilitas informasi yang meningkat, serta mekanisme *feedback* yang lebih cepat dan terukur (Araújo et al., 2022).

Transformasi budaya keselamatan di era digital memerlukan perubahan paradigma dalam cara perawat dan profesional kesehatan lainnya memandang dan berinteraksi dengan teknologi. Budaya kerja digital yang positif, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam konteks *retail 4.0*, menekankan pentingnya adaptasi teknologi yang bukan sekadar adopsi *hardware* dan *software*, tetapi juga internalisasi nilai-nilai digital seperti kolaborasi virtual, pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*), inovasi berbasis data, dan ketangkasan (*agility*) dalam merespons perubahan. Dalam konteks keperawatan, budaya kerja digital yang kuat akan mendorong perawat untuk secara proaktif memanfaatkan teknologi digital dalam praktik klinis mereka, berkontribusi aktif dalam sistem pelaporan elektronik, menggunakan data untuk refleksi dan perbaikan praktik, serta berpartisipasi dalam komunitas pembelajaran virtual yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan *best practices* antar institusi (Nurfuaddi et al., 2025).

Persepsi perawat terhadap budaya keselamatan di unit medis-bedah, sebagaimana diteliti dalam konteks rumah sakit di Arab Saudi, menunjukkan variasi signifikan dalam dimensi-dimensi budaya keselamatan seperti kerja tim dalam unit, ekspektasi dan tindakan manajer yang mempromosikan keselamatan, pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan, serta *staffing* yang adekuat. Era digitalisasi memberikan peluang untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui implementasi sistem *workforce management* berbasis data yang mengoptimalkan alokasi staf berdasarkan *patient acuity* dan beban kerja, platform komunikasi digital yang memfasilitasi koordinasi tim yang lebih efektif terutama dalam situasi *shift changes* yang merupakan periode risiko tinggi untuk terjadinya *gaps* komunikasi, serta sistem manajemen kinerja digital yang memberikan *feedback* konstruktif secara reguler kepada perawat mengenai kontribusi mereka terhadap keselamatan pasien (Alrasheadi et al., 2022).

Namun demikian, transformasi budaya keselamatan di era digital juga menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi secara proaktif. Tantangan-tantangan ini mencakup resistensi terhadap perubahan dari staf yang terbiasa dengan sistem manual, risiko *alert fatigue* akibat terlalu banyak notifikasi elektronik yang dapat menyebabkan *desensitization*, potensi depersonalisasi pelayanan akibat terlalu fokus pada interaksi dengan sistem digital dibandingkan dengan pasien, serta kesenjangan kompetensi digital (*digital divide*) antar generasi perawat yang dapat menciptakan ketimpangan dalam partisipasi dan kontribusi terhadap inisiatif keselamatan digital. Optimalisasi penerapan *patient safety goals* dalam pelayanan keperawatan di era digital memerlukan strategi komprehensif yang mencakup investasi dalam infrastruktur teknologi yang *user-friendly*, program pelatihan dan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, desain sistem yang menempatkan pengguna (*user-centered design*) di pusat pengembangan, serta mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan perspektif perawat sebagai pengguna utama teknologi tersebut (Hardono & Bunga, 2025).

3. Rekomendasi bagi Pengembangan Kompetensi Perawat

Pengembangan kompetensi perawat dalam konteks *quality improvement* dan *patient safety incident reporting* di era digitalisasi kesehatan merupakan investasi strategis yang esensial untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program keselamatan pasien. Kompetensi perawat tidak hanya mencakup keterampilan teknis klinis, tetapi juga kemampuan analitis, literasi digital, keterampilan komunikasi dan kolaborasi, serta kapasitas untuk pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan. Membangun budaya *self-learning* dalam *digital workplace* menjadi semakin relevan, di mana peran strategis *self-awareness* dan *Learning Management System* (LMS) dapat memfasilitasi perawat untuk mengidentifikasi *gap* kompetensi mereka sendiri, mengakses sumber pembelajaran yang relevan secara *on-demand*, dan mengukur progres pembelajaran mereka secara mandiri dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks dan dinamis (Hafizha et al., 2025).

Rekomendasi strategis untuk pengembangan kompetensi perawat mencakup berbagai dimensi:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi dalam Keselamatan Pasien: Integrasi komprehensif materi keselamatan pasien, metodologi QI, dan keterampilan investigasi insiden ke dalam kurikulum pendidikan keperawatan dasar dan program orientasi bagi perawat baru, yang dilengkapi dengan pembelajaran berbasis simulasi, studi kasus nyata, dan pengalaman praktik

lapangan yang memberikan kesempatan bagi perawat untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis dalam konteks praktis yang aman.

- b. Pengembangan Literasi Digital dan Kompetensi Teknologi Informasi: Program pelatihan sistematis dan berjenjang dalam penggunaan teknologi kesehatan digital, termasuk sistem informasi rumah sakit, aplikasi pelaporan insiden elektronik, *analytics tools*, dan platform komunikasi digital, yang disesuaikan dengan tingkat kemahiran digital perawat dan disertai dengan dukungan teknis yang mudah diakses serta pendampingan (*coaching*) bagi perawat yang mengalami kesulitan dalam adopsi teknologi.
- c. Pelatihan Metodologi *Quality Improvement* dan Analisis Data: Pengembangan kemampuan perawat dalam memahami dan mengaplikasikan metodologi perbaikan kualitas seperti *Plan-Do-Study-Act* (PDSA), *Lean*, *Six Sigma*, atau *Model for Improvement*, serta keterampilan dasar analisis data dan interpretasi statistik yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proyek-proyek QI di unit mereka.
- d. Penguatan Keterampilan Komunikasi dan Kolaborasi Interprofesional: Program pengembangan yang fokus pada komunikasi efektif dalam konteks keselamatan pasien, termasuk teknik *SBAR*, keterampilan *handover* yang terstruktur, komunikasi asertif dalam situasi risiko tinggi, kemampuan memberikan dan menerima *feedback* konstruktif, serta kompetensi kolaborasi dalam tim multidisiplin yang menghargai kontribusi unik setiap profesi.
- e. Pengembangan Kepemimpinan dalam Keselamatan Pasien: Identifikasi dan pengembangan perawat dengan potensi kepemimpinan untuk menjadi *safety champions* atau *quality improvement champions* di unit mereka, melalui program pelatihan kepemimpinan yang mencakup keterampilan *change management*, *influence without authority*, fasilitasi tim, dan mentoring, yang dapat mengkatalisasi perubahan budaya keselamatan di tingkat *grassroots*.
- f. Penciptaan *Community of Practice* dan Jaringan Pembelajaran: Fasilitasi pembentukan komunitas praktik (*communities of practice*) baik secara internal dalam institusi maupun lintas institusi, yang memungkinkan perawat untuk berbagi pengalaman, pembelajaran, dan *best practices* terkait QI dan keselamatan pasien, serta mengakses dukungan *peer* dan mentorat dari perawat yang lebih berpengalaman dalam bidang ini.
- g. Sistem Pengakuan dan Penghargaan (*Recognition and Reward*): Pengembangan mekanisme formal untuk mengakui dan menghargai kontribusi perawat terhadap inisiatif QI dan keselamatan pasien, baik melalui penghargaan individual, promosi berbasis kompetensi, kesempatan untuk presentasi di konferensi, publikasi, atau insentif lain yang bermakna, yang

dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan berkelanjutan dalam program-program peningkatan kualitas (Hutasuhut, 2025).

L. Simpulan

Keselamatan pasien merupakan fondasi utama dalam mutu pelayanan kesehatan dan menjadi indikator penting kualitas asuhan keperawatan. Pelaporan insiden keselamatan pasien berfungsi sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, menganalisis penyebab kejadian, serta mencegah terulangnya insiden serupa. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan pelayanan memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Namun demikian, optimalisasi peran tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, dukungan manajemen, beban kerja, serta sistem pelaporan yang aman, mudah digunakan, dan tidak bersifat menyalahkan.

Implikasi terhadap praktik keperawatan menunjukkan bahwa penerapan keselamatan pasien harus menjadi bagian integral dari praktik profesional perawat sehari-hari. Perawat dituntut untuk memiliki kesadaran tinggi terhadap risiko keselamatan pasien, kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi potensi insiden, serta komitmen dalam melaporkan seluruh jenis insiden, termasuk kejadian nyaris cedera dan kondisi potensial cedera. Praktik keperawatan yang aman perlu didukung oleh pelatihan berkelanjutan, supervisi yang efektif, serta keterlibatan aktif perawat dalam kegiatan peningkatan mutu seperti audit klinis, evaluasi indikator mutu, dan pengembangan praktik berbasis bukti.

Dari sisi kebijakan keperawatan, temuan dalam naskah ini menegaskan pentingnya kebijakan institusional yang mendukung budaya keselamatan pasien dan pelaporan insiden secara terbuka. Kebijakan tersebut harus menekankan pendekatan adil dan non-punitif, perlindungan terhadap pelapor, serta kejelasan alur tindak lanjut dan umpan balik dari setiap laporan insiden. Manajemen keperawatan memiliki tanggung jawab strategis dalam menyediakan sumber daya yang memadai, memperkuat kepemimpinan yang mendukung keselamatan pasien, serta memastikan integrasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam sistem manajemen rumah sakit.

Arah penelitian dan pengembangan keamanan pasien ke depan perlu difokuskan pada penguatan peran perawat dalam sistem pelaporan insiden, pengembangan model intervensi berbasis konteks lokal, serta pemanfaatan data insiden sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan kesehatan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi efektivitas inovasi teknologi pelaporan, pengaruh kepemimpinan keperawatan terhadap budaya keselamatan pasien, serta hubungan

antara beban kerja perawat dan kepatuhan pelaporan insiden. Upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien secara berkelanjutan.

Referensi

- Abou Hashish, E. A., Alsayed, S., Alnajjar, H., & Abu Bakar, S. A. (2024). The Relationship Between Organizational Justice and Bullying Behaviors Among Nurses: The Role of Nurse Managers' Caring Behaviors. *BMC Nursing*. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02134-1>
- Adnyani, N. L. G. S., Nugraha, I. N. A., & Rudiarta, I. G. L. M. (2022). Evaluasi Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 8(4), 537–549. <https://doi.org/10.33023/jikep.v8i4.1217>
- Ahsani-Estahbanati, E., Gordeev, V. S., & Doshmangir, L. (2022). Interventions to Reduce the Incidence of Medical Error and Its Financial Burden in Health Care Systems: A Systematic Review of Systematic Reviews. *Frontiers in Medicine*. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.875426>
- Akmal, A., Podgorodnichenko, N., Greatbanks, R., Foote, J., Stokes, T., & Gauld, R. (2021). Towards the Development of a System-Wide Quality Improvement Maturity Model: A Synthesis Using Systematic Review and Expert Opinion. *International Journal of Lean Six Sigma*. <https://doi.org/10.1108/ijlss-06-2021-0107>
- Al-Roomi, K., Alzayani, S., Almarabheh, A., Alqahtani, M. M., Aldosari, F., Aladwani, M., Aldeyouli, N., Alhobail, R., Atwa, H., & Salem, A. H. (2024). Familiarity and Applications of Artificial Intelligence in Health Professions Education: Perspectives of Students in a Community-Oriented Medical School. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.73425>
- Al Munawar, S. A. (2025). Analisis Sistematis Literatur Tentang Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai. *Simtek Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer*. <https://doi.org/10.51876/simtek.v10i1.1484>
- Ali Ali, H. M., Abdul-Aziz, A. M., Fawzy Darwish, E. A., Swelem, M. S., & Sultan, E. A. (2022). Assessment of Patient Safety Culture Among the Staff of the University Hospital for Gynecology and Obstetrics in Alexandria, Egypt. *Journal of Egyptian Public Health Association*. <https://doi.org/10.1186/s42506-022-00110-8>
- Alrasheadi, B., Alamri, M., Aljohani, K. A., AL-Dossary, R., Albaqawi, H., Alharbi, J., Hosis, K. Al, Aljohani, M., Almadani, N., Falatah, R., Alotaibi, J. S., & Almazan, J. U. (2022). Nurses' Perception of Safety Culture in Medical–Surgical Units in Hospitals in Saudi Arabia. *Medicina*. <https://doi.org/10.3390/medicina58070897>

- Anderson, M. J., Stephens, W. A., Levy, B. E., Newcomb, M. R., & Harris, A. (2024). Barriers to Incident Reporting by Physicians: A Survey of Surgical Residents and Attending Physicians. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.62850>
- Araújo, G. L., Amorim, F. F., Pereira Miranda, R. C., Pontes Amorim, F. F., Santana, L. A., & Donato Göttems, L. B. (2022). Patient Safety Culture in Primary Health Care: Medical Office Survey on Patient Safety Culture in a Brazilian Family Health Strategy Setting. *Plos One*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271158>
- Armstrong, A. (2023). Implementing an Electronic Root Cause Analysis Reporting System to Decrease Hospital-Acquired Pressure Injuries. *Journal for Healthcare Quality*. <https://doi.org/10.1097/jhq.0000000000000371>
- Beecham, E., Brady, G., Iqbal, S., Fatima, Q., Arshad, S., Bondaronek, P., O'Carroll, J., Glaser, S., Siassakos, D., Gilchrist, K., Dorey, J., Knagg, R., & Vindrola-Padros, C. (2025). Systematic Review of Patient Safety Incident Reporting Practices in Maternity Care. *BMJ Open Quality*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-003432>
- Camacho Rodríguez, D. E., Carrasquilla Baza, D. A., Domínguez-Cancino, K. A., & Palmieri, P. A. (2022). Patient Safety Culture in Latin American Hospitals: A Systematic Review With Meta-Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114380>
- Canali, D. G. R., Marques, F., Morales, A. M., Lopes, A. A., Maximo, A. C., Mata, L., Barraqui, L., Pedroso, C., Melo, G. de, & Quiarato, P. A. (2025). A-189 Assessment of Patient Safety Culture in Brazilian Diagnostic Network: Analysis of Dimensions, Communication, and Organizational Learning. *Clinical Chemistry*. <https://doi.org/10.1093/clinchem/hvaf086.183>
- da Brás, C. P., Céu Barbieri-Figueiredo, M. do, & Ferreira, M. (2023). Safety Culture in Obstetric Nurses' Clinical Practice. *Texto & Contexto - Enfermagem*. <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2022-0330en>
- Daly, A., Teeling, S. P., Garvey, S., Ward, M., & McNamara, M. (2022). Using a Combined Lean and Person-Centred Approach to Support the Resumption of Routine Hospital Activity Following the First Wave of COVID-19. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph19052754>
- Desty, M. (2025). An Examination of Safety Culture in Patient Safety Incident Reporting: A Literature Review Through the Spider Framework. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478). <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v14i3.3981>
- Dos Santos, C. A., Ajayi-Obe, A., & Aurélio, M. (2025). Using Quality Improvement to Improve Serious Incident Reporting in the English NHS. *BMJ Open Quality*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-003234>
- Fekadu, G., Muir, R., Tobiano, G., Ireland, M., Engidaw, M. T., & Marshall, A. P. (2025). Patient Safety Incident Reporting Systems and Reporting Practices in African

- Healthcare Organisations: A Systematic Review and Meta-Analysis. *BMJ Open Quality*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-003202>
- Ferorelli, D., Benevento, M., Vimercati, L., Spagnolo, L., Maria, L. De, Caputi, A., Zotti, F., Mandarelli, G., Dell'Erba, A., & Solarino, B. (2022). Improving Healthcare Workers' Adherence to Surgical Safety Checklist: The Impact of a Short Training. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.732707>
- Gambashidze, N., Wagner, A., Manser, T., Rieger, M. A., Martus, P., & Hammer, A. (2025). A Multi-Group Path Analysis of Medication Documentation Quality Using Cross-Sectional Survey Data: Impact of Leadership, Job Satisfaction, Patient-Related Burnout, and Patient Safety Culture. *Plos One*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0330499>
- Gilmartin, H., Connelly, B., Daus, M., Hess, E., Leonard, C., Morgan, B., Nolan, J. P., Perry, P., Sjoberg, H., Subramaniam, S., & Anderson, M. L. (2024). Implementation of the Acute Inpatient Medicine—High Reliability, Learning Environment, and Workforce Development Initiative (AIM-HI) in Rural Veterans Health Administration Hospitals: A Mixed Methods Evaluation Protocol. *Journal of Hospital Medicine*. <https://doi.org/10.1002/jhm.13474>
- Gqaleni, T. M., & Mkhize, S. W. (2024). Barriers to Implementing Patient Safety Incident Reporting and Learning Guidelines in Specialised Care Units, KwaZulu-Natal: A Qualitative Study. *Plos One*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289857>
- Grew, J., Thomsen, M., & Schiøtz, M. (2022). Intersectoral Ward Rounds on Patients Admitted to Temporary Twenty-Four-Hour Accommodations in Denmark: Case Study. *International Journal of Integrated Care*. <https://doi.org/10.5334/ijic.5688>
- Habibah, T., & Dhamanti, I. (2025). Faktor Yang Menghambat Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit: Literature Review. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 9(4), 449–460. <https://doi.org/10.25077/jka.v9i4.1460>
- Hafezi, A., Babaii, A., Aghaie, B., & Abbasinia, M. (2022). The Relationship Between Patient Safety Culture and Patient Safety Competency With Adverse Events: A Multicenter Cross-Sectional Study. *BMC Nursing*. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-01076-w>
- Hafizha, H. R., Erista Rindu, R. F., & Saluy Ahmad, A. B. (2025). Membangun Budaya Self-Learning Dalam Digital Workplace: Peran Strategis Self-Awareness Dan LMS. *Peshum*. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11134>
- Hardono, H., & Bunga, A. L. (2025). Optimalisasi Penerapan Patient Safety Goals Dalam Pelayanan Keperawatan: Literatur Review. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3051>
- Hussein, M., Pavlova, M., Ghalwash, M., & Groot, W. (2021). The Impact of Hospital Accreditation on the Quality of Healthcare: A Systematic Literature Review. *BMC Health Services Research*. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-07097-6>

- Hutasuhut, N. A. (2025). Peran Kepemimpinan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Academia Jurnal Inovasi Riset Akademik*. <https://doi.org/10.51878/academia.v5i4.8226>
- Imani, A., Alibabayee, R., Golestani, M., & Dalal, K. (2022). Key Indicators Affecting Hospital Efficiency: A Systematic Review. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.830102>
- Jittapranerat, J., & Chinswangwatanakul, W. (2024). A 5-Step Root Cause Analysis Model for Test Overutilization: A Study on Its Application to Plasma Transferrin Testing. *American Journal of Clinical Pathology*. <https://doi.org/10.1093/ajcp/aqae015>
- Kakemam, E., Gharaee, H., Rajabi, M. R., Nadernejad, M., Jelodar, Z. K., Raeissi, P., & Kalhor, R. (2021). Nurses' Perception of Patient Safety Culture and Its Relationship With Adverse Events: A National Questionnaire Survey in Iran. *BMC Nursing*. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00571-w>
- Kasanah, N., Sari, D. P., & Listyorini, P. I. (2025). Hubungan Antara Budaya Keselamatan Pasien Dengan Insiden Keselamatan Pasien Di Pelayanan Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta. *Galen*, 1(2), 307–320. <https://doi.org/10.71417/galen.v1i2.39>
- Kim, N., & Kwak, S. (2024). Relationship Between Nurses' Critical Thinking Disposition and Patient Safety Incident Reporting: The Mediating Role of Patient Safety Culture in a Comprehensive Nursing Service Ward. *Plos One*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315679>
- Koskiniemi, S., Syyrilä, T., Hämeen-Anttila, K., & Härkänen, M. (2025). Handling Features of Patient Safety Incident Reporting Software and Shortcomings in Report Processing From Healthcare Professionals' Perspectives: A Cross-Sectional Study With a Qualitative Design. *Journal of Nursing Management*. <https://doi.org/10.1155/jonm/6724890>
- Lakbala, P., Bordbar, N., & Fakhri, Y. (2024). Root Cause Analysis and Strategies for Reducing Falls Among inpatients in Healthcare Facilities: A Narrative Review. *Health Science Reports*. <https://doi.org/10.1002/hsr2.2216>
- Layli, A. N., Suryawati, C., & Kusumastuti, W. (2023). Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Perawat Di Rumah Sakit. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*. <https://doi.org/10.25026/jsk.v5i5.1758>
- Layli, R. (2022). Pengaruh Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(9), 1708–1714.
- Lee, S. E., Morse, B. L., & Kim, N. W. (2021). Patient Safety Educational Interventions: A Systematic Review With Recommendations for Nurse Educators. *Nursing Open*. <https://doi.org/10.1002/nop2.955>
- Lee, W., & Jang, I. (2023). Effect of Nurses' Professionalism, Work Environment, and Communication With Health Professionals on Patient Safety Culture (AHRQ 2.0.):

- A Cross-Sectional Multicenter Study. *Journal of Nursing Management*. <https://doi.org/10.1155/2023/1591128>
- López, M., Fernández-Castro, M., Martín-Gil, B., Muñoz-Moreno, M. F., & Jiménez, J. M. (2022). Auditing Completion of Nursing Records as an Outcome Indicator for Identifying Patients at Risk of Developing Pressure Ulcers, Falling, and Social Vulnerability: An Observational Study. *Journal of Nursing Management*. <https://doi.org/10.1111/jonm.13569>
- Mehta, N., Sharfuddin, N., Law, M., Ginzburg, A., & Chugh, S. (2022). Patient Safety Incident Analysis in Healthcare: A Novel Curricular Session for Medical Students. *Canadian Medical Education Journal*. <https://doi.org/10.36834/cmej.73327>
- Mike, Irimu, G., Akech, S., Aluvaala, J., Ogero, M., Isaaka, L., Malla, L., Tuti, T., Gathara, D., Oliwa, J., & Agweyu, A. (2021). Employing Learning Health System Principles to Advance Research on Severe Neonatal and Paediatric Illness in Kenya. *BMJ Global Health*. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005300>
- Miller, K. S. (2021). Comparing the Effects of Traditional Education and Root-Cause Analysis on Nursing Students' Attitudes About Safety Culture and Knowledge of Safe Medication Administration Practices. *Nurse Educator*. <https://doi.org/10.1097/nne.0000000000001126>
- Moldskred, P. S., Snibsoer, A. K., & Espehaug, B. (2021). Improving the Quality of Nursing Documentation at a Residential Care Home: A Clinical Audit. *BMC Nursing*. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00629-9>
- Moriwaki, M., Tanaka, M., Kakehashi, M., Koizumi, M., Horiguchi, H., & Hayashida, K. (2025). Influence of Nursing Time and Staffing on Medication Errors: A Cross-Sectional Analysis of Administrative Data. *Nursing Reports*. <https://doi.org/10.3390/nursrep15010012>
- Muda, I. R. (2025). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Di Rsud Haji Abdoel Madjid Batoe Batang Hari. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (Marsi)*, 9(4), 440–454. <https://doi.org/10.52643/marsi.v9i4.6736>
- Mukherjee, S., Roy, S., & Era, N. (2024). Safety Incident Reporting and Barriers (SIRaB) Study: Strategies and Approaches for Investigating Patient Safety Events in a Hospital Set-up. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*. <https://doi.org/10.1111/jep.13990>
- Nash, D. M., Bhimani, Z., Rayner, J., & Zwarenstein, M. (2021). Learning Health Systems in Primary Care: A Systematic Scoping Review. *BMC Family Practice*. <https://doi.org/10.1186/s12875-021-01483-z>
- Nthumba, P., Mwangi, C., & Osoo, M. O. (2024). Patient Safety in a Rural Sub-Saharan Africa Hospital: A 7-Year Experience at the AIC Kijabe Hospital, Kenya. *Plos Global Public Health*. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0003919>

- Nurfuaddi, N., Irwansyah, I., & Shoalihin, S. (2025). Pengaruh Budaya Kerja Digital Dan Adaptasi Teknologi Terhadap Kinerja Karyawan Alfamart Di Era Retail 4.0. *Advances in Management & Financial Reporting*. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.621>
- Oweidat, I., Al-Mugheed, K., Alsenany, S. A., Farghaly Abdelaliem, S. M., & Alzoubi, M. M. (2023). Awareness of Reporting Practices and Barriers to Incident Reporting Among Nurses. *BMC Nursing*. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01376-9>
- Prabowo, A., Mufarrihah, A. T., Pramadya, A. P., & Prayitno, H. (2025). Implementasi Casr Part 830 Dalam Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Di Indonesia. *Education of Aviation Science and Technology*, 3(1), 298–305. <https://doi.org/10.61510/skyeast.v3i1.48>
- Pramesona, B. A., Sukohar, A., Taneepanichskul, S., & Abdillah Rasyid, M. F. (2023). A Qualitative Study of the Reasons for Low Patient Safety Incident Reporting Among Indonesian Nurses. *Revista Brasileira De Enfermagem*. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0583>
- Rigamonti, D., & Rigamonti, K. H. (2021). Achieving and Maintaining Safety in Healthcare Requires Unwavering Institutional and Individual Commitments. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.13192>
- Ropero-Padilla, C., González-Chordá, V. M., Mena-Tudela, D., Román, P. L., Cervera-Gasch, Á., & Rodriguez-Arrastia, M. (2022). Root Cause Analysis for Understanding Patient Safety Incidents in Nursing Student Placements: A Qualitative Content Analysis. *Nurse Education in Practice*. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103462>
- Sarla, G. S. (2025). Human Resource Management in a Health Care Facility. *Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports*. <https://doi.org/10.36502/2025/asjbccr.6393>
- Serou, N., Sahota, L. K., Husband, A., Forrest, S., Slight, R., & Slight, S. P. (2021). Learning From Safety Incidents in High-Reliability Organizations: A Systematic Review of Learning Tools That Could Be Adapted and Used in Healthcare. *International Journal for Quality in Health Care*. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzab046>
- Silvania, S., & Lisum, K. (2024). Systematic Literature Review: Pengaruh Mentoring Terhadap Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. *Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 7642–7661. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i3.36443>
- Smit, C. T., & Peddle, M. (2025). Experiences and Perceptions of Registered Nurses Who Work in Acute Care Regarding Incident Reporting: A Scoping Review. *Healthcare*. <https://doi.org/10.3390/healthcare13111250>
- Smith-Love, J. (2022). Reducing Near Miss Medication Events Using an Evidence-Based Approach. *Journal of Nursing Care Quality*. <https://doi.org/10.1097/ncq.0000000000000630>
- Tlili, M. A., Aouicha, W., Gambashidze, N., Cheikh, A. Ben, Sahli, J., Weigl, M., Mtiraoui,

- A., Chelbi, S., Laatiri, H. S., & Mallouli, M. (2024). A Retrospective Analysis of Adverse Events Reported by Tunisian Intensive Care Units' Professionals. *BMC Health Services Research*. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-10544-9>
- Toyo, E. M., Leki, K. G. B., Indarsari, F., & Woro, S. (2022). Evaluasi Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Dengan Metode HMN Di Rumah Sakit. *Majalah Farmasetika*, 8(1), 56. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v8i1.41357>
- Triana, G. A., Giman, A. W., Muhafid, Ariyanto, C., & Akbar, P. (2023). Tela'ah Yuridis Terhadap Pelayanan Kesehatan Online (Telemedicine) di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/download/48181/30874>
- Ünal, A., Yıldırım, N., & Öncel, S. (2025). Investigation of the Relationship Between Perceived Leadership Behaviours of Nurses and Hospital Safety Culture: A Study With the Structural Equation Model. *International Journal of Nursing Practice*. <https://doi.org/10.1111/ijn.13324>
- Valentin, Y. I. S. (2025). Hubungan Budaya Keselamatan Pasien Dengan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Di RS Ben Mari Malang. *Jurnal Keperawatan Tropis Papua*, 8(2), 118–123. <https://doi.org/10.47539/jktp.v8i2.464>
- Viana, K. E., Matsuda, L. M., Dias Ferreira, A. M., Xavier Reis, G. A., de Souza, V. S., & Marcon, S. S. (2021). Patient Safety Culture From the Perspective of Nursing Professionals. *Texto & Contexto - Enfermagem*. <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2020-0219>
- Wackers, E., Stadhouders, N., Heil, A., Westert, G. P., Dulmen, S. van, & Jeurissen, P. (2021). Hospitals Bending the Cost Curve With Increased Quality: A Scoping Review Into Integrated Hospital Strategies. *International Journal of Health Policy and Management*. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.168>
- Wilson, M.-A., Teper, M. H., Sinno, M., Kohlberger, K., Nuseir, D., Chan, A., Palomera-Dinglasan, K., Leon, L., Donaldson, D., & Taher, A. (2022). Designing and Implementing a Zero Harm Falls Prevention Program. *Journal of Nursing Care Quality*. <https://doi.org/10.1097/ncq.0000000000000617>
- Wulandari, H., Setyaningsih, Y., & Musthofa, S. B. (2023). Beberapa Aspek Dimensi Budaya Keselamatan Pasien Hubungannya Dengan Budaya Lapar : Studi Kasus Di RSUD Kabupaten Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 11(1), 91–98. <https://doi.org/10.14710/jmki.11.1.2023.91-98>
- Yusuf, Y., & Irwan, A. M. (2021). The Influence of Nurse Leadership Style on the Culture of Patient Safety Incident Reporting: A Systematic Review. *British Journal of Healthcare Management*. <https://doi.org/10.12968/bjhc.2020.0083>
- Zehir, S., & Zehir, C. (2023). Effects of Total Quality Management Practices on Financial and Operational Performance of Hospitals. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su152115430>

Glosarium

1	QI	Quality Improvement, yaitu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara sistematis dan berkelanjutan
2	PSIR	Patient Safety Incident Reporting, yaitu sistem pelaporan insiden keselamatan pasien
3	KPRS	Keselamatan Pasien Rumah Sakit, yaitu program untuk menjamin pelayanan kesehatan yang aman
4	KTD	Kejadian Tidak Diharapkan, yaitu insiden yang menyebabkan cedera atau kerugian pada pasien
5	KNC	Kejadian Nyaris Cedera, yaitu insiden yang hampir menyebabkan cedera tetapi berhasil dicegah
6	KTC	Kejadian Tidak Cedera, yaitu insiden yang terjadi namun tidak menimbulkan cedera
7	KPC	Kondisi Potensial Cedera, yaitu situasi yang berpotensi menimbulkan cedera jika tidak ditangani
8	RCA	Root Cause Analysis, yaitu metode analisis untuk mengidentifikasi akar penyebab insiden
9	FMEA	Failure Mode and Effects Analysis, yaitu metode proaktif untuk mengidentifikasi potensi kegagalan sistem
10	PDSA	Plan Do Study Act, yaitu siklus perbaikan mutu berkelanjutan
11	Lean	Metode peningkatan mutu yang berfokus pada pengurangan pemborosan dalam proses pelayanan
12	Six Sigma	Metode peningkatan mutu berbasis data untuk mengurangi variasi dan kesalahan
13	TQM	Total Quality Management, yaitu pendekatan manajemen mutu menyeluruh dalam organisasi
14	ICPS	International Classification for Patient Safety, yaitu klasifikasi internasional keselamatan pasien
15	WHO	World Health Organization, yaitu organisasi kesehatan dunia
16	JCI	Joint Commission International, yaitu lembaga akreditasi internasional pelayanan kesehatan
17	KKP-RS	Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit
18	HRO	High Reliability Organization, yaitu organisasi dengan tingkat keselamatan tinggi dan kesalahan minimal

19	Near Miss	Kejadian nyaris cedera yang tidak sampai menimbulkan dampak pada pasien
20	Adverse Event	Kejadian tidak diharapkan yang berdampak merugikan pasien
21	Just Culture	Budaya organisasi yang adil dan tidak menyalahkan individu atas kesalahan sistem
22	Blame Culture	Budaya menyalahkan individu atas kesalahan yang terjadi
23	Patient Safety	Keselamatan pasien, yaitu upaya pencegahan cedera akibat pelayanan kesehatan
24	Incident Reporting	Proses pelaporan kejadian keselamatan pasien
25	Nurse Staffing	Pengaturan jumlah dan komposisi perawat dalam pelayanan
26	Nurse to Patient Ratio	Perbandingan jumlah perawat dengan jumlah pasien
27	Clinical Audit	Audit klinis, yaitu evaluasi praktik pelayanan berdasarkan standar
28	Continuous Improvement	Upaya perbaikan mutu secara berkelanjutan
29	Medical Error	Kesalahan dalam pelayanan medis yang berpotensi membahayakan pasien
30	Hospital Acquired Infection	Infeksi yang diperoleh pasien selama perawatan di rumah sakit
31	Pressure Injury	Luka tekan akibat tekanan berkepanjangan pada jaringan tubuh
32	Patient Centered Care	Pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan dan keselamatan pasien
33	Evidence Based Practice	Praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah
34	Leadership Keperawatan	Peran kepemimpinan perawat dalam manajemen pelayanan
35	Budaya Keselamatan Pasien	Nilai, sikap, dan perilaku organisasi yang mendukung keselamatan pasien
36	Pelaporan Non-Punitif	Sistem pelaporan tanpa sanksi bagi pelapor
37	Zero Harm	Pendekatan pelayanan dengan tujuan tidak ada cedera yang dapat dicegah

38	Dashboard Mutu	Media pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien
39	Indikator Mutu	Ukuran untuk menilai kualitas pelayanan keperawatan
40	Indikator Struktur	Indikator terkait sumber daya dan fasilitas pelayanan
41	Indikator Proses	Indikator terkait pelaksanaan tindakan keperawatan
42	Indikator Outcome	Indikator terkait hasil pelayanan terhadap pasien

CHAPTER 3

PENGENDALIAN INFEKSI NOSOKOMIAL DAN SANITASI LINGKUNGAN FASILITAS KESEHATAN

Nima Eka Nur Rahmania, S.KM., M.KKK.

A. Pendahuluan

Infeksi nosokomial atau *Healthcare-Associated Infections* (HAIs) merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan mutu layanan dan keselamatan pasien. HAIs didefinisikan sebagai infeksi yang didapatkan pasien selama menjalani perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak sedang dalam masa inkubasi pada saat pasien pertama kali menerima pelayanan kesehatan, umumnya muncul setelah 48 jam perawatan atau lebih (Horan et al., 2008). Dalam praktik pelayanan kesehatan, kejadian HAIs sering kali berkaitan erat dengan prosedur medis dan keperawatan, penggunaan alat invasif, serta kondisi lingkungan fasilitas kesehatan yang belum dikelola secara optimal.

Secara global, WHO melaporkan bahwa prevalensi HAIs masih relatif tinggi, yaitu sekitar 7% di negara maju dan meningkat hingga 10-15% di negara berkembang. Negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan yang lebih besar akibat keterbatasan sumber daya, kepadatan pasien, serta variasi kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pencegahan dan pengendalian infeksi (Allegranzi et al., 2018). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa HAIs berkontribusi terhadap peningkatan angka kesakitan dan kematian, memperpanjang lama rawat inap, meningkatkan penggunaan antibiotik, serta menambah beban biaya pelayanan kesehatan baik bagi pasien maupun institusi pelayanan kesehatan (Haque et al., 2018).

Dalam konteks Indonesia, pengendalian infeksi nosokomial telah menjadi perhatian penting pemerintah melalui penguatan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di fasilitas pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan bahwa setiap rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan program PPI secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Data nasional menunjukkan bahwa jenis HAIs yang paling sering terjadi di rumah sakit meliputi infeksi luka operasi, infeksi saluran

kemih terkait penggunaan kateter, pneumonia terkait ventilator, serta infeksi aliran darah akibat pemasangan kateter intravena. Tingginya kejadian tersebut menunjukkan bahwa risiko infeksi masih menjadi tantangan nyata dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari.

Upaya pengendalian infeksi nosokomial di fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat hanya berfokus pada tindakan klinis dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur medis, tetapi harus didukung oleh pengelolaan sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan yang memadai. Sanitasi lingkungan mencakup penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan, pengelolaan limbah medis dan nonmedis, kebersihan ruangan dan permukaan, sistem ventilasi yang baik, serta pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Lingkungan fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi standar sanitasi berpotensi menjadi reservoir mikroorganisme patogen dan media penularan infeksi, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung (*Centers for Disease Control and Prevention* [CDC], 2019).

Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas sanitasi lingkungan memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian HAIs. Permukaan lingkungan yang sering disentuh, kualitas udara di ruang perawatan, serta sistem pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar terbukti meningkatkan risiko transmisi mikroorganisme patogen di rumah sakit (Dancer, 2014). Oleh karena itu, dalam praktik di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, pengendalian infeksi nosokomial harus dilaksanakan melalui pendekatan aplikatif yang mengintegrasikan kebijakan PPI, kepatuhan tenaga kesehatan, serta pengelolaan sanitasi lingkungan yang sesuai dengan regulasi nasional dan standar internasional.

Bab ini membahas secara aplikatif konsep infeksi nosokomial, mekanisme penularan di fasilitas pelayanan kesehatan, strategi pencegahan dan pengendalian infeksi yang dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta peran sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan sebagai komponen penting dalam upaya peningkatan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya dalam konteks sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

B. Konsep, Karakteristik dan Jenis Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial atau *Healthcare-Associated Infections* (HAIs) merupakan infeksi yang muncul pada pasien setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu tertentu, umumnya ≥ 48 jam setelah dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan, dan tidak sedang berada dalam masa inkubasi pada saat pasien pertama kali masuk fasilitas tersebut atau dapat terjadi setelah pasien pulang dari fasilitas kesehatan apabila berkaitan dengan pelayanan yang diterima (*World Health*

Organization [WHO], 2016). Karakteristik utama infeksi nosokomial meliputi keterkaitannya dengan tindakan medis, prosedur invasif, serta paparan lingkungan fasilitas kesehatan. Dalam praktik pelayanan kesehatan, HAIs digunakan sebagai indikator penting untuk menilai mutu pelayanan, efektivitas penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta tingkat keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan sumbernya, infeksi nosokomial dapat diklasifikasikan menjadi infeksi endogen dan eksogen. Infeksi endogen berasal dari flora normal pasien yang berubah menjadi patogen oportunistik akibat menurunnya sistem imun, tindakan invasif, atau penggunaan antibiotik spektrum luas. Sementara itu, infeksi eksogen berasal dari luar tubuh pasien, termasuk tenaga kesehatan, pasien lain, alat kesehatan, serta lingkungan fasilitas kesehatan seperti udara, air, dan permukaan benda mati (*fomites*) (Siegel et al., 2024).

Tabel 1.1: Sumber Infeksi Nosokomial Berdasarkan Mekanisme Penularan

No	Sumber Infeksi	Contoh	Implikasi Pengendalian
1	Endogen	Flora normal pasien	Pengendalian penggunaan antibiotik
2	Eksogen	Alat medis, tangan petugas	Kepatuhan PPI dan kebersihan tangan
3	Lingkungan	Udara, air, permukaan	Sanitasi dan desinfeksi lingkungan

Sumber : Diadaptasi dari WHO (2011) dan CDC (2019)

Mikroorganisme penyebab HAIs meliputi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Bakteri merupakan penyebab dominan, khususnya bakteri gram negatif seperti *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, dan *Pseudomonas aeruginosa*, serta bakteri gram positif seperti *Staphylococcus aureus*, termasuk *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA). Mikroorganisme tersebut diketahui mampu bertahan hidup di permukaan lingkungan rumah sakit selama beberapa hari hingga minggu, sehingga meningkatkan risiko penularan silang apabila sanitasi lingkungan tidak dikelola secara optimal (Magill et al., 2018).

The Centers for Disease Control (CDC) melaporkan bahwa terdapat beberapa jenis infeksi nosokomial yang paling sering terjadi dan menjadi fokus utama berdasarkan pedoman resmi dan surveilans HAIs CDC melalui *National Healthcare Safety Network* (NHSN) sebagai berikut (CDC, 2024):

1. Central Line-Associated Bloodstream Infection (CLABSI)

Central Line-Associated Bloodstream Infection (CLABSI) adalah infeksi aliran darah yang terjadi pada pasien dengan kateter vena sentral, dimana sumber

infeksi tidak berasal dari fokus infeksi lain dan berkaitan secara langsung dengan penggunaan central line. Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) melalui NHSN, CLABSI umumnya muncul ≥ 48 jam setelah pemasangan kateter dan sering ditemukan pada pasien di unit perawatan intensif. Mikroorganisme penyebab CLABSI meliputi bakteri gram positif, gram negatif, serta jamur, dengan peningkatan risiko resistensi antimikroba. Faktor risiko utama meliputi durasi pemasangan kateter, teknik aseptik yang tidak optimal, perawatan kateter yang tidak adekuat, serta kondisi imunitas pasien.

2. Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI)

Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) merupakan infeksi saluran kemih yang terjadi pada pasien dengan kateter urin yang terpasang, di mana infeksi tidak ada atau tidak sedang dalam masa inkubasi saat pemasangan kateter dilakukan. CDC mendefinisikan CAUTI sebagai salah satu HAIs yang paling sering terjadi karena penggunaan kateter urin yang luas di fasilitas kesehatan. Karakteristik utama CAUTI adalah kolonisasi dan invasi mikroorganisme melalui sistem kateter, baik secara intraluminal maupun ekstraluminal. Faktor risiko mencakup lama penggunaan kateter, teknik pemasangan yang tidak steril, sistem drainase yang terbuka, serta perawatan kateter yang tidak sesuai standar.

3. Surgical Site Infection (SSI)

Surgical Site Infection (SSI) adalah infeksi yang terjadi pada area insisi atau jaringan yang terlibat dalam prosedur pembedahan, baik superfisial, dalam, maupun organ, dalam rentang waktu tertentu setelah operasi. SSI merupakan indikator penting mutu pelayanan bedah dan pencegahan infeksi di fasilitas kesehatan. Karakteristik SSI melibatkan kontaminasi mikroorganisme selama atau setelah prosedur pembedahan, yang dipengaruhi oleh faktor pasien (status nutrisi, diabetes, obesitas), faktor prosedur (durasi operasi, teknik bedah), serta faktor lingkungan (sterilisasi alat, kebersihan ruang operasi). CDC melalui NHSN menggunakan klasifikasi SSI untuk pemantauan epidemiologis dan evaluasi efektivitas praktik pencegahan, termasuk profilaksis antibiotik yang tepat dan kontrol infeksi di ruang bedah.

4. Ventilator-Associated Events (VAE)

Ventilator-Associated Events (VAE) merupakan kategori surveilans CDC yang mencakup berbagai komplikasi paru pada pasien yang menggunakan ventilator mekanik, termasuk *ventilator-associated pneumonia* (VAP). CDC mengembangkan pendekatan VAE untuk meningkatkan objektivitas pengukuran dan fokus pada perubahan kondisi respirasi pasien. Karakteristik infeksi pernapasan terkait ventilator meliputi kolonisasi mikroorganisme pada saluran napas bawah, aspirasi sekret, serta gangguan mekanisme pertahanan paru. Risiko

meningkat pada pasien dengan penggunaan ventilator jangka panjang, kebersihan mulut yang buruk, serta posisi tubuh yang tidak adekuat.

5. *Clostridioides Difficile Infection (CDI)*

Clostridioides difficile Infection (CDI) adalah infeksi saluran cerna yang disebabkan oleh *C. difficile*, bakteri pembentuk spora yang sering berkaitan dengan penggunaan antibiotik di fasilitas kesehatan. CDC memasukkan CDI sebagai bagian dari surveilans HAIs karena dampaknya yang signifikan terhadap morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan. Karakteristik CDI meliputi diare berulang, kolitis, dan potensi komplikasi berat, terutama pada pasien lanjut usia dan pasien dengan terapi antibiotik jangka panjang. Spora *C. difficile* mampu bertahan di lingkungan fasilitas kesehatan dan berkontribusi pada penularan nosokomial.

6. *Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Bloodstream Infection*

MRSA bloodstream infection adalah infeksi aliran darah yang disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap antibiotik golongan *beta-laktam*. CDC memantau MRSA sebagai bagian dari HAIs karena perannya dalam resistensi antimikroba dan infeksi berat di fasilitas kesehatan. Karakteristik utama MRSA meliputi keterkaitannya dengan prosedur invasif, luka operasi, dan penggunaan alat medis seperti kateter. Penularan MRSA dapat terjadi melalui kontak langsung maupun lingkungan yang terkontaminasi.

C. Epidemiologi Infeksi Nosokomial di Fasilitas Kesehatan

Secara global, *World Health Organization (WHO)* melaporkan bahwa beban HAIs masih tinggi, dengan estimasi sekitar 7% pasien rawat inap di negara berpenghasilan tinggi dan hingga 15% pasien di negara berpenghasilan rendah dan menengah mengalami HAI. WHO juga menegaskan bahwa sebagian besar HAIs berkaitan dengan penggunaan alat medis invasif, kepatuhan kebersihan tangan, serta kualitas sanitasi dan higiene lingkungan fasilitas kesehatan (WHO, 2024).

Secara regional, epidemiologi *Healthcare-Associated Infections (HAIs)* di Indonesia menunjukkan beban yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data dan rujukan yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi infeksi nosokomial di Indonesia dilaporkan sekitar 15,74%, angka yang berada di atas kisaran prevalensi HAIs di banyak negara Asia Tenggara. Tingginya angka ini berkaitan dengan variasi kapasitas fasilitas kesehatan, kepatuhan terhadap praktik pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta sistem surveilans yang masih terus diperkuat secara nasional (Kemenkes, 2024).

Sebagai perbandingan, negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam umumnya melaporkan prevalensi HAIs rumah sakit pada kisaran 6-10%, sedangkan Singapura melaporkan prevalensi yang lebih rendah, umumnya di bawah 6%. Perbedaan ini menegaskan bahwa penguatan sistem PPI, sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan, serta pelaporan surveilans yang konsisten berperan besar dalam menurunkan beban HAIs di tingkat nasional.

D. Rantai Penularan Infeksi

Penularan infeksi nosokomial terjadi melalui suatu mekanisme yang dikenal sebagai rantai penularan infeksi, yang terdiri atas enam komponen utama, yaitu agen infeksi, reservoir, pintu keluar, cara penularan, pintu masuk, dan pejamu rentan. Rantai ini bersifat saling berkaitan, sehingga pemutusan salah satu mata rantai dapat secara signifikan menurunkan risiko terjadinya infeksi nosokomial (Siegel et al., 2024).

1. Agen Infeksi

Agen infeksi atau patogen merupakan mikroorganisme penyebab infeksi meliputi bakteri, virus, jamur, dan parasit yang mampu menyebabkan penyakit menular. Mikroorganisme patogen yang sering terlibat dalam HAIs antara lain *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, serta *Pseudomonas aeruginosa*. Adapun faktor yang mempengaruhi mikroorganisme agar dapat menyebabkan infeksi antara lain: organisme harus dalam jumlah yang cukup, virulensi, dan kemampuan mikroorganisme untuk masuk dan bertahan hidup dalam pejamu.

2. Reservoir

Reservoir merupakan tempat hidup dan berkembangnya agen infeksi, seperti manusia (pasien dan tenaga kesehatan), alat medis, air, udara, serta permukaan lingkungan. Pada manusia reservoir dapat ditemukan di mukosa mulut, permukaan kulit, saluran napas bagian atas, dan organ tubuh lain. Lingkungan rumah sakit yang terkontaminasi berperan besar sebagai reservoir patogen.

3. Pintu Keluar (*Portal of exit*)

Pintu keluar adalah media keluarnya mikroorganisme dari reservoir, seperti darah, cairan tubuh, droplet pernapasan, sekret luka, atau feses. Sebagai salah satu contoh yaitu patogen penyebab penyakit infeksi pernafasan biasanya keluar melalui hidung atau mulut seseorang.

4. Cara Penularan atau Metode Transmisi

Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung melalui alat atau permukaan, droplet, airborne, maupun media lingkungan seperti air dan udara (Reuter-Sandquist & RN, 2022).

a. Kontak

Transmisi melalui kontak terjadi ketika agen infeksi berpindah dari sumber infeksi ke penjamu yang rentan melalui interaksi langsung maupun tidak langsung.

- 1) *Kontak langsung* merupakan penularan yang terjadi melalui interaksi fisik secara langsung antara manusia, seperti melalui jalur fekal-oral atau sentuhan permukaan tubuh. Penularan ini dapat terjadi saat tindakan yang melibatkan kontak dengan tubuh penjamu. Contohnya adalah penularan virus hepatitis A, herpes simpleks, *Shigella*, dan *Staphylococcus*.
- 2) *Kontak tidak langsung* terjadi ketika penjamu yang rentan bersentuhan dengan benda mati yang telah terkontaminasi oleh agen infeksi. Contohnya adalah penularan virus hepatitis B melalui penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi.
- 3) *Droplet* merupakan penularan melalui percikan partikel cair berukuran relatif besar yang keluar saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara, dan mengenai penjamu yang rentan dalam jarak dekat. Penyakit yang dapat menular melalui mekanisme ini antara lain influenza, rubella, dan measles.

b. Udara

Penularan melalui udara terjadi ketika agen infeksi terbawa oleh droplet nucleus atau residu droplet yang telah menguap, kemudian melayang di udara atau menempel pada partikel debu. Agen infeksi ini dapat terhirup oleh penjamu yang rentan. Contoh penyakit yang ditularkan melalui udara adalah tuberkulosis yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, rubella yang disebabkan oleh virus *rubeola*, serta cacar air yang disebabkan oleh virus *varicella*.

c. Peralatan

Transmisi juga dapat terjadi melalui penggunaan peralatan atau bahan yang terkontaminasi, seperti air, obat-obatan dan larutan medis, darah, serta makanan yang tidak diolah dengan baik. Peralatan atau bahan tersebut dapat menjadi media perantara perpindahan agen infeksi ke tubuh manusia.

d. Vektor

Penularan melalui vektor melibatkan organisme hidup yang membawa agen infeksi dari satu inang ke inang lainnya. Mekanisme transmisi vektor terdiri atas dua cara, yaitu:

- 1) *Transmisi mekanis eksternal*, dimana agen infeksi berpindah secara pasif melalui permukaan tubuh vektor, misalnya penularan penyakit kolera melalui lalat.
- 2) *Transmisi internal*, yaitu ketika agen infeksi berkembang atau mengalami siklus hidup di dalam tubuh vektor sebelum ditularkan ke manusia, seperti penularan malaria oleh nyamuk.

5. Pintu Masuk (Portal of Entry)

Merupakan jalan yang digunakan oleh agen infeksi untuk masuk kedalam penjamu yang rentan melalui rute yang sama untuk keluar. Mikroorganisme masuk kedalam tubuh pejamu melalui luka terbuka, saluran pernapasan, saluran pencernaan, atau melalui alat invasif seperti kateter dan ventilator.

6. Pejamu Rentan (*Susceptible Host*)

Merupakan seseorang yang beresiko tinggi terpapar infeksi karena memiliki sistem pertahanan kekebalan tubuh yang lemah. Pejamu rentan meliputi pasien dengan daya tahan tubuh rendah, bayi, lansia, pasien dengan penyakit kronis, serta pasien dengan tindakan invasif. Di lingkungan pelayanan kesehatan seluruh pasien dianggap sebagai penjamu yang rentan karena sudah memiliki penyakit sebelumnya dan perawatan medis.

Sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam memutus rantai penularan infeksi, khususnya pada komponen reservoir dan cara penularan. Pengelolaan kebersihan lingkungan, kualitas udara, air bersih, serta desinfeksi permukaan secara rutin terbukti mampu menurunkan kepadatan mikroorganisme patogen di lingkungan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pengendalian HAIs harus dilakukan melalui pendekatan epidemiologis yang terintegrasi antara PPI, sanitasi lingkungan, dan perilaku tenaga kesehatan.



Gambar 3.1: Rantai Penularan Infeksi di Fasilitas Kesehatan

E. Faktor Risiko Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial (*Healthcare-Associated Infections*, HAIs) muncul karena interaksi kompleks antara kondisi pasien, prosedur medis, tenaga kesehatan, dan lingkungan fasilitas kesehatan. Secara umum, faktor-faktor yang meningkatkan risiko HAI dapat dikelompokkan menjadi: faktor pasien, faktor prosedural atau alat, faktor sistem pelayanan (tenaga kesehatan), faktor lingkungan, dan faktor terkait penggunaan antibiotik atau resistensi antimikroba (Shrestha et.al., 2022).

1. Faktor pasien

Pasien lanjut usia atau pasien dengan komorbiditas seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit paru kronik, pasien imunokompromis, dan pasien yang memiliki luka atau kondisi kulit rentan memiliki risiko HAIs lebih tinggi karena berkurangnya kemampuan pertahanan tubuh. Selain itu, lama rawat inap yang panjang juga berasosiasi kuat dengan peningkatan risiko HAIs.

2. Faktor prosedural dan penggunaan alat medis invasif

Penggunaan perangkat invasif (kateter intravena pusat, kateter urin, ventilator mekanik, drain) adalah determinan utama kejadian HAIs tertentu, seperti CLABSI, CAUTI, dan VAP. Risiko meningkat sebanding dengan durasi penggunaan alat, teknik pemasangan yang tidak aseptik, dan perawatan alat yang tidak sesuai pedoman. Oleh karena itu banyak program pencegahan fokus pada "*device-associated bundles*" untuk menurunkan kejadian.

3. Faktor tenaga kesehatan dan praktik klinis

Kepatuhan terhadap kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, teknik aseptik saat prosedur, serta kebijakan pembersihan dan disinfeksi instrumen memengaruhi transmisi patogen. Perpindahan pasien antar unit atau antar fasilitas tanpa komunikasi yang memadai juga meningkatkan risiko penyebaran kuman antar lingkungan layanan.

4. Faktor lingkungan dan sanitasi fasilitas kesehatan

Kualitas WASH (*water, sanitation, hygiene*) di fasilitas kesehatan, pemeliharaan ventilasi, serta kebersihan permukaan dan peralatan merupakan faktor penting. Spora seperti *Clostridioides difficile* dan organisme resisten dapat bertahan di lingkungan dan menjadi sumber penularan jika dekontaminasi lingkungan tidak memadai.

5. Penggunaan antibiotik dan resistensi antimikroba (AMR)

Terapi antibiotik yang tidak tepat (indikasi, dosis, dan durasi) mendorong seleksi bakteri resisten yang selanjutnya meningkatkan risiko infeksi nosokomial yang sulit diobati. Tren kenaikan AMR memperburuk beban HAIs global dan lokal, sehingga program *antimicrobial stewardship* menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pencegahan.

6. Setting perawatan (ICU, neonatal, dan pembedahan besar)

Unit perawatan intensif (ICU), unit neonatal, dan pasien bedah mayor menunjukkan insiden HAI yang lebih tinggi karena frekuensi prosedur invasif, beban penyakit yang berat, dan paparan yang intensif terhadap berbagai perangkat medis. Banyak studi menunjukkan konsentrasi HAI dan organisme resisten yang lebih tinggi berada di ICU.

F. Sanitasi Lingkungan Fasilitas Kesehatan

Sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial. Lingkungan fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi berpotensi menjadi reservoir dan media penularan berbagai mikroorganisme patogen, baik melalui udara, air, permukaan lingkungan, maupun vektor. Oleh karena itu, sanitasi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), melainkan harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.

WHO menegaskan bahwa fasilitas kesehatan wajib menyediakan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat guna melindungi pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, serta masyarakat sekitar dari risiko penularan penyakit infeksi (WHO, 2019). Di Indonesia, persyaratan sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit serta regulasi teknis terkait pengelolaan air bersih, limbah medis, kualitas udara, dan pengendalian vektor (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Salah satu komponen utama sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan adalah **penyediaan air bersih**. Air bersih diperlukan untuk berbagai aktivitas pelayanan kesehatan, termasuk kebersihan tangan, pembersihan alat, sanitasi ruangan, dan kebutuhan pasien. Air yang terkontaminasi mikroorganisme patogen dapat menjadi sumber penularan infeksi, terutama infeksi saluran pencernaan dan infeksi kulit. Oleh karena itu, kualitas air di fasilitas kesehatan harus memenuhi standar fisik, kimia, dan mikrobiologis sesuai ketentuan yang berlaku.

Komponen berikutnya adalah **pengelolaan limbah medis dan nonmedis**. Limbah medis yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi sumber penularan penyakit serta membahayakan tenaga kesehatan dan lingkungan. Pengelolaan limbah medis harus dilakukan secara sistematis mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara, hingga pemusnahan sesuai dengan klasifikasi limbah dan standar keselamatan. Kementerian Kesehatan RI (2019) menekankan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan limbah

merupakan indikator penting dalam pelaksanaan sanitasi lingkungan rumah sakit dan pemenuhan standar akreditasi.

Selain itu, **kebersihan lingkungan dan permukaan** merupakan faktor penting dalam memutus rantai penularan infeksi. Permukaan yang sering disentuh (*high-touch surfaces*) seperti gagang pintu, tempat tidur pasien, meja perawatan, dan alat medis berpotensi terkontaminasi mikroorganisme patogen. Penelitian menunjukkan bahwa pembersihan dan desinfeksi lingkungan yang tidak optimal berkontribusi terhadap peningkatan kejadian HAIs, terutama infeksi oleh bakteri resisten (CDC, 2019). Oleh karena itu, pembersihan dan desinfeksi lingkungan harus dilakukan secara rutin dengan menggunakan bahan dan metode yang sesuai standar.

Ventilasi dan kualitas udara juga memegang peranan penting dalam sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan. Sistem ventilasi yang baik dapat mengurangi konsentrasi mikroorganisme di udara dan menurunkan risiko penularan infeksi melalui udara (*airborne transmission*). Ruang isolasi, ruang operasi, dan unit perawatan intensif memerlukan sistem ventilasi khusus dengan pengaturan tekanan dan filtrasi udara yang memadai. Pengendalian kualitas udara menjadi semakin penting dalam menghadapi penyakit infeksi menular yang menyebar melalui droplet dan aerosol.

Komponen sanitasi lingkungan lainnya adalah **pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit**. Keberadaan serangga dan hewan pengerat di fasilitas kesehatan dapat menjadi media penularan penyakit dan mencerminkan buruknya pengelolaan lingkungan. Program pengendalian vektor harus dilakukan secara terpadu melalui perbaikan sanitasi, penggunaan perangkap, dan pengendalian kimiawi yang aman dan terkontrol.

Secara keseluruhan, sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan berperan strategis dalam mendukung keberhasilan program PPI. Lingkungan yang bersih dan sehat tidak hanya menurunkan risiko terjadinya infeksi nosokomial, tetapi juga meningkatkan kenyamanan pasien, keselamatan tenaga kesehatan, serta citra mutu pelayanan kesehatan.

G. Peran Sumber Daya Manusia, Monitoring, dan Audit PPI

Keberhasilan pengendalian infeksi nosokomial tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan kebijakan, tetapi sangat bergantung pada peran dan perilaku sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan faktor utama dalam implementasi program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), karena hampir seluruh aktivitas pelayanan berpotensi menjadi jalur penularan mikroorganisme patogen apabila tidak dilakukan sesuai standar. Oleh karena itu, kompetensi, sikap, dan kepatuhan

tenaga kesehatan terhadap prinsip PPI dan sanitasi lingkungan menjadi faktor penentu dalam menurunkan kejadian *Healthcare-Associated Infections* (HAIs) (Mitchell, 2018).

SDM di fasilitas kesehatan mencakup tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, petugas laboratorium, petugas kebersihan, hingga tenaga nonkesehatan yang terlibat dalam operasional fasilitas kesehatan. Setiap kelompok SDM memiliki peran spesifik dalam rantai pengendalian infeksi. Tenaga medis dan keperawatan bertanggung jawab terhadap penerapan kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), praktik aseptik dan antiseptik, serta kepatuhan terhadap prosedur invasif yang aman. Sementara itu, sanitarian dan petugas kebersihan berperan penting dalam menjaga sanitasi lingkungan, kebersihan permukaan, serta pengelolaan limbah medis dan nonmedis (CDC, 2019).

Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan PPI secara berkelanjutan merupakan strategi utama dalam membangun budaya keselamatan pasien. WHO menekankan bahwa pelatihan PPI tidak boleh bersifat satu kali, melainkan harus dilakukan secara periodik dan disesuaikan dengan risiko kerja masing-masing unit pelayanan. Di Indonesia, pelatihan PPI menjadi salah satu persyaratan dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit dan harus terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari sistem manajemen mutu (Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2022).

Selain kompetensi SDM, keberhasilan PPI juga ditentukan oleh sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Monitoring PPI dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar operasional prosedur (SOP) PPI, seperti kepatuhan kebersihan tangan, penggunaan APD, dan praktik aseptik. Monitoring yang dilakukan secara rutin dan sistematis memungkinkan fasilitas kesehatan untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi serta merancang intervensi perbaikan yang tepat sasaran.

Audit PPI merupakan bagian dari proses evaluasi yang bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan PPI dengan standar yang telah ditetapkan. Audit dapat dilakukan dalam bentuk audit kepatuhan, audit lingkungan, maupun audit dokumen. Hasil audit PPI menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, perbaikan kebijakan, serta penguatan kapasitas SDM. Penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang secara konsisten melakukan audit PPI dan memberikan umpan balik kepada tenaga kesehatan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan angka HAIs yang lebih rendah (Allegranzi et al., 2018).

Di Indonesia, pelaksanaan monitoring dan audit PPI telah diatur dalam Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan membentuk Tim PPI yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program PPI. Tim PPI juga berperan dalam menyusun laporan berkala, melakukan investigasi kejadian infeksi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen fasilitas kesehatan.

Dengan demikian, sinergi antara kompetensi SDM, sistem monitoring yang efektif, dan audit PPI yang berkelanjutan merupakan fondasi utama dalam pengendalian infeksi nosokomial. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan kejadian HAIs, tetapi juga memperkuat budaya keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

H. Tantangan dan Best Practice Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia

1. Tantangan dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan komponen esensial dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien (patient safety) dan mutu layanan. Infeksi nosokomial atau *Healthcare-Associated Infections* (HAIs) didefinisikan sebagai infeksi yang muncul pada pasien selama perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak berada dalam masa inkubasi pada saat masuk fasilitas tersebut. Secara global, HAIs masih menjadi masalah serius karena berkontribusi terhadap meningkatnya angka kesakitan, kematian, lama rawat inap, serta beban biaya kesehatan.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, risiko HAIs relatif lebih tinggi akibat keterbatasan sumber daya, kepadatan pasien, dan variasi kepatuhan terhadap standar PPI. Oleh karena itu, implementasi PPI yang efektif menjadi prioritas strategis dalam sistem kesehatan nasional.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi

Salah satu tantangan utama implementasi PPI di Indonesia adalah keterbatasan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus di bidang PPI. Studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap praktik dasar PPI, seperti kebersihan tangan (*hand hygiene*) dan penggunaan alat pelindung diri (APD), masih belum optimal. Data penelitian rumah sakit di Indonesia menunjukkan bahwa kejadian HAIs masih cukup tinggi, dengan ILO (Infeksi Luka Operasi) 18,9%, ISK (Infeksi Saluran Kemih) 15,1%, IADP (Infeksi Aliran Darah Perifer) 26,4%, Pneumonia 24,5% dan Infeksi Saluran Napas lain 15,1%, serta infeksi lain 32,1% (Sulistyowati, 2024). Kondisi ini mencerminkan

perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan supervisi yang konsisten.

b. Ketimpangan Infrastruktur dan Sarana Pendukung

Ketersediaan infrastruktur PPI di fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia masih belum merata. Rumah sakit rujukan nasional dan fasilitas di wilayah perkotaan umumnya memiliki sarana yang lebih memadai, seperti fasilitas cuci tangan, ruang isolasi, dan sistem sterilisasi terstandar. Sebaliknya, fasilitas di daerah terpencil dan perdesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sarana tersebut. Ketimpangan ini berdampak langsung pada efektivitas penerapan standar PPI, khususnya dalam pengendalian transmisi mikroorganisme patogen di lingkungan perawatan.

c. Keterbatasan Sistem Surveilans dan Laboratorium

Surveilans infeksi merupakan fondasi utama dalam pencegahan HAIs. Namun, banyak fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia belum memiliki sistem surveilans yang berjalan optimal, terutama karena keterbatasan dukungan laboratorium mikrobiologi, termasuk pemeriksaan kultur dan uji kepekaan antibiotik (*Antimicrobial Susceptibility Testing*) (Sirait et al., 2025). Keterbatasan ini menyebabkan data HAIs sering kali tidak lengkap atau tidak representatif, sehingga menyulitkan evaluasi risiko dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

d. Komitmen Manajemen dan Tata Kelola

Keberhasilan program PPI sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dukungan manajerial, baik dalam bentuk kebijakan, alokasi anggaran, maupun penguatan tim PPI, menjadi penghambat utama implementasi program secara berkelanjutan. Tanpa dukungan struktural yang kuat, upaya PPI sering kali bersifat administratif dan tidak terintegrasi dalam budaya keselamatan pasien.

2. Best Practice dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Best practice PPI di fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia merupakan integrasi antara kebijakan nasional, standar akreditasi, dan praktik berbasis bukti. Penguatan tata kelola, surveilans HAIs, kepatuhan kebersihan tangan, peningkatan kompetensi SDM, serta monitoring berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan implementasi PPI dalam menurunkan HAIs dan meningkatkan keselamatan pasien.

a. Tata Kelola dan Organisasi Program PPI

Best practice PPI dimulai dari penguatan tata kelola organisasi. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib membentuk Tim atau Komite PPI yang ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan fasilitas. Tim PPI berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi seluruh kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi.

Struktur organisasi PPI idealnya melibatkan unsur manajemen, tenaga medis, keperawatan, dan profesi kesehatan lain, termasuk IPCN (*Infection Prevention and Control Nurse*) dan IPCLN (*Infection Prevention and Control Link Nurse*). Dukungan kebijakan dan sumber daya dari pimpinan fasilitas menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program PPI sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

b. Implementasi Surveilans HAIs sebagai Praktik Terbaik

Surveilans HAIs merupakan pilar utama dalam program PPI. Best practice surveilans dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis standar yang jelas. Surveilans mencakup kegiatan pengumpulan, analisis, interpretasi, serta pelaporan data kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan.

Jenis HAIs yang menjadi prioritas surveilans di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain *Ventilator-Associated Pneumonia* (VAP), Infeksi Daerah Operasi (IDO), Infeksi Saluran Kemih (ISK) terkait kateter, dan flebitis. Data surveilans digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Pendekatan surveilans ini selaras dengan komponen inti PPI yang direkomendasikan oleh *World Health Organization*.

c. Kepatuhan Kebersihan Tangan dan Kewaspadaan Standar

Kepatuhan terhadap kebersihan tangan dan kewaspadaan standar merupakan praktik PPI yang paling efektif dan berbasis bukti ilmiah. Best practice di fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa implementasi program kebersihan tangan yang terstruktur dapat menurunkan angka HAIs secara signifikan.

Prinsip *Five Moments for Hand Hygiene* menjadi dasar dalam pelaksanaan kebersihan tangan, didukung oleh ketersediaan sarana, edukasi berkelanjutan, serta audit kepatuhan. Selain itu, penerapan kewaspadaan standar seperti penggunaan alat pelindung diri, pengelolaan limbah medis, dan dekontaminasi alat kesehatan menjadi bagian integral dari praktik PPI.

d. Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Program PPI

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan PPI. Best practice PPI menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga

kesehatan melalui pelatihan, supervisi, dan evaluasi berkala. IPCN dan IPCLN memiliki peran strategis dalam edukasi, surveilans, dan monitoring kepatuhan PPI di unit pelayanan. Penguatan kapasitas SDM PPI tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga membangun budaya keselamatan pasien di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

e. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari siklus peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Best practice PPI menuntut adanya audit rutin, analisis akar masalah, serta tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil surveilans dan evaluasi kepatuhan. Hasil monitoring dan evaluasi PPI harus dilaporkan kepada manajemen sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

I. Simpulan

Pengendalian infeksi nosokomial atau *Healthcare-Associated Infections* (HAIs) merupakan tantangan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik di tingkat global maupun nasional. Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam buku ini, dapat disimpulkan bahwa kejadian HAIs tidak hanya dipengaruhi oleh faktor klinis dan tindakan medis semata, tetapi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi pasien, perilaku tenaga kesehatan, sistem pelayanan, serta kualitas sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan. Penerapan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang efektif terbukti sangat bergantung pada kekuatan tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, sistem surveilans yang berjalan baik, serta dukungan sanitasi lingkungan yang memenuhi standar. Lingkungan fasilitas kesehatan yang bersih, aman, dan terkelola dengan baik berperan penting dalam memutus rantai penularan infeksi, khususnya pada aspek reservoir dan mekanisme transmisi mikroorganisme patogen. Keberhasilan pengendalian infeksi nosokomial tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial. Upaya pencegahan yang hanya berfokus pada kepatuhan individu tanpa dukungan sistem, atau sebaliknya hanya mengandalkan kebijakan tanpa penguatan perilaku dan budaya keselamatan, tidak akan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pengendalian HAIs harus dipandang sebagai upaya kolektif yang berkelanjutan, melibatkan seluruh komponen fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari pimpinan hingga petugas operasional di lini terdepan. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai upaya penguatan pengendalian infeksi nosokomial dan sanitasi lingkungan fasilitas kesehatan antara lain : 1) penguatan komitmen manajemen dan kepemimpinan, 2) peningkatan kompetensi dan budaya keselamatan SDM, 3) penguatan sistem surveillance HAIs berbasis bukti, 4) optimalisasi sanitasi

lingkungan fasilitas kesehatan, 5) monitoring, audit, dan perbaikan berkelanjutan, 6) pengembangan riset dan inovasi PPI.

Referensi

- Allegranzi, B., Kilpatrick, C., Storr, J. (2018). Global infection prevention and control priorities 2018-22: A call for action. *The Lancet Global Health*, 6(9), e1017-e1026.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2019). *Guideline for infection prevention and control in healthcare facilities*.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Current HAI Progress Report*.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *CDC's Core Infection Prevention and Control Practices for Safe Healthcare Delivery in All Settings*
- Dancer, S. J. (2014). Focus on the role of the environment and new technologies for decontamination. *Clinical Microbiology Reviews*, 27(4), 665-690.
- Haque, M., Sartelli, M., McKimm, J., & Abu Bakar, M. (2018). Health care-associated infections: An overview. *Infection and Drug Resistance*, 11, 2321-2333.
- Horan, T. C., Andrus, M., & Dudeck, M. A. (2008). CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection. *American Journal of Infection Control*, 36(5), 309-332.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Evaluasi Pelaporan Surveilans HAIs Rumah Sakit*. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2024*. Kementerian Kesehatan RI
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2022). *Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)*.
- Magill, S. S., O'Leary, E., Janelle, S. J., Thompson, D. L., Dumyati, G., Nadle, J., & Fridkin, S. K. (2018). Changes in Prevalence of Health Care-Associated Infections in U.S. Hospitals. *New England Journal of Medicine*, 379(18), 1732-1744.
- Mitchell, B. G., Gardner, A., Stone, P. W., Hall, L., & Pogorzelska-Maziarz, M. (2018). Hospital staffing and health care-associated infections: A systematic review of the literature. *Journal of Quality and Patient Safety*, 44(10), 613-622.
- Reuter-Sandquist, M., & RN, O. R. (2022). *Nursing Assistant*. Chippewa Valley Technical College.

- Shrestha, A.K., Trotter, A., Shrestha, P.K. (2022). Epidemiology and Risk Factors of Healthcare-Associated Infections in Critically Ill Patients in a Tertiary Care Teaching Hospital in Nepal: A Prospective Cohort Study. *Infectious Diseases: Research and Treatment. SAGE Journal*, 15, 1-8
- Siegel, J. D., Rhinehart, E., Jackson, M., Chiarello, L., & the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. (2024). *Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings*. Centers for Disease Control and Prevention.
- Sirait, R. A., Sari, A. P., & Sitorus, R. S. (2025). Analisis sistem surveilans healthcare-associated infections (HAIs) di RSUD Drs. H. Amri Tambunan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kesmas dan Gizi (JKG)*, 7(2), 319-328. <https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKG/article/view/2690>
- Sulistyowati, E., Mahendra, G., Zubaidah, M., & Chamariyah. (2024). Evaluasi manajemen program pencegahan dan pengendalian infeksi di RS TK III Brawijaya: Tantangan dan strategi. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 9(2), 1-14
- World Health Organization. (2011). *Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide*.
- World Health Organization. (2019). *Water, Sanitation, And Hygiene In Health Care Facilities: Practical Steps To Achieve Universal Access To Quality Care*.
- World Health Organization. (2024). *Global Report on Infection Prevention and Control*

Glosarium

AMR	= Antimicrobial Resistance
CAUTI	= Catheter-Associated Urinary Tract Infection
CLABSI	= Central Line-Associated Bloodstream Infection
HAIs	= Healthcare-Associated Infections
ICU	= Intensive Care Unit
IDO	= Infeksi Daerah Operasi
IPCLN	= Infection Prevention and Control Link Nurse
IPCN	= Infection Prevention and Control Nurse
MRSA	= Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
PPI	= Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
VAP	= Ventilator-Associated Pneumonia
WASH	= Water, Sanitation, and Hygiene

CHAPTER 4

KOMUNIKASI EFEKTIF INTERPROFESI DALAM UPAYA KESELAMATAN PASIEN

Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H.

A. Pendahuluan/Prolog

Fasilitas pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh berbagai kelompok profesi yang melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan tugas dan kompetensinya masing-masing. Dengan semakin kompleksnya masalah kesehatan, kualitas layanan kesehatan membutuhkan sinergi dari berbagai disiplin ilmu kesehatan dalam bentuk kolaborasi interprofesi. Pelayanan multidisiplin dalam fasilitas kesehatan berpotensi menimbulkan konflik interprofesional yang pada akhirnya dapat berisiko terhadap keselamatan pasien (Rahayu & Surya Darmawan, 2022). Permasalahan utama dari insiden keselamatan pasien adalah komunikasi antar tenaga kesehatan yang kurang terintegrasi dengan baik. Atas dasar tersebut, maka komunikasi efektif dijadikan salah satu sasaran keselamatan pasien (Joint Commission International, 2011).

Komunikasi interprofesi merupakan sebagai interaksi yang terjadi antara dua atau lebih profesional kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker, dan ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya) yang bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan kesehatan pasien yang optimal (Noviyanti et al., 2023). Komunikasi yang efektif dalam pelayanan kesehatan adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh penerima sehingga dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Maka dalam komunikasi efektif perlu ditekankan kejelasan dan ketepatan pemberian informasi sesuai dengan konteks bahasa dan isi yang akan disampaikan (KARS, 2012). Komunikasi efektif interprofesi diyakini akan menjembatani berbagai profesi dalam memberikan pelayanan yang efektif pada pasien.

B. Teknik SBAR dalam komunikasi interprofesi

Teknik SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) adalah kerangka komunikasi terstruktur yang dirancang untuk menyampaikan informasi penting secara akurat, singkat, dan jelas. Teknik ini Awalnya dikembangkan oleh militer Angkatan Laut AS untuk kapal selam nuklir dan kemudian diadopsi oleh

industri penerbangan, teknik ini kini diterapkan dalam dunia kesehatan untuk mencegah kesalahan komunikasi (*miscommunication*). SBAR digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar dan merupakan hal yang memerlukan perhatian antar profesi kesehatan (WHO, 2011). Adapun komponen dari teknik komunikasi SBAR adalah sebagai berikut:

1. S – Situation (Situasi), merupakan kalimat pembuka untuk menyampaikan informasi. menggambarkan keadaan yang dialami pasien saat ini, keluhan utama pasien dan mengapa tenaga kesehatan tersebut menghubungi dokter/ tenaga kesehatan lain. Informasi yang disampaikan pada Situation berfokus pada masalah utama dalam 10-20 detik pertama.
2. B – Background (latar belakang), membahas apa yang melatarbelakangi kondisi pasien, tanda-tanda vital dan riwayat penyakit, obat-obatan yang sedang dikonsumsi atau tindakan yang telah dilakukan. Pada tahap ini sebaiknya memberikan data pendukung yang relevan dengan situasi saat ini, sesuai dengan masalah yang sedang terjadi
3. A – Assessment (Penilaian), merupakan hasil pengkajian pasien dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi pasien. Hal ini adalah kesimpulan sementara berdasarkan data yang ada
4. R – Recommendation (Rekomendasi), merupakan usulan tindakan yang dapat dilakukan terkait kondisi pasien saat ini

Contoh ilustrasi penggunaan teknik komunikasi SBAR antara perawat dengan dokter (Christina & Susilo, 2021)

Perawat:

- S: Selamat pagi dokter Adi, saya sari, perawat yang sedang masuk shift pagi di ruang IGD. Saya ingin melaporkan pasien baru atas nama Ny. Bunga usia 60 tahun. Pasien datang dengan penurunan kesadaran. Wajah kaku dan menurun pada satu sisi. Terlihat kesulitan menggerakkan tangan sebelah kanan dan bicara pelo
- B: Pasien memiliki riwayat hipertensi, TD 180/100 mmHg, nadi 85x/menit, RR 20x/menit. Biasanya di rumah minum obat rutin. Tidak ada riwayat alergi obat
- A: Sepertinya Ny. Bunga mengalami gejala yang mengarah ke stroke
- R: Apakah dokter bisa segera menemui pasien? Apakah saya harus melakukan CT Scan dan tes EKG?

Dokter :

"saya akan segera kesana. Sementara itu, lakukan CT Scan dan EKG ya"

Dalam ilustrasi percakapan perawat dengan dokter tersebut, ada hal tambahan yang perlu dilakukan dalam komunikasi efektif interprofesi yaitu melakukan TBAK

(Tulis, Baca kembali) atau *Checkback*. Setelah instruksi diberikan terutama instruksi yang diberikan melalui telepon, maka penerima informasi wajib menuliskan dan membacakan kembali instruksi tersebut sebagai klarifikasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien dari kesalahan pemberian obat atau intervensi lainnya.

Teknik SBAR yang digunakan oleh tenaga kesehatan memiliki berbagai manfaat dan keunggulan. Kolaborasi praktik interprofesional dengan komunikasi efektif SBAR meningkatkan kepuasan pasien, keselamatan serta status kesehatan pasien. Metode SBAR meningkatkan keakuratan informasi yang diberikan tim perawat atau interprofesional pada saat timbang terima pasien dan mengurangi kesalahan komunikasi saat berbicara melalui telepon (Müller et al., 2018).

Penggunaan metode SBAR saat operan dinas perawat dapat meningkatkan keselamatan pasien. Keterlibatan pasien dalam proses komunikasi saat operan dinas dapat meningkatkan tingkat keberhasilan rencana perawatan yang akan dilakukan pada shift berikutnya. Perawat dapat mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi informasi kepada pasien, sehingga perawat dapat menyusun rencana perawatan lebih komprehensif dan mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan (Achrekar et al., 2016). Manfaat metode SBAR antara lain dapat mentransfer Informasi penting secara akurat, karena adanya standarisasi komunikasi interprofesi, Efisiensi waktu terutama dalam situasi darurat, mengurangi risiko kesalahan informasi dan menunjukkan profesionalisme dan kompetensi pembicara terutama dalam komunikasi efektif interprofesi.

Teknik SBAR digunakan dalam setiap interaksi profesional tenaga kesehatan di tempat pelayanan kesehatan. Secara umum SBAR digunakan saat ada timbang terima atau perpindahan tanggung jawab dan kebutuhan akan tindakan segera. Teknik SBAR dapat digunakan antara lain saat:

1. Kondisi kritis atau perubahan status kesehatan pasien

Pada kondisi kritis atau mendesak maka tenaga kesehatan (biasanya perawat) melaporkan kondisi tersebut kepada dokter atau tim medis gawat darurat. Pelaporan ini dapat menggunakan teknik komunikasi SBAR. Penggunaan teknik ini memudahkan dokter mendapatkan gambaran klinis yang cepat dan dapat memberikan instruksi medis segera.

2. Serah terima pasien/ timbang terima (hand over)

Pelaksanaan serah terima pasien sebaiknya menggunakan teknik SBAR agar pemberian intervensi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Serah terima pasien dilakukan :

- a. Antar shift jaga, misalnya perawat shift pagi menyerahkan pasien kepada perawat shift siang
- b. Antar unit, misalnya perpindahan pasien dari ruang IGD ke ruang rawat inap

- c. Antar fasilitas kesehatan (rujukan), misalnya perpindahan pasien dari rumah sakit A ke rumah sakit B
3. Konsultasi dan kolaborasi interprofesi
Teknik SBAR digunakan saat dibutuhkan kolaborasi dengan profesi lain untuk memberikan perawatan pasien. Misalnya perawat atau bidan menghubungi dokter spesialis untuk melaporkan keadaan pasien, atau perawat menghubungi apoteker terkait interaksi obat.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan penunjang
Petugas laboratorium atau radiologi menggunakan SBAR saat melaporkan hasil pemeriksaan pasien yang memerlukan perhatian segera.
5. Pendokumentasian rekam medis
Struktur komunikasi SBAR digunakan pula dalam mendokumentasikan catatan perkembangan pasien terintegrasi. Hal ini bertujuan agar siapaun yang membaca rekam medis tersebut bisa langsung memahami masalah utama dan rencana tindakannya dengan cepat (Sukawan et al., 2021)

C. TeamSTEPPS untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antar profesi kesehatan

Dalam rangka peningkatan komunikasi efektif interprofesi maka perlu suatu program untuk meningkatkannya. Salah satu program pelatihan yang terbukti efektif dalam membangun dan meningkatkan keterampilan komunikasi petugas kesehatan adalah TeamSTEPPS.

TeamSTEPPS® merupakan singkatan dari *Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety*. Kegiatan ini adalah framework berbasis bukti (evidence-based framework) yang dikembangkan bersama oleh Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) dan Department of Defense (DoD) di Amerika Serikat untuk meningkatkan kerja tim, komunikasi, dan keselamatan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan.

TeamSTEPPS merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan mengurangi kesalahan dalam asuhan pasien. Program ini berfokus pada peningkatan keterampilan khusus yang berguna untuk mendukung prinsip dinamika tim interprofesi yang ada di fasilitas kesehatan.

TeamSTEPPS terdiri dari empat komponen keterampilan penting yang perlu dipelajari, yaitu kepemimpinan, pemantauan situasi, dukungan sejawat dan komunikasi. Program ini dirancang untuk membantu tim kesehatan bekerja lebih efektif antar profesional kesehatan (dokter, perawat, apoteker, bidan dan profesi kesehatan lainnya) dengan penguatan kemampuan dalam kompetensi berikut:

1. Komunikasi efektif antar profesi, meliputi komunikasi verbal dan nonverbal yang disampaikan akurat dan jelas
2. Peran kepemimpinan, merupakan kemampuan untuk memimpin tim dan memaksimalkan efektivitas anggota tim serta pengaturan struktur tim untuk meningkatkan koordinasi
3. Pemantauan situasi, merupakan kemampuan penilaian elemen situasional secara aktif untuk mendukung fungsi tim dan keselamatan pasien.
4. Dukungan timbal balik sejawat, dimana anggota tim kesehatan saling membantu dan mengelola beban kerja demi keselamatan pasien

Dengan keterampilan ini, TeamSTEPPS mendukung kolaborasi interprofesional yang optimal (American Hospital Association, 2011)

TeamSTEPPS penting dalam kolaborasi interprofesi karena terdapat beberapa profesi kesehatan yang bekerja bersama dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemberian asuhan untuk pasien secara terkoordinasi (Ahsan et al., 2021). Program ini merupakan model yang efektif untuk mengembangkan sinergi dalam pelayanan kesehatan karena :

1. Dapat meningkatkan kesadaran peran dari profesi lain dalam pemberian asuhan pasien, dimana setiap anggota tim belajar memahami peran dan tanggung jawab teman sejawatnya
2. Membantu dalam memperbaiki teknik komunikasi dan kerja tim sehingga mengurangi miskomunikasi yang dapat mengakibatkan medical error
3. Mendorong kepemimpinan tim dan keterlibatan semua profesi dalam memastikan rencana perawatan yang tepat sasaran.

1. Komunikasi efektif

Komunikasi efektif yang dilatih dalam program TeamSTEPPS adalah sebagai berikut:

a. SBAR

Merupakan teknik komunikasi untuk memberikan informasi terkait pasien atau hal lain yang mewajibkan tim kesehatan segera memberikan perhatian dan intervensi

b. *Call-out*

Call-out digunakan untuk mengkomunikasikan informasi penting. Adanya *call-out* dapat :

- 1) Menginformasikan informasi pada semua anggota tim secara bersamaan
- 2) Membantu anggota tim mengantisipasi langkah selanjutnya
- 3) Berkontribusi pada pemantauan situasi yang efektif dan memegang model mental bersama

Contoh : "saat ini detak jantung pasien 78 kali/menit dan pasien kembali ke ritme sinus"

c. *Closed-Loop Communication*

Merupakan teknik komunikasi antar profesi kesehatan yang digunakan sebagai cara untuk meminimalkan kesalahan. Adapun teknik Closed-loop communication adalah:

- 1) Request (permintaan), merupakan instruksi kepada tim kesehatan untuk melakukan suatu intervensi
- 2) Repeat-back (mengulang kembali), digunakan untuk memverifikasi informasi yang diterima. Informasi dapat pula dituliskan jika pesan diterima melalui telepon
- 3) Confirmation (konfirmasi), dilakukan memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pengirim pesan dapat dipahami sesuai apa yang dimaksud. Selanjutnya percakapan ditutup dengan menandakan penyelesaian tugas. Penerima pesan menyampaikan kembali jika permintaan telah dikerjakan

Contoh:

Dr. Adi: Ners Sita, tolong berikan pasien Ny. Bunga Epinefrin 1 mg via intravena

Ners Sita: baik, Dokter meminta pasien Ny Bunga untuk diberikan 1 mg epinefrin via intravena

Dr. Adi: Ya betul

Ners Sita: (memberikan obat sesuai instruksi), selanjutnya menyampaikan kembali kepada dr. Adi

Ners Sita : Pasien Ny Bunga sudah diberikan epinefrin 1mg intravena.

d. *Teach-back* (mengulang kembali)

Merupakan strategi komunikasi yang digunakan tim kesehatan untuk mengkonfirmasi bahwa pengirim telah menjelaskan informasi dengan jelas kepada pasien dan keluarga, dan bahwa pasien dan keluarga memiliki pemahaman yang sama tentang informasi yang diterima.

Teach-back (mengulang kembali) memberikan kesempatan bagi pasien dan keluarga untuk :

- 1) Menjelaskan kembali informasi yang diterima dengan kata-kata sendiri
- 2) Melakukan demonstrasi keterampilan yang diajarkan oleh tim kesehatan

e. *Handoff* / timbang terima/ operan

Merupakan teknik standar untuk mentransfer informasi dan tanggung jawab selama transisi perawatan pasien. Dalam kegiatan ini tim yang diberikan serah terima diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi (Priantoro et al., 2022). Komunikasi ini dapat digunakan saat operan shift, perpindahan antar unit dan perubahan tim.

Kegiatan timbang terima sebaiknya:

- 1) Menjelaskan informasi dengan jelas dan lengkap
- 2) Menggunakan format standar (bisa menggunakan SBAR)
- 3) Memberikan kesempatan untuk mereview informasi dan menanyakan hal-hal yang dirasa belum jelas
- 4) Konfirmasi perpindahan tanggungjawab pasien antar tim

Jika memungkinkan, saat kegiatan timbang terima pasien dan keluarga dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi atau bertanya terkait informasi yang diberikan saat timbang terima/operan (WHO, 2011)

2. Kepemimpinan

Selain komunikasi, kompetensi TeamSTEPPS adalah kepemimpinan yang efektif. Tanggung jawab pemimpin tim yang efektif antara lain:

- a. Memastikan kebutuhan dan keinginan pasien dipahami dan diprioritaskan
- b. Menentukan, menetapkan, membagi, memantau dan memodifikasi rencana kerja tim
- c. Menetapkan tanggung jawab anggota tim
- d. Mengelola dan mengalokasikan sumberdaya secara efektif
- e. Memfasilitasi berbagai informasi
- f. Mendorong anggota tim untuk saling membantu
- g. Memfasilitasi resolusi konflik dalam tim

Tim yang efektif dapat dibentuk dengan cara :

- a. Brief (pemantapan), sesi diskusi singkat sebelum memulai suatu pekerjaan yang didalamnya berisi menetapkan tanggung jawab dan peran tim, menetapkan tujuan dan memantapkan kolaborasi antar profesi
- b. Berkumpul kembali untuk mendiskusikan keadaan pasien, menetapkan pemecahan masalah atau memperkuat rencana yang sudah ada dan menilai kebutuhan untuk menyesuaikan rencana
- c. Pemantapan kembali, merupakan sesi informal, pertukaran informasi terkini pasien dan umpan balik, untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas tim dari kasus yang sudah ada serta peningkatan perilaku positif antar tim

3. Dukungan timbal balik

Dukungan timbal balik dalam TeamSTEPPS merupakan kompetensi ketiga yang akan meningkatkan efektivitas kolaborasi antar profesi. Hal ini akan meningkatkan kerjasama tim kesehatan. Dukungan antar profesi akan menumbuhkan rasa aman secara psikologis dan saling melindungi dari beban kerja berlebih, tim yang efektif akan berfokus pada keselamatan pasien, serta

menciptakan rasa aman untuk meminta bantuan satu sama lain (Yuanasika & Rosa, 2023).

Informasi yang diberikan kepada anggota tim melalui komunikasi verbal dan non verbal, sengaja maupun tidak sengaja, akan meningkatkan kinerja tim. Bentuk dukungan timbal balik antara lain:

- a. Apresiatif, yaitu mengekspresikan rasa terima kasih dan menghargai tindakan yang dilakukan anggota tim dengan baik
- b. Tepat waktu, dukungan diberikan segera setelah hal baik terjadi dalam tim
- c. Saling menghormati, merupakan sikap saling menghargai sebagai tim dalam proses pelayanan kesehatan
- d. Spesifik, berkaitan dengan tugas atau perilaku spesifik yang memerlukan koreksi atau perbaikan
- e. Peningkatan kearah yang lebih baik, yaitu dukungan berupa arahan untuk perbaikan di masa mendatang
- f. Pertimbangan, dimana anggota tim saling mempertimbangkan perasaan dan menyampaikan hal negatif dengan adil dan sopan
- g. Berfokus pada dampak, yaitu diskusi terkait dampak perilaku anggota tim dan dampaknya pada keselamatan pasien

4. Pemantauan situasi

Pemantauan situasi dalam TeamStepps adalah proses monitoring lingkungan serta kinerja tim untuk mendapatkan gambaran yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan. Metode yang dilakukan adalah pemantauan silang (Cross monitoring), yaitu "Saling menjaga satu sama lain" untuk memastikan dukungan yang efektif bagi anggota tim dan advokasi bagi pasien ketika risiko muncul atau bantuan dibutuhkan.

Pemantauan silang meliputi:

- a. Memantau perilaku satu sama lain, agar sesuai dengan perilaku yang diharapkan
- b. Budaya kolaborasi antar profesi terkait asuhan pasien dan dinamika tim
- c. Berani berbicara ketika ditemukan potensi risiko atau kelalaian teridentifikasi
- d. Berterima kasih kepada anggota tim karena telah menyampaikan hasil observasi atau pendapat
- e. Melibatkan pasien kapanpun jika memungkinkan

D. Simpulan

Komunikasi efektif interprofesi tidak lepas dari manajemen kolaborasi antar profesi kesehatan. Komunikasi antar profesi dapat menggunakan metode SBAR

untuk mengurangi adanya miskomunikasi dan menjaga keselamatan pasien. Dalam rangka peningkatan merupakan salah satu solusi yang dapat diaplikasikan. Program ini meningkatkan kemampuan komunikasi efektif antar profesi, meningkatkan kemampuan menjadi pemimpin (team leader), memberikan dukungan timbal balik antar profesi dan pemantauan situasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya komunikasi efektif interprofesi dan kerjasama tim yang baik, maka akan mencegah terjadinya insiden dan mewujudkan keselamatan pasien.

Referensi

- Yuanasika, D., & Rosa, R. D. (2023). Team Effectiveness Intervention Using TeamSTEPPS in Healthcare: A Literature Review. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(3).
- WHO. (2011). *Patient safety curriculum guide: Multi-professional Edition*. World Health Organization.
- Sukawan, A., Meilany, L., & Rahma, A. N. (2021). Literature Review: Peran Lembar Catatan Perkembangan Terintegrasi (CPPT) dalam Meningkatkan Komunikasi Efektif pada Pelaksanaan Kolaborasi Interprofesional di Rumah Sakit. *Health Information Management Journal ISSN*, 9(1), 2655–9129.
- Rahayu, A., & Surya Darmawan, E. (2022). Hambatan komunikasi interprofesional pada fasilitas layanan kesehatan rumah sakit. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10595>
- Priantoro, C. T., Purwanza, S. W., & Wachidah, E. Z. (2022). Metode Komunikasi dengan Pendekatan SBAR Terhadap Keselamatan Pasien: Studi Literatur. *Nursing Information Journal*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.54832/nij.v1i2.191>
- Noviyanti, A., Lita Sari, N., & Lestari, T. (2023). Komunikasi Efektif Dalam Pelaksanaan Interprofessional Kolaborasi Di Rumah Sakit Literature Review. *Indonesian Journal of Health Information Management (IJHIM)*, 3(1), 1.
- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: a systematic review. *BMJ Open*, 8(8), e022202. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022202>
- KARS. (2012). *Instrumen Akreditasi Rumah Sakit*. PERSI.
- Joint Commission International. (2011). *Standar Akreditasi Rumah Sakit* (4th ed.). Joint Commission Resources.
- Christina, L. V., & Susilo, A. P. (2021). Penggunaan Metode SBAR untuk Komunikasi Efektif antara Tenaga Kesehatan dalam Konteks Klinis. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 3(1), 57–63. <https://doi.org/10.24123/kesdok.v3i1.4584>
- American Hospital Association. (2011). *TeamSTEPPS® POCKET GUIDE Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety*. AHA Team Training.

- Ahsan, A., Setiowati, L., Noviyanti, L. W., Rahmawati, I. N., Ningrum, H., & Putra, K. R. (2021). Nurses' team communication in hospitals: A quasi-experimental study using a modified TeamSTEPPS. *Journal of Public Health Research*, 10, 2157.
- Achrekar, M. S., Murthy, V., Kanan, S., Shetty, R., Nair, M., & Khattry, N. (2016). Introduction of Situation, Background, Assessment, Recommendation into Nursing Practice: A Prospective Study. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 3(1), 45–50. <https://doi.org/10.4103/2347-5625.178171>

Glosarium

SBAR = Situation, Background, Assessment, Recommendation

TeamSTEPPS = Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety

CHAPTER 5

ETIKA, LEGALITAS, DAN INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN MODERN

Ns. Asih Minarningtyas, M.Kep.

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan modern berkembang sangat pesat seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi medis, digitalisasi sistem pelayanan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak kesehatan. Perubahan ini membawa implikasi besar tidak hanya pada aspek klinis, tetapi juga pada dimensi etika dan hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Etika, legalitas, dan informed consent menjadi tiga pilar utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menjamin pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan serta martabat manusia.

Etika pelayanan kesehatan berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan tenaga kesehatan dalam bertindak secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etika seperti otonomi, beneficence, nonmaleficence, dan justice menjadi pedoman penting dalam setiap pengambilan keputusan klinis (Beauchamp & Childress, 2019). Dalam praktiknya, tenaga kesehatan sering dihadapkan pada dilema etis, terutama ketika kepentingan pasien, keluarga, institusi, dan regulasi tidak selalu sejalan. Oleh karena itu, pemahaman etika yang kuat diperlukan agar keputusan yang diambil tetap mengedepankan nilai kemanusiaan.

Selain etika, aspek legalitas memegang peranan krusial dalam pelayanan kesehatan modern. Legalitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar profesi, serta kebijakan institusi yang mengatur praktik pelayanan kesehatan. Kerangka hukum bertujuan melindungi hak pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya (Pozgar, 2020). Di Indonesia, aspek legal pelayanan kesehatan diatur melalui berbagai regulasi, seperti undang-undang kesehatan, undang-undang praktik kedokteran dan keperawatan, serta peraturan terkait keselamatan pasien. Ketidakpatuhan terhadap aspek legal tidak hanya berpotensi merugikan pasien, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan etik bagi tenaga kesehatan.

Informed consent merupakan perwujudan nyata dari prinsip etika otonomi dan sekaligus menjadi kewajiban legal dalam pelayanan kesehatan. Informed consent tidak sekadar berupa penandatanganan formulir persetujuan tindakan medis, melainkan sebuah proses komunikasi yang komprehensif antara tenaga kesehatan dan pasien. Proses ini mencakup pemberian informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami mengenai diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta konsekuensi apabila tindakan tidak dilakukan (Hall, Prochazka, 2012). Dengan demikian, pasien memiliki kebebasan dan kapasitas untuk mengambil keputusan secara sadar sesuai dengan nilai dan preferensinya.

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, penerapan informed consent menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas teknologi medis, keterbatasan waktu pelayanan, perbedaan tingkat pendidikan pasien, serta faktor budaya dan bahasa sering kali memengaruhi kualitas proses informed consent. Selain itu, berkembangnya telemedicine dan penggunaan sistem informasi kesehatan digital memunculkan pertanyaan baru terkait validitas persetujuan, keamanan data, dan perlindungan privasi pasien (Floridi et al., 2018). Kondisi ini menuntut adaptasi pendekatan etika dan hukum agar tetap relevan dengan dinamika pelayanan kesehatan masa kini.

B. Tren dan Isu Kontemporer

Beberapa tren dan isu penting yang menonjol dalam bidang etika, legalitas, dan informed consent pelayanan kesehatan modern antara lain meningkatnya tuntutan patient-centered care, penguatan hak pasien, serta akuntabilitas tenaga kesehatan dan institusi pelayanan. Pasien tidak lagi diposisikan sebagai penerima layanan pasif, melainkan sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan klinis. Hal ini menuntut tenaga kesehatan untuk memiliki kompetensi komunikasi etik yang lebih baik serta sensitivitas terhadap nilai dan latar belakang pasien.

Isu lain yang berkembang adalah meningkatnya kasus sengketa medis dan tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap mutu pelayanan dan penghormatan terhadap hak pasien. Informed consent yang tidak adekuat sering menjadi salah satu faktor utama dalam konflik hukum pelayanan kesehatan (Pozgar, 2020). Oleh karena itu, dokumentasi informed consent yang baik dan proses komunikasi yang efektif menjadi kebutuhan mendesak dalam praktik klinis.

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan memunculkan dilema etika baru, seperti penggunaan data besar (big data), algoritma klinis, serta pengambilan keputusan berbasis sistem digital. Isu privasi, kerahasiaan data pasien, dan transparansi informasi menjadi

perhatian utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan modern (Mittelstadt et al., 2016).

Secara keseluruhan, etika, legalitas, dan informed consent merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan modern yang bermutu, aman, dan berkeadilan. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga aspek ini menjadi kebutuhan esensial bagi tenaga kesehatan agar mampu menghadapi tantangan dan dinamika pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.

C. Etika dalam Pelayanan Kesehatan Modern

Pelayanan kesehatan modern ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi medis, digitalisasi sistem informasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pasien. Kondisi ini menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki integritas moral dan pemahaman etika yang kuat. Etika dalam pelayanan kesehatan berperan sebagai landasan normatif dalam pengambilan keputusan klinis dan profesional agar pelayanan yang diberikan tetap menghormati martabat manusia serta menjamin keselamatan pasien (Beauchamp & Childress, 2019).

Etik adalah sistem nilai pribadi yang digunakan untuk memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat, memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Etik merupakan prinsip yang menyangkut benar atau salah dan tindakan apa yang akan dilakukan. Penerapan prinsip etik penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien yang dapat menyebabkan injury atau bahaya fisik, bahaya emosional seperti perasaan ketidakpuasan, kecacatan bahkan kematian dan akhirnya tujuan pelayanan yang berupa *patient safety* tidak akan pernah terwujud. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang 24 jam berada di samping pasien dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan harus memberikan asuhan keperawatan dengan baik dan senantiasa menjunjung kode etik keperawatan serta menerapkan prinsip-prinsip etik keperawatan selama memberikan pelayanan.

1. Pengertian Etika Pelayanan Kesehatan

Etika pelayanan kesehatan adalah seperangkat prinsip moral, nilai, dan norma yang menjadi pedoman perilaku tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesionalnya. Etika ini mengatur hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, keluarga, sejawat, institusi pelayanan kesehatan, dan masyarakat luas (Sugarman & Sulmasy, 2010).

Dalam pelayanan kesehatan modern, etika tidak hanya terbatas pada interaksi langsung dengan pasien, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi

medis, sistem informasi kesehatan, riset kesehatan, serta kebijakan pelayanan yang adil dan berkelanjutan (WHO, 2020).

Lebih luas lagi, etika pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan hubungan langsung antara tenaga kesehatan dan pasien, tetapi juga terkait dengan integritas institusional, kesetaraan dalam akses layanan, serta tanggung jawab moral dalam menghadapi dilema etis seperti distribusi sumber daya yang terbatas atau konflik kepentingan dalam praktik pelayanan. Etika menjadi patokan yang membantu mencegah diskriminasi, malpraktik, dan pelanggaran hak pasien, sehingga kualitas pelayanan meningkat dan diterima secara adil oleh semua lapisan masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Etika dalam Pelayanan Kesehatan Modern

a. Autonomy (*Otonomi*)

Prinsip otonomi menekankan penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan pilihan terkait pelayanan kesehatannya setelah memperoleh informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami. Penerapan prinsip ini tercermin dalam pelaksanaan informed consent dan pengambilan keputusan bersama (shared decision making) (Beauchamp & Childress, 2019).

b. Beneficence (*Berbuat Baik*)

Beneficence mengharuskan tenaga kesehatan bertindak untuk memberikan manfaat maksimal bagi pasien. Setiap tindakan pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas hidup pasien (Emanuel et al., 2022).

c. Non-Maleficence (*Tidak Merugikan*)

Prinsip ini mengandung kewajiban moral untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pasien. Dalam pelayanan modern, prinsip non-maleficence sangat terkait dengan upaya keselamatan pasien (patient safety) dan pencegahan kesalahan medis (ANA, 2015).

d. Justice (*Keadilan*)

Prinsip keadilan menuntut distribusi pelayanan kesehatan yang adil dan setara tanpa diskriminasi. Dalam sistem kesehatan modern, keadilan mencakup akses pelayanan, alokasi sumber daya, dan perlakuan yang sama bagi seluruh pasien (WHO, 2020).

e. Tidak Merugikan (*Nonmaleficence*)

Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya / cedera fisik dan psikologis pada klien (Varkey, B. 2021)

f. Kejujuran (*Veracity*)

Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan.

g. Menepati janji (*Fidelity*)

Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.

h. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang klien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari.

i. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali.

3. Etika dan Hak Pasien

Pelayanan kesehatan modern menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan (*patient-centered care*). Oleh karena itu, tenaga kesehatan wajib menghormati hak-hak pasien, antara lain:

- a. Hak memperoleh informasi yang benar dan lengkap
- b. Hak atas privasi dan kerahasiaan data medis
- c. Hak mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu
- d. Hak menyetujui atau menolak tindakan medis

Penggunaan rekam medis elektronik dan *telemedicine* meningkatkan efisiensi pelayanan, namun juga menimbulkan tantangan etis terkait perlindungan data dan kerahasiaan pasien (Thome et al., 2020).

4. Tantangan Etika dalam Pelayanan Kesehatan Modern

Kemajuan teknologi dan kompleksitas sistem kesehatan menimbulkan berbagai dilema etis, antara lain:

- a. Penggunaan teknologi canggih dan kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan klinis
- b. Dilema etis pada perawatan pasien terminal dan akhir hayat
- c. Konflik kepentingan dalam pembiayaan dan asuransi kesehatan
- d. Ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan

Tenaga kesehatan dituntut memiliki kemampuan analisis etis dan kepatuhan terhadap kode etik profesi dalam menghadapi tantangan tersebut (Sugarman & Sulmasy, 2010).

5. Peran Tenaga Kesehatan dalam Penerapan Etika

Tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam menegakkan etika pelayanan kesehatan melalui:

- a. Penerapan kode etik profesi secara konsisten
- b. Penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan martabat pasien
- c. Perlindungan keselamatan dan hak pasien
- d. Penciptaan budaya etis dan keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan

Perawat, sebagai tenaga kesehatan dengan kontak paling intensif dengan pasien, memiliki peran penting dalam advokasi pasien dan penerapan etika dalam praktik sehari-hari (ANA, 2015).

D. Aspek Legalitas dalam Pelayanan Kesehatan Modern

Pelayanan kesehatan modern tidak hanya menuntut kompetensi profesional dan etika, tetapi juga kepatuhan terhadap aspek legalitas. Aspek legal menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, pasien, serta institusi pelayanan kesehatan. Kepatuhan terhadap hukum bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien, menjamin mutu pelayanan, serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesionalnya (Guido, 2020).

Perkembangan teknologi medis, sistem informasi kesehatan, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan bermutu menjadikan aspek legal semakin penting dalam pelayanan kesehatan modern.

1. Pengertian Aspek Legalitas Pelayanan Kesehatan

Aspek legalitas pelayanan kesehatan adalah seluruh ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, standar profesi, maupun kebijakan institusi. Aspek ini

mencakup tanggung jawab hukum tenaga kesehatan, perlindungan hak pasien, serta mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan (Pozgar, 2020).

Dalam praktik modern, aspek legal tidak dapat dipisahkan dari etika dan profesionalisme, karena pelanggaran hukum sering kali berawal dari pengabaian nilai etis dalam pelayanan kesehatan.

Aspek legal tenaga kesehatan merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Legalitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh profesional kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, malpraktik, atau tindakan yang merugikan pasien dan masyarakat.

Pertama, *tenaga kesehatan wajib melaksanakan pelayanan sesuai standar profesi dan hukum kesehatan yang berlaku*. Setiap tindakan medis harus berlandaskan persetujuan pasien melalui prosedur *informed consent* sehingga menghormati hak pasien atas informasi dan keputusan sendiri mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Jika tindakan medis dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari pasien, maka tenaga kesehatan dapat dikenai tanggung jawab hukum berdasarkan hukum perdata maupun pidana (Zainuddin & Risdawati, I. (2025)

Kedua, *tanggung jawab hukum tenaga kesehatan mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana*. Misalnya, dalam kasus malpraktik, tenaga kesehatan dapat diproses hukum jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian medis yang menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. Hal ini juga diatur dalam ketentuan kesehatan Indonesia seperti Law Number 29 of 2004 tentang Medical Practice dan aturan lain dalam hukum kesehatan nasional. Zainuddin & Risdawati, I. (2025)

Ketiga, legalitas juga mencakup *perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan* yang bertindak berdasarkan ketentuan hukum dan standar pelayanan. Misalnya, tenaga kesehatan yang menangani pasien darurat tanpa persetujuan eksplisit sebelumnya tetap harus dilindungi secara hukum jika tindakannya ditujukan untuk menyelamatkan nyawa pasien dalam situasi yang mendesak. Perlindungan ini menghindarkan mereka dari tuntutan hukum yang tidak sesuai dengan kondisi profesional mereka.

Selain itu, aspek legal juga mencakup pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab profesional, seperti standar kompetensi, sertifikasi profesi, serta izin praktik yang diwajibkan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa tenaga kesehatan mampu memberikan layanan yang aman. Ketidakpatuhan terhadap

standar ini dapat berakibat pada sanksi hukum administrasi atau pencabutan izin praktik. (Mahendra, M., Afrita, I., & Triana, Y. (2025)

Penerapan aspek legal dalam pelayanan kesehatan juga mencakup perlindungan dan kewajiban lainnya seperti keselamatan kerja, hak atas informasi pasien, serta penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan tenaga kesehatan. Semua ini dilakukan untuk menciptakan layanan kesehatan yang adil, profesional, dan bermartabat sesuai dengan tujuan hukum kesehatan nasional.

2. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan modern didasarkan pada berbagai ketentuan hukum yang mengatur praktik tenaga kesehatan, antara lain:

- a. Regulasi tentang praktik dan perizinan tenaga kesehatan
- b. Standar profesi dan standar pelayanan
- c. Ketentuan mengenai keselamatan pasien
- d. Perlindungan hak dan kewajiban pasien

Secara umum, hukum kesehatan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pasien, tenaga kesehatan, dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan (Pozgar, 2020).

3. Aspek Legal Tenaga Kesehatan

- a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Profesional

Tenaga kesehatan wajib menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan standar profesi. Pelayanan yang diberikan di luar kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana (Guido, 2020).

- b. Informed Consent

Informed consent merupakan persetujuan pasien atas tindakan medis atau keperawatan setelah memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai tujuan, prosedur, manfaat, risiko, dan alternatif tindakan. Secara hukum, informed consent menjadi bukti bahwa tindakan pelayanan dilakukan dengan persetujuan pasien dan menghormati hak otonomi pasien (Beauchamp & Childress, 2019).

- c. Dokumentasi dan Rekam Medis

Rekam medis memiliki nilai hukum yang sangat penting sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dokumentasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu mencerminkan mutu pelayanan dan menjadi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien (ANA, 2015).

4. Aspek Legal Hak dan Perlindungan Pasien

Pelayanan kesehatan modern menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak, antara lain:

- a. Hak atas informasi dan persetujuan tindakan
- b. Hak atas privasi dan kerahasiaan data medis
- c. Hak memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu
- d. Hak mengajukan pengaduan dan mendapatkan penyelesaian sengketa

Perlindungan data kesehatan menjadi isu legal penting seiring dengan penggunaan rekam medis elektronik dan telemedicine (WHO, 2020).

5. Tantangan Legalitas dalam Pelayanan Kesehatan Modern

Kemajuan teknologi dan kompleksitas sistem kesehatan menimbulkan tantangan hukum, seperti:

- a. Keamanan dan kerahasiaan data kesehatan digital
- b. Tanggung jawab hukum dalam pelayanan berbasis teknologi dan AI
- c. Sengketa medis dan tuntutan malpraktik
- d. Ketimpangan akses dan keadilan hukum dalam pelayanan kesehatan

Tenaga kesehatan dituntut memahami aspek legal agar mampu meminimalkan risiko hukum dan memberikan pelayanan yang aman serta bermutu (Pozgar, 2020).

6. Peran Tenaga Kesehatan dalam Menegakkan Aspek Legal

Tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam penerapan aspek legalitas melalui:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Penerapan standar profesi dan standar operasional prosedur
- c. Pendokumentasian pelayanan yang benar
- d. Perlindungan hak pasien dan keselamatan pasien

Perawat, sebagai tenaga kesehatan dengan kontak langsung dan berkelanjutan dengan pasien, berperan penting dalam memastikan pelayanan sesuai aspek hukum dan etika (ANA, 2015).

E. Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan Modern

Informed consent merupakan bagian fundamental dalam pelayanan kesehatan modern yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, otonomi pasien, serta prinsip etika dan legalitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan informed consent tidak hanya menjadi kewajiban etis tenaga kesehatan, tetapi juga

merupakan kewajiban hukum yang bertujuan melindungi pasien dan tenaga kesehatan dari risiko sengketa hukum (Beauchamp & Childress, 2019).

Perkembangan teknologi medis, peningkatan kompleksitas tindakan kesehatan, serta perubahan pola hubungan tenaga kesehatan dan pasien menjadikan informed consent sebagai proses komunikasi yang semakin penting dalam pelayanan kesehatan modern.

Di Indonesia, kewajiban informed consent ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan harus didasarkan pada persetujuan pasien setelah memperoleh informasi yang memadai (Republik Indonesia, 2023).

1. Pengertian Informed Consent

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah menerima informasi yang lengkap, jelas, dan dapat dipahami mengenai tindakan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan. Informasi tersebut mencakup diagnosis, tujuan tindakan, prosedur, manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta konsekuensi apabila tindakan tidak dilakukan (Guido, 2020).

Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 menegaskan bahwa persetujuan tindakan kedokteran merupakan persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga terdekat setelah penjelasan lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan (Kementerian Kesehatan RI, 2008).

Dalam konteks modern, informed consent dipahami sebagai proses komunikasi dua arah, bukan sekadar penandatanganan formulir persetujuan.

2. Dasar Etika dan Legal Informed Consent

a. Dasar Etika

Informed consent berlandaskan pada prinsip:

- 1) Autonomy, yaitu hak pasien untuk menentukan pilihan terhadap pelayanan kesehatannya
- 2) Beneficence dan Non-maleficence, yaitu kewajiban tenaga kesehatan memberikan manfaat dan menghindari bahaya
- 3) Justice, yaitu perlakuan yang adil dan setara terhadap pasien

Penerapan informed consent mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan nilai kemanusiaan pasien (Beauchamp & Childress, 2019).

b. Dasar Legal

Secara hukum, informed consent menjadi bukti bahwa tindakan pelayanan kesehatan dilakukan dengan persetujuan pasien yang sah.

Ketidakterpenuhan informed consent dapat menimbulkan implikasi hukum berupa tuntutan malpraktik atau pelanggaran hak pasien (Pozgar, 2020). Pelaksanaan informed consent di Indonesia memiliki dasar hukum kuat, antara lain:

1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menjamin hak pasien memperoleh informasi dan memberikan persetujuan atas tindakan pelayanan kesehatan (Republik Indonesia, 2023).

2) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Mengatur kewajiban dokter dan dokter gigi memberikan penjelasan lengkap sebelum tindakan medis (Republik Indonesia, 2004).

3) Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Mengatur bentuk, isi, dan tata cara informed consent (Kementerian Kesehatan RI, 2008).

4) Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Menegaskan bahwa persetujuan tindakan harus terdokumentasi dalam rekam medis sebagai alat bukti hukum (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Dengan dasar hukum ini, informed consent menjadi perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan.

3. Unsur-Unsur Informed Consent

Agar informed consent dinyatakan sah secara etis dan legal, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Kompetensi

Pasien memiliki kemampuan untuk memahami informasi dan mengambil keputusan.

b. Informasi yang Adekuat

Tenaga kesehatan memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami.

c. Pemahaman

Pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan.

d. Kesukarelaan

Persetujuan diberikan tanpa paksaan, tekanan, atau manipulasi.

e. Persetujuan

Persetujuan dinyatakan secara lisan atau tertulis sesuai jenis tindakan (Guido, 2020).

4. Bentuk Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan

Informed consent dapat diberikan dalam beberapa bentuk:

- a. Tertulis, untuk tindakan invasif, berisiko tinggi, atau prosedur khusus
- b. Lisan, untuk tindakan rutin dan berisiko rendah
- c. Implied consent, persetujuan tersirat berdasarkan situasi tertentu, seperti kondisi gawat darurat

Dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa, tindakan dapat dilakukan tanpa informed consent untuk menyelamatkan pasien, sesuai prinsip keselamatan pasien (Pozgar, 2020).

5. Informed Consent di Era Pelayanan Kesehatan Modern

Pelayanan kesehatan modern menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan informed consent, antara lain:

- a. Penggunaan teknologi medis canggih dan kecerdasan buatan
- b. Pelayanan jarak jauh (telemedicine)
- c. Rekam medis elektronik dan perlindungan data pasien
- d. Keterlibatan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan

Tenaga kesehatan dituntut menyesuaikan proses informed consent agar tetap menjamin pemahaman dan hak pasien di tengah kemajuan teknologi (WHO, 2020).

Permenkes No. 24 Tahun 2022 menegaskan bahwa rekam medis elektronik harus menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan data, termasuk dokumentasi persetujuan tindakan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

6. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Informed Consent

Tenaga kesehatan berperan penting dalam memastikan informed consent dilaksanakan secara benar melalui:

- a. Pemberian informasi yang jelas dan sesuai tingkat pemahaman pasien
- b. Pendokumentasian informed consent secara lengkap dan akurat
- c. Penghormatan terhadap keputusan pasien
- d. Kolaborasi antarprofesi dalam proses pengambilan keputusan

Perawat memiliki peran strategis sebagai advokat pasien dalam memastikan hak pasien terpenuhi dalam proses informed consent (ANA, 2015).

F. Kesimpulan

Etika dalam pelayanan kesehatan modern merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Penerapan prinsip etika membantu tenaga kesehatan menghadapi dilema klinis, menjaga kepercayaan pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aspek legalitas dalam pelayanan kesehatan modern merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pelayanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Kepatuhan terhadap hukum memberikan perlindungan bagi pasien dan tenaga kesehatan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Informed consent dalam pelayanan kesehatan modern merupakan proses etis dan legal yang bertujuan melindungi hak pasien serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Pelaksanaan informed consent yang baik mencerminkan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan serta martabat pasien.

Referensi

- American Nurses Association. (2015). *Code of ethics for nurses with interpretive statements*. American Nurses Association.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Emanuel, E. J., Upshur, R., Thome, B., Parker, M., Glickman, A., Zhang, C., Boyle, C., Smith, M., & Phillips, J. P. (2022). Fair allocation of scarce medical resources in the time of Covid-19 and beyond. *New England Journal of Medicine*, 382(21), 2049–2055. <https://doi.org/10.1056/NEJMs2005114>
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., ... Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Guido, G. W. (2020). *Legal and ethical issues in nursing* (7th ed.). Pearson.
- Hall, Prochazka, & F. (2012). Informed consent for clinical treatment. *Canadian Medical Association Journal*, 184(5), 533–540. <https://doi.org/10.1503/cmaj.112120>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis*. Kementerian Kesehatan RI.
- Mahendra, M., Afrita, I., & Triana, Y. (2025). Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis terhadap Standar Kompetensi atas Tindakan Medis. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(1), 246-270.
- Methods in Medical Ethics (2nd ed.). Georgetown University Press. Retrieved from <https://www.perlego.com/book/949434/methods-in-medical-ethics-second-edition-pdf> (Original work published 2010) ersity Press.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1–21. <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>

- Pozgar, G. D. (2020). *Legal and ethical issues for health professionals* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran*. Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan*. Sekretariat Negara RI.
- Sugarman, J., & Sulmasy, D. P. (2010). *Methods in medical ethics* (2nd ed.). Georgetown Univ . (2010).
- Thome, B., Ph, D., Parker, M., Ph, D., Glickman, A., Zhang, C., Boyle, C., Smith, M., Ph, D., & Phillips, J. P. (2020). *Sounding Board Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19*. 2049–2055.
- Varkey, B. (2021). *Principles of clinical ethics and their application to practice*. PMC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7923912/>
- World Medical Association. (2018). *Declaration of Geneva*. World Medical Association.
- World Health Organization. (2020). *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. World Health Organization.

CHAPTER 6

PENGUATAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN PADA PERAWAT, BIDAN, APOTEKER DAN AHLI GIZI

Dr. Yahmin Setiawan, MARS.

A. Pendahuluan

Keselamatan pasien merupakan elemen penting dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang ditandai dengan perspektif semua komponen penyedia layanan terkait pentingnya keselamatan, transparansi dan efektivitas komunikasi, serta pelaksanaan langkah-langkah preventif yang efektif untuk meningkatkan keselamatan pasien (Hessel A et al., 2019). Menurut *World Health Organization* (WHO), keselamatan pasien adalah upaya pencegahan kesalahan medis dan efek samping tindakan/pelayanan pada pasien selama perawatan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang tidak aman dapat menyebabkan cedera, kecacatan, bahkan kematian (Azyabi A et al., 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menjamin standar keselamatan pasien dengan menerapkan sistem pelayanan yang sesuai dengan kriteria keselamatan pasien seperti hak pasien, pendidikan untuk keluarga pasien dan pasien, keselamatan pasien dalam pelayanan, mengevaluasi dan peningkatan keselamatan pasien, kepemimpinan dalam keselamatan pasien, pendidikan staf dan komunikasi demi mencapai keselamatan pasien, serta langkah pertama untuk mewujudkan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan adalah membangun budaya keselamatan.

Budaya keselamatan pasien merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan yang berfokus pada pengurangan risiko dan peningkatan keselamatan pasien. Dalam konteks perawatan, perawat memiliki peran kunci dalam membangun dan memelihara budaya keselamatan ini (Arbianti K et al., 2024). Budaya keselamatan pasien berkaitan dengan keyakinan, nilai, sikap, dan norma yang diterapkan oleh seluruh tenaga kesehatan dan staf organisasi, yang dapat memengaruhi tindakan dan perilaku. Budaya keselamatan pasien sangat penting di semua tingkatan unit dalam sistem pelayanan kesehatan, karena merupakan prinsip fundamental dalam layanan kesehatan. Implementasi keselamatan pasien di rumah sakit sesuai dengan sasaran dapat meningkatkan rasa aman pasien selama proses penanganan dan pelayanan (Ludin & Bajuri, 2020).

Dalam Panduan Nasional Keselamatan Pasien tahun 2006, keselamatan pasien merupakan hal utama yang diterapkan di rumah sakit karena berkaitan dengan kualitas, keselamatan dan reputasi rumah sakit. rumah sakit selalu meningkatkan mutu pada tiga elemen yaitu struktur, proses dan hasil dengan berbagai macam program regulasi yang berwenang misalnya penerapan standar pelayanan rumah sakit. Budaya keselamatan pasien merupakan budaya organisasi yang mendorong keselamatan pasien di rumah sakit yang melibatkan seluruh sumber daya manusia di dalamnya, seperti bidan, perawat, apoteker dan ahli gizi.

B. Budaya Keselamatan Pasien Terhadap Keselamatan Pasien

Budaya keselamatan Pasien adalah dasar utama dalam regulasi keselamatan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan oleh suatu institusi layanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko di setiap sektor layanan yang ada. Budaya keselamatan pasien dalam industri kesehatan dianggap sebagai inisiatif krusial untuk meningkatkan keselamatan pasien. Hal ini mencakup nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku yang dimiliki oleh individu maupun organisasi dalam layanan kesehatan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi pasien. Budaya ini menekankan pentingnya pencegahan, deteksi, dan penanganan kesalahan atau insiden untuk meningkatkan keselamatan pasien (Kartikasari BK et.al., 2023)

Budaya keselamatan pasien didefinisikan sebagai komitmen kolektif untuk melibatkan setiap individu atau kelompok dalam upaya menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang aman. Komitmen mencakup perhatian dan tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses perawatan pasien dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan pasien, dengan mempertimbangkan prinsip budaya keselamatan pasien untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan (Ekawardani N et al., 2022)

Sasaran keselamatan pasien memiliki enam poin meliputi identifikasi pasien benar, komunikasi efektif, keamanan terhadap obat yang harus diwaspadai, memastikan tempat pembedahan benar, prosedur benar dan pasien benar, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan dan mengurangi risiko pasien jatuh. Sasaran keselamatan pasien merupakan upaya untuk mencegah insiden yang dapat merugikan pasien maupun institusi kesehatan yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi risiko cedera, kesalahan, atau bahaya selama pemberian layanan kesehatan. Sasaran ini menjadi landasan bagi fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa praktik dan prosedur mereka mendukung keselamatan pasien secara optimal. Tujuan ini mencakup langkah-langkah krusial yang harus diimplementasikan oleh rumah sakit untuk mencegah

risiko keselamatan pasien dan melindungi kedua pihak dari kemungkinan kerugian (Larasati & Dharmanti, 2021).

Tepat dalam melaksanakan standar prosedur operasional dan kepatuhan dalam merawat pasien merupakan manifestasi penerapan sasaran keselamatan pasien yang menyediakan asuhan yang aman dan berkualitas. Dengan implementasi yang efektif dari sasaran keselamatan pasien, rumah sakit dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden yang membahayakan pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Implementasi sasaran ini melibatkan pelatihan tenaga kesehatan, pengembangan kebijakan, serta pemantauan berkelanjutan untuk meminimalkan risiko bagi pasien (Soru & Wahyuningsih, 2018).

Pada Agustus 2021, WHO menegaskan kembali dalam *Global Patient Safety Action Plan 2021-2030* memastikan keselamatan pasien merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, fasilitas kesehatan, hingga sektor swasta. Salah satu strategi yang digunakan dengan penguatan sistem pelaporan dan pembelajaran untuk insiden terkait keselamatan pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan harus mengatasi insiden untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Insiden yang terjadi harus dilaporkan secara internal kepada Tim Keselamatan Pasien dalam waktu 2x24 jam, serta secara eksternal kepada KNKP (Komisi Nasional Keselamatan Pasien) Kementerian Kesehatan RI.

Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien menganut prinsip No Naming, No Shaming, dan No Blaming yang menjadi data dasar untuk proses pembelajaran sehingga dapat mencegah terulangnya kesalahan yang pada akhirnya akan meningkatkan budaya keselamatan pasien (Mjadu TM, Jarvis MA, 2012). Penguatan budaya keselamatan pasien dalam fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan memahami dan melaksanakan peran dari setiap Pemberi Pelayanan Asuhan (PPA) seperti perawat, bidan, apoteker dan ahli gizi dengan baik, tepat dan berkelanjutan.

C. Peran Perawat Dalam Budaya Keselamatan Pasien

Perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling banyak berinteraksi langsung dengan pasien memiliki peran strategis dalam menerapkan budaya keselamatan pasien. Pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien berkorelasi kuat dengan budaya keselamatan pasien di rumah sakit, artinya semakin baik pengetahuan perawat, semakin kuat budaya keselamatan pasien di lingkungan kerja mereka (Victor M & Patria A, 2020).

Perawat merupakan **tenaga kesehatan yang paling banyak berinteraksi langsung dengan pasien**, sehingga secara praktis memiliki peran inti dalam

mencegah insiden yang mengancam keselamatan pasien. Peran ini mencakup deteksi dini risiko, pencegahan kesalahan, dan pelaksanaan praktik keperawatan yang aman sesuai dengan prinsip keselamatan pasien. Penerapan budaya keselamatan oleh perawat mencakup **komunikasi terbuka, pelaporan insiden, transfer informasi yang efektif saat pergantian shift (*handover*), serta kerja sama antar unit layanan**. Namun, penerapan budaya keselamatan di lapangan masih beragam dan perlu peningkatan berkelanjutan (Wiwin Nur Aeni et al., 2024).

Budaya keselamatan pasien sangat dipengaruhi oleh komunikasi efektif dan pelaporan insiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perawat sudah menerapkan komunikasi terbuka dan pelaporan insiden sebagai bagian dari budaya keselamatan, meskipun frekuensi dan kualitas pelaporan masih perlu ditingkatkan. Kerja tim dan kolaborasi antar unit juga merupakan aspek penting yang mendukung perawat dalam mengidentifikasi risiko dan mencegah kejadian tidak diinginkan (Wiwin Nur Aeni et al., 2024).

Selain itu, sikap perawat terhadap **budaya kerja yang adil (*just culture*)**—di mana kesalahan dilaporkan tanpa takut hukuman—mendorong peningkatan kepercayaan diri untuk melaporkan insiden dan belajar dari kesalahan. Ini tercermin dalam kajian literatur tentang persepsi perawat terhadap budaya adil dan pelaporan insiden keselamatan pasien (Raun S & Indriati K, 2024).

Pengetahuan dan kompetensi **perawat** tentang keselamatan pasien berperan penting dalam implementasi budaya keselamatan. Perawat yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang keselamatan cenderung lebih aktif dalam menerapkan praktik yang aman dan melaporkan insiden. **Pelatihan berbasis kasus dan seminar keselamatan pasien dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan perawat dalam menerapkan budaya keselamatan pasien** di tempat kerja (Fitri Annisa et al., 2025).

Beberapa faktor yang memengaruhi kemampuan perawat dalam mengimplementasikan budaya keselamatan pasien antara lain :

1. Kepemimpinan dan dukungan manajemen yang mendorong standar keselamatan yang tinggi.
2. Kompetensi klinis dan komunikasi efektif, yang membantu perawat mengambil keputusan cepat dan tepat saat menghadapi risiko klinis.
3. Lingkungan kerja yang mendukung pelaporan insiden tanpa rasa takut, sehingga perawat merasa aman untuk melaporkan kesalahan yang terjadi.

Analisis dari beberapa studi mengidentifikasi bahwa faktor seperti kepemimpinan, kompetensi, dan komunikasi efektif memiliki hubungan signifikan dengan penerapan budaya keselamatan pasien oleh perawat (Dewi Kuraesin et al., 2023).

Perawat secara rutin melakukan tugas-tugas yang kritis terhadap keselamatan pasien, seperti:

1. Identifikasi pasien yang akurat untuk mencegah kesalahan administrasi obat dan prosedur.
2. Pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan untuk mendeteksi tanda-tanda awal perburukan kondisi medis.
3. Pemberian asuhan keperawatan berbasis bukti yang membantu meminimalkan risiko infeksi, jatuh, atau komplikasi lainnya.

Peran ini merupakan bagian dari budaya keselamatan yang mengutamakan pendekatan sistematis untuk mengurangi risiko merugikan pasien (Alireza Hajizadeh et al., 2025).

Perawat juga berperan sebagai *agent of change* dalam membangun budaya keselamatan melalui:

1. Pendidikan pasien **tentang risiko perawatan dan hak mereka atas keselamatan.**
2. Pelatihan internal **untuk staf baru dan program peningkatan kompetensi berkala.**
3. Partisipasi dalam audit dan evaluasi **keselamatan pasien untuk menemukan area perbaikan.**

Program pendidikan, seperti seminar berbasis kasus tentang prosedur aman, dapat meningkatkan kesadaran keselamatan dan keterampilan perawat yang berdampak positif terhadap budaya keselamatan pasien secara keseluruhan (Fitri Annisa et al., 2025).

D. Peran Bidan dalam Budaya Keselamatan Pasien

Budaya keselamatan pasien (patient safety culture) adalah **kumpulan nilai, sikap, perilaku, dan praktik** yang dimiliki tenaga kesehatan dalam suatu organisasi untuk mencegah insiden yang merugikan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan. Di layanan kebidanan, budaya ini sangat penting karena area ini memiliki risiko tinggi terhadap kejadian yang berpotensi membahayakan ibu dan bayi jika prinsip keselamatan tidak diterapkan secara ketat (Nor Amal Hazirah Hassan et al., 2025).

Bidan bekerja pada unit layanan ibu dan anak yang rawan terhadap risiko keselamatan, seperti komplikasi persalinan. Budaya keselamatan di unit pre-post partum dan perinatologi sangat penting untuk mencegah kejadian merugikan pada ibu dan bayi. Penerapan budaya keselamatan di unit ini memerlukan **koordinasi yang kuat antar tim klinis, sistem pelaporan insiden, serta pelatihan yang berkelanjutan** agar risiko dapat dikelola dengan baik. Bidan bekerja secara

langsung dengan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Interaksi klinis yang intens ini menjadikan bidan sebagai salah satu **profesi yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pasien** :

1. **Pencegahan Kesalahan Klinis** : Selama persalinan dan perawatan postpartum, bidan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko klinis, melakukan penilaian yang tepat, dan mengambil tindakan cepat yang dapat mencegah kejadian merugikan (Isra Wati et al., 2024).
2. **Pengawasan Ketat terhadap Ibu dan Bayi** : Risiko seperti perdarahan pascapersalinan, distosia, atau komplikasi lainnya harus dikelola sejak dini melalui pendekatan yang aman dan berbasis bukti (Isra Wati et al., 2024).

Pelaporan kejadian keselamatan — termasuk near miss atau insiden kecil — merupakan elemen kunci dalam membangun budaya keselamatan. Ketika bidan aktif melaporkan kejadian ini tanpa takut akan sanksi, institusi bisa melakukan pembelajaran dan perbaikan yang sistemik. Laporan insiden ini juga menjadi dasar evaluasi risiko berulang dan peningkatan prosedur keselamatan. Budaya keselamatan pasien yang kuat bergantung pada komunikasi terbuka dan kolaboratif di antara tim kesehatan, termasuk bidan. Ini memastikan bahwa informasi penting tentang kondisi pasien ditransfer secara akurat antar shift atau antar disiplin ilmu — misalnya saat merujuk ke dokter, perawat, atau tim gizi. Komunikasi efektif juga membantu dalam pengambilan keputusan cepat yang bisa mengurangi risiko cedera pasien. Bidan harus terus **mengikuti** pelatihan klinis tentang keselamatan pasien, termasuk teknik resusitasi neonatal, penanganan perdarahan, serta praktik terbaik lain yang dibuktikan secara ilmiah. Pelatihan berkala membantu menjaga kompetensi klinis, sehingga bidan dapat merespon situasi kritis dengan benar dan aman (Nor Amal Hazirah Hassan et al., 2025).

Just culture adalah prinsip yang mendorong pelaporan kesalahan tanpa hukuman pribadi sehingga belajar dari kesalahan bisa lebih efektif. Bidan berperan penting dalam pembentukan iklim kerja just culture ini dengan mendukung keterbukaan dan pembelajaran dari setiap insiden keselamatan. Penelitian juga menunjukkan hubungan langsung antara budaya keselamatan pasien dan **kesalahan pemberian obat** maupun **hasil klinis perinatal**. Ketika budaya keselamatan kuat— termasuk pelaporan insiden dan pembelajaran tim — **insiden seperti kesalahan pemberian obat menurun**, dan **keamanan pasien meningkat**. Studi internasional juga menggarisbawahi bahwa perspektif bidan tentang keselamatan pasien sangat dipengaruhi oleh **elemen organisasi seperti leadership, komunikasi antarprofesi, pelatihan, serta beban kerja**. Ketidakhadiran salah satu elemen ini dapat menghambat implementasi budaya keselamatan secara efektif (Niken Dayu Anggraini et al., 2024).

E. Peran Apoteker dalam Budaya Keselamatan Pasien

Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan kunci dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Peran mereka tidak hanya terbatas pada penyediaan obat, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap **budaya keselamatan pasien** melalui **pengelolaan obat yang aman, edukasi pasien, kolaborasi interprofesional, dan pencegahan kesalahan medis** terkait penggunaan obat. Budaya keselamatan pasien sendiri dipahami sebagai persepsi dan perilaku organisasi serta individu dalam meminimalisasi risiko dan kesalahan dalam proses pelayanan kesehatan (Baiq Khuwailidia Kartikasari et al., 2023).

Peran apoteker paling dominan dalam budaya keselamatan pasien adalah mencegah kesalahan terkait penggunaan obat — salah satu insiden yang paling sering terjadi dan berdampak buruk pada pasien. Apoteker melakukan pemeriksaan resep, *medication reconciliation*, identifikasi *drug-related problems*, dan tindak lanjut intervensi yang memastikan pasien menerima obat yang tepat dengan dosis yang benar serta interaksi obat yang diminimalisir (Yash Gupta et al., 2023).

Apoteker berperan dalam edukasi pasien mengenai terapi obat, termasuk tujuan penggunaan, cara minum obat yang benar, efek samping yang mungkin terjadi, hingga pemantauan terapi. Edukasi ini penting untuk meningkatkan keterlibatan pasien dalam asuhan mereka sendiri dan meminimalkan risiko kesalahan penggunaan obat di luar lingkungan rumah sakit. Kegiatan ini selain meningkatkan pemahaman pasien, juga membantu mendeteksi masalah penggunaan terapi yang berpotensi membahayakan jika tidak ditangani (**Anna Legreid Dopp et al.**, 2020)

Apoteker **berkolaborasi secara langsung dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam** tim interprofesional untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif. Penelitian menunjukkan bahwa peran apoteker dalam *pharmacy services* dipandang sebagai aset penting dalam meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan, bahkan oleh profesional non-farmasi. Kolaborasi ini mencakup pemberian informasi obat kepada tenaga kesehatan lain, validasi terapi pasien, serta integrasi apoteker dalam rapat klinis dan diskusi perawatan pasien yang kompleks (Kyung Min Kirsten Lee et al., 2023)

Budaya keselamatan pasien yang kuat **mempromosikan** pelaporan kesalahan **dan near miss** sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Apoteker memainkan peran penting dalam melaporkan kejadian yang berhubungan dengan obat serta memberikan analisis awal terkait faktor penyebab kejadian tersebut. Lingkungan keselamatan yang **menjunjung no-blame culture** mendorong apoteker untuk terbuka dalam melaporkan kesalahan, sehingga

organisasi dapat menyesuaikan kebijakan atau prosedur pengobatan untuk mencegah kejadian berulang (**Anna Legreid Dopp et al.**, 2020).

Studi terbaru menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien di instalasi farmasi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan yang mengutamakan keselamatan, **komunikasi terbuka, dan sistem organisasi yang mendukung pelaporan serta perbaikan proses**. Kepemimpinan menjadi faktor fundamental dalam memfasilitasi sikap proaktif apoteker dalam kegiatan keselamatan pasien. Fasilitasi ini mencakup *feedback* terhadap laporan kesalahan, pengembangan rekomendasi perbaikan, serta pembinaan terhadap staf kefarmasian agar mampu menjalankan praktik yang aman dan konsisten (Biset Asrade Mekonnen et al., 2025)

Beberapa penelitian empiris menilai persepsi apoteker terhadap budaya keselamatan pasien menggunakan instrumen seperti *Pharmacy Survey on Patient Safety Culture*. Hasilnya menunjukkan adanya tantangan dalam beberapa dimensi seperti beban kerja (*work pressure*) dan staffing, tetapi juga menekankan pentingnya kerja sama tim dalam promosi keselamatan pasien. Temuan ini menegaskan bahwa peran apoteker tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural – yaitu ikut **membangun persepsi bersama** tentang pentingnya keselamatan pasien dalam setiap proses pelayanan kefarmasian (Al-Surimi, Khaled PhD et al., 2021)

F. Peran Ahli Gizi dalam Budaya Keselamatan Pasien

Ahli gizi mendukung budaya keselamatan pasien melalui keterlibatan dalam praktik pelayanan makanan di rumah sakit, termasuk **penerapan prosedur** identifikasi pasien untuk memastikan bahwa makanan yang disiapkan dan diberikan sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari pasien yang benar. Kesalahan distribusi makanan dapat dicegah melalui penerapan budaya keselamatan pasien yang baik dan keterlibatan aktif ahli gizi dalam pengawasan pelayanan makanan. (Palupi IR et al., 2022).

Penerapan pedoman klinis yang baku (mis. protokol nutrisi enteral dan parenteral) oleh ahli gizi atau *registered dietitians* mendukung praktik keselamatan pasien dengan mengurangi variasi dalam pelayanan gizi dan meningkatkan standar keselamatan perawatan. Studi observasional di rumah sakit Saudi menunjukkan bahwa dietitian yang mematuhi *nutrition support guidelines* membantu meminimalkan kesalahan nutrisi dan memperbaiki hasil klinis pasien (Sara Zaher, 2025).

Ahli gizi, bersama dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat dan dokter, berperan dalam pengembangan **rencana perawatan yang aman dan terpadu**. Mereka menyediakan **penilaian status gizi** yang sistematis dan rekomendasi

intervensi yang berbasis bukti (*Medical Nutrition Therapy/MNT*), yang penting untuk mencegah komplikasi gizi dan mempertahankan keselamatan pasien secara keseluruhan. Peran ahli gizi profesional sebagai yang paling berkompeten dalam memberikan terapi nutrisi medis dan berkontribusi dalam sistem perawatan berbasis bukti (Eliza Short PhD et al., 2025).

Ahli gizi yang memimpin **perencanaan nutrisi** individual, seperti dalam ICU, terbukti memberikan **dukungan nutrisi awal yang aman dan efektif** bagi pasien kritis, yang dapat mengurangi komplikasi klinis, mempercepat pemulihan, dan memperbaiki hasil keseluruhan pasien (*Mamoru Hayashi et al., 2024*).

G. Faktor-Faktor yang Mendukung Budaya Keselamatan Pasien

Beberapa faktor yang menentukan dalam mendukung penguatan budaya keselamatan pasien pada perawat, bidan, apoteker dan ahli gizi di antaranya adalah :

1. Kepemimpinan yang Kuat & Komitmen Manajemen

Dukungan dari pimpinan rumah sakit dan kepala unit adalah fondasi penting untuk memperkuat budaya keselamatan pasien. Manajemen harus mendorong lingkungan kerja yang aman dan terbuka untuk melaporkan insiden tanpa takut dihukum.

2. Komunikasi Terbuka dan Tim yang Solid

Komunikasi yang efektif antara semua profesi kesehatan—termasuk perawat, bidan, apoteker, dan ahli gizi—adalah kunci untuk mengidentifikasi risiko potensial dan mengimplementasikan tindakan pencegahan.

3. Pelatihan & Pendidikan Berkelanjutan

Pelatihan tentang keselamatan pasien dan praktik terbaiknya sangat penting untuk meningkatkan kompetensi staf. Ini termasuk pelatihan pelaporan insiden dan kemampuan merespon risiko klinis secara efektif.

4. Pelaporan Insiden Tanpa Hukuman (*No Blame Culture*)

Budaya yang mendorong pelaporan kejadian tanpa memberikan efek hukuman kepada pelapor akan meningkatkan keterbukaan dan pembelajaran dari setiap insiden. Ini penting untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

H. Simpulan

Budaya keselamatan pasien merupakan pondasi penting bagi mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk meraih budaya keselamatan pasien yang kuat dan berkelanjutan, maka perawat, bidan, apoteker, dan ahli gizi harus memahami dan melaksanakan perannya masing-masing dengan baik, tepat dan berkelanjutan, serta bekerja dalam satu sistem yang mendukung pelaporan yang

terbuka, komunikasi efektif, pelatihan yang terstruktur, dan kepemimpinan yang kuat. Penguatan budaya keselamatan pasien bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga institusi yang menyediakan dukungan sistemik dan sumber daya yang memadai.

Referensi

- Alireza Hajizadeh, Behrouz Amini Kordkandi, Sevda Sadeghpour, Milad Khodayandi, Jalal Saedpour & Edris Kakemam. Nurses' perception of patient safety culture using the Hospital Survey on Patient Safety Culture tool and its association with nursing-patient: a systematic review in Iranian hospitals. BMC Nursing. Volume 24, article number 774, 2025. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12912-025-03305-4>
- Al-Surimi, Khaled PhD, Alwabel, Ali Mohammed MSc, Bawazir, Amen PhD and Shaheen, Naila A. MD. Editor(s): Schaller., Bernhard. Road towards promoting patient safety practices among hospital pharmacists. Hospital-based baseline patient safety culture assessment cross-sectional survey. Medicine-journal, 2021. Available from : https://journals.lww.com/mdjournal/fulltext/2021/01150/road_towards_promoting_patient_safety_practices.5.aspx
- Anna Legreid Dopp, Pharm. D, Kendall K. Hall, MD, MS and Eleanor Fitall, MPH. Pharmacist Role in Patient Safety. Patient Safety Networ (PASNet), 2020. Available from : <https://psnet.ahrq.gov/perspective/pharmacist-role-patient-safety>
- Arbianti K, et al. Patient Safety Culture Analysis at Sultan Agung Islamic Dental Hospital to Improve Patient Safety. JMMR (J Medicoetico Manaj Rumah Sakit). 2024;13(1):24–42. Available from: <https://doi.org/10.18196/jmmr.v13i1.65>.
- Azyabi A, Karwowski W, Davahli MR. Assessing Patient Safety Culture in Hospital Settings. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(5):2466. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052466>.
- Baiq Khuwailidia Kartikasari, Samirah Samirah, Elida Zairina, S.Si., MPH., Ph.D., Apt. The Assessment of Patient Safety Culture Among Doctors, Nurses, and Pharmacists in a Public Hospital in Indonesia. Journal of Management and PharmacyPratice. Vol 13. No.2, 2023. Available from: <https://doi.org/10.22146/jmpf.83575>
- Biset Asrade Mekonnen, Samrawit Girma, Samuel Telay & Dagninet Derebe Abie. Patient safety culture and associated factors among pharmacy professionals working in Bahir Dar City public hospitals using a pharmacy survey on patient safety culture (PSOPSC). BMC Health Services Research. Volume 25, article number 1191, 2025. Available from : <https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-025-13396-z>
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 2006.

- Dewi Kuraesin, Rina Mutiara dan Rokiah Kusumapradja Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan Budaya Keselamatan Pasien pada Perawat. *Journal Health Sains*. Vol. 5. No. 5, 2023. Available from : <https://doi.org/10.46799/jhs.v4i5.899>
- Ekawardani N, Manampiring AE, Kristanto. Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Persepsi Tenaga Kesehatan Terhadap Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Med Scope J*. 2022;4(1):79–88. Available from: <https://doi.org/10.35790/msj.v4.i1.44770>.
- Eliza Short PhD, Lisa Akers PhD, Emily A. Callahan MPH, Cara Cliburn Allen PhD, Mayra CrespoBellido PhD, Kirsten Deuman MPH, Emily Dimond MPH, Chelsea Hollowell MS, Miguel Ángel López PhD, MPH, [Elizabeth Anderson Steeves PhD](#). The Role of Registered Dietitian Nutritionists within Food Is Medicine. *Journal of Nutrition & Health Impact*, 2025. Available from : <https://doi.org/10.1016/j.jand.2025.03.004>
- Fitri Annisa, Merri Silaban, Tiffatul Jannah Firdausya, Ayu My Lestari Saragih dan Asha Grace Sicilia Peningkatan Kompetensi Perawat terhadap Budaya Keselamatan Pasien melalui Seminar Berbasis Kasus untuk Perawat Di RS Medika Lestari. *Community Service Article*. Vol.2 No. 2, November 2025. Available from : <https://doi.org/10.65344/comers.v2i2.135>
- Hessel A, Paliwal M, Weaver SH, Siddiqui S, Wurmser TA. Impact of Patient Safety Culture on Missed Nursing Care and Adverse Patient Events. *J Nurs Care Qual*. 2019; 34(4): 287–294. doi:10.1097/NCQ.0000000000000378. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3250>
- Isra Wati, Suhartati, Devin dan Arbiyah. Peran Bidan Dalam Mendukung Persalinan Aman dan Nyaman. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* Vol. 4 No. 3. Agustus - October 2025. Available from :
- Kartikasari BK, Samirah, Zairina E. The Assessment Of Patient Safety Culture Among Doctors, Nurses And Pharmacists In A Public Hospital In Indonesia. *J Manaj Pelayanan Farmasi*. 2023;13(2):104-105. Available from: <https://doi.org/10.22146/jmpf.83575>.
- [Kyung Min Kirsten Lee](#), [Amy Page](#), [Sangseo Kim](#), [Tarik Al-Diery](#), [Ivanka Koeper](#), [Isabella Singh](#), [Deborah Hawthorne](#) and [Jacinta Johnson](#). Perceptions and expectations of health professionals regarding hospital pharmacy services and the roles of hospital pharmacists: A qualitative systematic review and meta-synthesis. *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*. Volume 10, June 2023. Available from : <https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2023.100264>
- Larasati A, Dharmanti I. Studi Literatur: Implementasi Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit di Indonesia. *J Media Gizi Kemas*. 2021;10(1):138-148.

- Ludin SM, Bajuri NAA. Nurses Perception on Patient Safety Culture in Critical Care Area at a Tertiary Hospital In Pahang Malaysia. *Malays J Nurs*. 2020;11(4):78–84. Available from: <https://doi.org/10.31674/mjn.2020.v11i04.008>.
- Mamoru Hayashi, Yuki Nishikido, Hiroyuki Banno, Tsuzuki Michitaka, Eiko Tachibana & Takayoshi Tsukahara. Effectiveness of Registered Dietitian-led Management of Early Nutritional Support in the Emergency ICU. *BMC Nutrition*. Volume 10, article number 96, 2024. Available from : <https://link.springer.com/article/10.1186/s40795-024-00904-3>tiveness of registered dietitian-led management of early nutritional support in the emergency intensive care unit: a retrospective observational study
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mjadu TM, Jarvis MA. Patients' safety in adult ICUs: Registered nurses' attitudes to critical incident reporting. *Int J Afr Nurs Sci*. 2018 Jan 1;9:81–6.
- Niken Dayu Anggraini, Fridawaty Rivai, Syahrir A. Pasinringi, Indahwaty Sidin, Herlina Hamzah, Khalid Saleh. Influence of Patient Safety Culture on Medication Administration Error among Nurses and Midwives at Restu Ibu Hospital in Balikpapan, Indonesia. *Pak. j. life soc. Sci (Pakistan Journal of Life and Social Sciences)*, 2024. Available from: https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/15404-15415.pdf
- Nor Amal Hazirah Hassan, Hanif Abdul Rahman, Joe Knights, Sarena Hashim, Sharimawati Sharbini and Khadizah A. Abdul Mumin. Cultivating patient safety culture in midwifery practices through incident reporting. Publication: [British Journal of Midwifery Volume 32, Number 7](https://doi.org/10.12968/bjom.2024.32.7.388), June 2024. Available from : <https://doi.org/10.12968/bjom.2024.32.7.388>
- Palupi IR, Prawiningdyah Y, Setyawening A, Amalia L. Perception of Hospital Food Service Workers Regarding Patient Safety Culture and Patient Identification Practice. *J Medicoet Legal & Manajemen Rumah Sakit (JMMR)* Vol 11 No. 3, 2022. Available from : <https://doi.org/10.18196/jmmr.v11i3.14595>
- Raun Sinaga, Indriati Kusumaningsih. Nurse Perceptions Regarding Just Culture Using Leininger's Perspective In Incident Reporting: Literature Review. *The Indonesian Journal of Health Promotion*. MPPKI Vol. 7 No. 5, Mei 2024. Available from : <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i5.5067>
- [Sara Zaher](#), [Alhanouf Sameer Alhussaini](#), [Raneem Zuhair Abdulghani](#), [Refal Eihab Azzouni](#), [Seba Khalid Aalouh](#), [Shahd Majed Alharbi](#) and [Sondos Albukhari](#). Evaluation of Dietitians' Adherence to Nutrition Support Guidelines in Saudi Hospitals. *PubMed Central Frontiers in Nutrition*, 2025. Available from: doi [10.3389/fnut.2025.1675530](https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1675530)

- Soru A, Wahyuningsih A. Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien. J STIKES RS Baptis Kediri. 2018;2(11):89-160.
- Victor Melius, Patria Asda. Hubungan Pengetahuan Perawat Dengan Budaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Mitra Paramedika Sleman Yogyakarta. Immanuel Jurnal Ilmu Kesehatan Volume 14 Nomor 1, Juni 2020. Available from : <https://jiki.immanuel.ac.id/index.php/JIKI/article/view/110/pdf>.
- WHO. Global Patient Safety Action Plan 2021-2030: Towards eliminating avoidable harm in health care. 2021.
- Wiwin Nur Aeni, Bestina Nindy Virgian, Neneng Wijayanti. Penerapan Budaya Keselamatan Pasien oleh Perawat di Rumah Sakit. Journal of Vocational Health Science Vol. 3 No. 1 (2024). Available from : <https://jovas.polindra.ac.id/index.php/jovas/article/view/38/19>
- Yash Gupta, Neeraj Kumar, Amrita Shukla and Vishal Rai. Assessment of the Role of Pharmacists in Preventing Medication Errors in Hospital Settings. Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology. Vol 2. No 2, 2023. Available from : <https://doi.org/10.55544/jrasb.2.2.30>

PROFIL PENULIS



Badriah, SST, MPH. Lahir di Majalengka, 15 Juni 1962. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gajah Mada dan lulus pada tahun 2008. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1984 menjadi pelaksana Perawatan mulai tahun 1986 menjadi guru perawat pada tahun 1996 sampai dengan sekarang sebagai dosen pada Program Studi D3 Keperawatan Cirebon dan menjadi Pengampu pada Mata Kuliah: Keperawatan Maternitas, manajemen

Patient Safety, Etika Keperawatan, KMKK. Saat ini penulis bekerja di Poltekas Kemenkes Tasikmalaya Program Studi D3 Keperawatan Cirebon. Penulis aktif dalam mengikuti kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Similitabkes. Penulis dapat dihubungi melalui email: badriahbaran@gmail.com. Achmd.

Motto: Life is a journey, not a destination. (Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir.)



Sarwoko, S.Ag, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep. Lahir di Sragen, 21 Maret 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Aqidah Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997, Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Sahid Surakarta Tahun 2014 dan 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Kedokteran Keluarga, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009 dan Magister Keperawatan, Universitas Karya Husada Semarang tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 sebagai tenaga

kependidikan, 2004 sebagai kepala Tata Usaha, 2006-2015 sebagai Wakil Direktur pada Akademi Kebidanan Estu Utomo. 2015-2021 sebagai Wakil Ketua, 2021-2025 dan 2025-sekarang sebagai Ketua STIKES Estu Utomo. Saat ini penulis bekerja di STIKES Estu Utomo Program Studi Keperawatan Program Sarjana mengampu mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Proses Keperawatan dan Berfikir Kritis, Ketrampilan Dasar Keperawatan, Biomedik dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan konsultan Pendidikan Kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sanuria21@gmail.com

Motto: "Serious, Learn and Sincere"

PROFIL PENULIS



Nima Eka Nur Rahmania, S.KM., M.KKK. Lahir di Tulungagung, 13 Juli 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu berawal dari jenjang D3 pada Prodi Hyperkes UNAIR tahun 2006 kemudian melanjutkan ke jenjang S1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Universitas Airlangga pada tahun 2009. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada 2012 sebagai staff *Environment, Health and Safety* (EHS) di perusahaan manufacture swasta Jepang yang bergerak di bidang *food and baverage*. Selain itu penulis juga merupakan konsultan di bidang sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan di beberapa perusahaan. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia sebagai dosen dan menjabat sebagai Kaprodi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penulis mengampu di berbagai mata kuliah K3 khususnya di bidang Hygiene Industri. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dari hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat. Penulis juga berkontribusi sebagai pembicara dalam agenda seminar baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Hingga saat ini penulis juga aktif tergabung kedalam berbagai organisasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti keanggotaan pada Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ring 1 Jawa Timur serta sebagai sekretaris pada Komunitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (KAK3RS) Pengda Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nimaeka@gmail.com

PROFIL PENULIS



Patria Asda, S.Kep, Ns., M.P.H. lahir di Balikpapan-Kalimantan timur pada 27 Maret 1982, merupakan lulusan S1 dan profesi Ners dari prodi ilmu keperawatan universitas gadjah mada tahun 2007, Serta Master Of Public Health dari Magister Ilmu Kesehatan masyarakat FK-KMK Universitas Gadjah mada pada tahun 2009. Saat ini penulis merupakan dosen program studi Keperawatan (S1) dan Pendidikan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta. Mata Kuliah yang diampu antara lain Manajemen Keperawatan, Ilmu Dasar Keperawatan, keperawatan Gerontik, dan keperawatan Keluarga (KKG). Penulis aktif dalam penyusunan modul praktikum, telah menerbitkan beberapa buku ajar dan buku referensi. Penulis aktif pula dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta telah menghasilkan berbagai publikasi di jurnal nasional dan jurnal terakreditasi. Alamat korespondensi/ e-mail: asdapaty@gmail.com



Nama Lengkap dan Gelar Ketua Penulis Lahir di Bekasi 28 Oktober 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan Akper RSPAD Gatot Soebroto 1991, S1 + Ners FIK UI 2003 dan Magister Manajemen Keperawatan FIK UI 2011. Pernah bekerja sebagai Perawat Pelaksana di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 1992 – 1995 dan sejak 1995 bergabung di Akper Bani Saleh yang saat menjadi Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh Universitas Bani Saleh. Dalam berorganisasi pernah menjadi pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan, yaitu AIPVIKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Vocasi Indonesia) Pusat di tahun 2015 – 2019 dan Pengurus AIPVIKI Regional Jawa Barat tahun 2024 – 2028. Penulis juga Aktif pada Organisasi Profesi DPD PPNI Kota Bekasi sejak tahun 2015 sampai saat ini. Penulis menjadi dosen pengampu Mata Kuliah Keperawatan Dasar, Manajemen Keperawatan dan Keperawatan Luka. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai narasumber, penulis modul / buku, publikasi, seminar dan pengabdian masyarakat. serta menjadi anggota aktif dalam NCI (Nursing Centre Indonesia), RLI (Rawat Luka Indonesia), Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asih@ubs.ac.id

PROFIL PENULIS



dr. Yahmin Setiawan, MARS. Lahir di Jakarta, 03 Desember 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia program studi Kajian Administrasi Rumah Sakit (KARS) dan lulus tahun pada tahun 2010. Riwayat pekerjaan sebagai praktisi manajemen rumah sakit sejak tahun 2012 sampai sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Bangsa Kota Serang pada Fakultas Ilmu Kesehatan program Studi Administrasi Rumah Sakit sejak tahun 2022. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yahmin76@gmail.com
Motto: "Selalu berfastabiqul khoirot"

Sinopsis

Bunga rampai *Keamanan Pasien dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Perspektif Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi* menghadirkan gambaran komprehensif tentang bagaimana keselamatan pasien dibangun melalui standar, sistem, dan kolaborasi lintas profesi di fasilitas pelayanan kesehatan. Buku ini mengawali pembahasan dengan pemetaan **standar keselamatan pasien**, sasaran keselamatan pasien, serta penjabaran **enam sasaran keselamatan pasien** sebagai rambu praktis yang dapat diterapkan dalam tata kelola layanan sehari-hari. Melalui fondasi ini, pembaca diajak memahami bahwa keselamatan pasien adalah kerja sistematis yang menuntut konsistensi prosedur, ketepatan proses, dan orientasi pada pencegahan risiko.

Pada bagian berikutnya, buku menyoroti peran sentral **perawat** dalam penguatan mutu melalui **Quality Improvement (QI)** dan **Patient Safety Incident Reporting (PSIR)**. Uraian tidak hanya membahas konsep dasar dan hubungan QI dengan patient safety, tetapi juga menampilkan peran perawat dalam pelaporan insiden, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan, strategi peningkatan, dukungan manajemen keperawatan, hingga contoh praktik baik dan studi kasus. Selanjutnya, buku memperdalam aspek pengendalian risiko klinis-lingkungan melalui pembahasan **infeksi nosokomial**—mulai dari karakteristik, epidemiologi, rantai penularan, faktor risiko, hingga **sanitasi lingkungan** serta peran SDM, monitoring, dan audit PPI sebagai kunci pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan.

Sebagai penguat implementasi di lapangan, buku ini juga mengulas elemen yang menentukan efektivitas tim layanan: **komunikasi interprofesi**. Pembaca dikenalkan pada teknik **SBAR** dan pendekatan **TeamSTEPPS** untuk meningkatkan kolaborasi dan mengurangi kesalahan komunikasi yang berpotensi menimbulkan insiden. Tidak kalah penting, buku membahas dimensi **etika, legalitas, dan informed consent** dalam pelayanan kesehatan modern, agar praktik keselamatan pasien tetap sejalan dengan hak pasien dan ketentuan hukum. Pada penutup, buku menegaskan pentingnya **budaya keselamatan pasien** dengan menguraikan peran perawat, bidan, apoteker, dan ahli gizi serta faktor-faktor pendukungnya—menjadikan bunga rampai ini relevan sebagai referensi akademik sekaligus panduan praktis bagi tenaga kesehatan dan pengelola layanan.

Bunga rampai Keamanan Pasien dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Perspektif Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi menghadirkan gambaran komprehensif tentang bagaimana keselamatan pasien dibangun melalui standar, sistem, dan kolaborasi lintas profesi di fasilitas pelayanan kesehatan. Buku ini mengawali pembahasan dengan pemetaan standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, serta penjabaran enam sasaran keselamatan pasien sebagai rambu praktis yang dapat diterapkan dalam tata kelola layanan sehari-hari. Melalui fondasi ini, pembaca diajak memahami bahwa keselamatan pasien adalah kerja sistematis yang menuntut konsistensi prosedur, ketepatan proses, dan orientasi pada pencegahan risiko.

Pada bagian berikutnya, buku menyoroti peran sentral perawat dalam penguatan mutu melalui Quality Improvement (QI) dan Patient Safety Incident Reporting (PSIR). Uraian tidak hanya membahas konsep dasar dan hubungan QI dengan patient safety, tetapi juga menampilkan peran perawat dalam pelaporan insiden, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan, strategi peningkatan, dukungan manajemen keperawatan, hingga contoh praktik baik dan studi kasus. Selanjutnya, buku memperdalam aspek pengendalian risiko klinis-lingkungan melalui pembahasan infeksi nosokomial—mulai dari karakteristik, epidemiologi, rantai penularan, faktor risiko, hingga sanitasi lingkungan serta peran SDM, monitoring, dan audit PPI sebagai kunci pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan.

Sebagai penguat implementasi di lapangan, buku ini juga mengulas elemen yang menentukan efektivitas tim layanan: komunikasi interprofesi. Pembaca dikenalkan pada teknik SBAR dan pendekatan TeamSTEPPS untuk meningkatkan kolaborasi dan mengurangi kesalahan komunikasi yang berpotensi menimbulkan insiden. Tidak kalah penting, buku membahas dimensi etika, legalitas, dan informed consent dalam pelayanan kesehatan modern, agar praktik keselamatan pasien tetap sejalan dengan hak pasien dan ketentuan hukum. Pada penutup, buku menegaskan pentingnya budaya keselamatan pasien dengan menguraikan peran perawat, bidan, apoteker, dan ahli gizi serta faktor-faktor pendukungnya—menjadikan bunga rampai ini relevan sebagai referensi akademik sekaligus panduan praktis bagi tenaga kesehatan dan pengelola layanan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7556-41-7



Optimal
Untuk
Negeri

